ESTUDIOS SOBRE LA IDEA DE MUERTE Y LOS SUICIDIOS

DE LAS PSICOLOGÍAS AL PSICOANÁLISIS



María Cristina Ortega Martínez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

Estudios sobre la idea de muerte y los suicidios

De las psicologías al psicoanálisis

EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

COMITÉ EDITORIAL EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
ÁREA HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Dra. Mónica Hernández Islas
Universidad de Guadalajara

Dr. Miguel Lizcano Sánchez
Universidad de Guadalajara

Dra. María Guadalupe Huerta Morales
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Dra. Laura Beatriz Vidal Turrubiates
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Cada libro de la Colección Ciencia e Investigación es evaluado para su publicación mediante el sistema de dictaminación de pares externos y autentificación antiplagio. El proceso de dictaminación y su trazabilidad puede consultarse, así como el libro en Acceso Abierto.

comunicacion-cientifica.com

DOI.ORG/10.52501/cc.457



COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
PUBLICACIONES ARBITRADAS
HUMANIDADES, SOCIALES Y CIENCIAS

CC+I
COLECCIÓN CIENCIA e INVESTIGACIÓN

Estudios sobre la idea de muerte y los suicidios

De las psicologías al psicoanálisis

María Cristina Ortega Martínez

EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Ortega Martínez, María Cristina,

Estudios sobre la idea de muerte y los suicidios : De las psicologías al psicoanálisis / María Cristina Ortega Martínez. — Ciudad de México : Comunicación Científica, 2026. (Colección Ciencia e Investigación).

177 páginas ; 23 × 16.5 centímetros

ISBN: 978-968-9803-33-1

DOI: 10.52501/cc.457

1. Suicidio — Prevención. 2. Suicidio — Aspectos psicológicos. 3. Suicidio — Psicoanálisis

LC: HV6545 O78 Dewey: 362.28 O78

La titularidad de los derechos patrimoniales y morales de esta obra pertenece a la autora D. R. © María Cristina Ortega Martínez, 2026. Reservados todos los derechos conforme a la Ley. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es

Primera edición en Ediciones Comunicación Científica, 2026

Diseño de portada: Francisco Zeledón • Interiores: Guillermo Huerta

Ediciones Comunicación Científica, S. A. de C. V., 2026,
Av. Insurgentes Sur 1602, piso 4, suite 400,
Crédito Constructor, Benito Juárez, 03940, Ciudad de México,
Tel.: (52) 55-5696-6541 • Móvil: (52) 55-4516-2170
info@comunicacion-cientifica.com • www.comunicacion-cientifica.com
comunicacioncientificapublicaciones @ ComunidadCient2

ISBN 978-968-9803-33-1

DOI 10.52501/cc.457





Esta obra fue dictaminada mediante el sistema de pares ciegos externos.
La trazabilidad de la dictaminación puede consultarse, así como el libro en acceso abierto, en https://doi.org/10.52501/cc.457

Índice

Dedicatoria 9
Agradecimientos 11
Resumen 13
Prólogo, Francisco Landa Reyes 15
Introducción 19

1. La historia 33

2. Propuestas de prevención y tratamiento 63

3. Suicidio asistido 71

4. Algunas nociones teóricas del Psicoanálisis 79

5. Psicoanálisis y suicidio 127

6. ¿Cuál es la tarea del Psicoanálisis frente al suicidio? 153

Para terminar 167
Referencias 171
Sobre la autora 177

Dedicatoria

A mi madre. Aun ahora en su ausencia física, no deja de guiarme, de acompañarme y de provocar un sinfín de preguntas por el deseo, lo que me tiene aquí.

A mi padre, a mis hermanos Víctor y Martha.

Al amor más fuerte de mi vida, Luis Jerónimo.

A todas las personas que me han permitido escucharlas. También a los que, en algún momento de sus vidas, se hayan preguntado por su existencia, deseando que puedan encontrar respuestas en compañía de personas sabias y compasivas.

Agradecimientos

A la Universidad Autónoma de Querétaro, a la Facultad de Psicología y Educación, por el apoyo para la publicación de este texto.

A Ariel, por sus observaciones y por la permanencia en estos últimos tiempos del proceso de escritura.

A Francisco Landa, por prologar de una manera tan amable y puntual este libro.

A Alfredo Eidelsztein, por la dirección clarificadora del principio de este escrito.

A todos mis maestros, no solo los que de manera formal lo han sido, sino a los que me han acompañado mostrándome los caminos posibles y los adecuados: Jaime, Teté, Kelsang Wangchog, Claudio, Bere.

A los guardianes que he encontrado en diferentes momentos de mi vida y en diferentes espacios, a los de siempre, a los de ahora.

A todos y cada uno de mis estudiantes, que han sido también mis maestros durante estos treinta años para poder nombrarme su profesora.

Resumen

El fenómeno del suicidio siempre ha generado un sinfín de cuestionamientos sobre las causas y las formas de prevenirlo. Este texto recoge algunas aproximaciones a la idea de muerte, que ha ido modificándose en la historia de la humanidad, así como las consideraciones respecto al suicidio, pasando de ser, de acuerdo con la época, un pecado, desde la religión; un delito o un hecho social, hasta un problema de salud mental derivado de algún trastorno. También abordo el dilema que representa el respeto a la decisión por la propia muerte, acercando también el tema de la prevención y, sobre todo, del tratamiento para el que padece de ideación suicida o ya tuvo intentos fallidos, desde propuestas terapéuticas que brindan algunas psicologías. Partiendo de la idea de que habrá algunos suicidios que se pueden prevenir y otros que no, como lo muestra la estadística, sugiero la posibilidad de pensar el suicidio desde un enfoque psicoanalítico, para que el lector tome en cuenta si este le ofrece una alternativa útil para el abordaje. Sirvan estas palabras para entender que la cuestión del suicido, de la propia muerte, no es exclusivo de la locura o algún trastorno mental; es común en tanto somos sujetos atravesados por la finitud/intuición de infinitud. Finalmente, a partir de lo mucho que le pueda faltar a este texto, insto a indagar y estudiar sobre lo que nos corresponde hacer ante la petición de escucha del sufrimiento y del deseo de otra cosa y no esta vida que duele.

Palabras clave: *suicidio, ideación suicida, prevención de suicidio, psicoanálisis.*

comunicacion-cientifica.com

Prólogo

Cuando en los años noventa tuve por primera vez contacto con colegas brasileños, me sorprendió que en su presentación colocaban juntas ambas denominaciones: "Fulan@, psicólog@ y psicoanalista". Hacer eso era casi impensable en México a fines del siglo pasado, donde ambas identidades se pensaban incompatibles —sobre todo desde los espacios psicoanalíticos—: o eras una cosa o la otra, había que elegir. Hoy, al primer cuarto del siglo XXI, para muchos aún es así. Desde esa postura, se diría, o se escribe un libro psicológico o uno psicoanalítico. Sin embargo, otros muchos clínicos y teóricos, entre ellos la autora de este libro y quien lo prologa, hemos tomado, por decirlo así, la vía *brasileira*. El libro que tienes en tus manos da cuenta de ello.

Cristina Ortega, psicóloga y psicoanalista, académica universitaria, atendiendo a su formación profesional de origen, a su formación clínica y teórica en psicoanálisis, así como a su propio estilo atento a lo histórico-cultural, se aproxima al complejo tema del suicidio en dos bloques que marcan complementariedad y diferencia: un conjunto de capítulos para aproximaciones diversas, y otro que profundiza en el abordaje psicoanalítico.

Este diseño no solo responde a una elección identitaria o de estilo. Es notorio también un compromiso pedagógico, un deseo de ofrecer a quien desea aproximarse al tema un panorama completo de las aportaciones más importantes en diversos espacios de reflexión y acción frente al fenómeno suicida.

En los primeros capítulos, Cristina presenta y discute todo aquello que en la mirada social predominante ocupa y preocupa: la ocurrencia repetida

del suicidio como un asunto moral, ético, y epidemiológico de salud pública. Para abordar estas dimensiones recurre de forma relevante a la revisión histórica, antropológica y filosófica. En pocos trazos nos conduce a la reflexión sobre la responsabilidad colectiva por los actos suicidas y a la significación del quitarse la vida para diversas cosmovisiones, aterrizando por último en la tremendamente actual discusión sobre el suicidio asistido y la eutanasia.

Casi al final del primer bloque de capítulos, la autora se enfoca en la revisión de fuentes psicológicas. Parece plantearse con nosotros una pregunta: ¿Qué tiene la psicología para aportar frente al fenómeno suicida? La brevedad del apartado dedicado a esta exploración corresponde con lo que la realidad de esta disciplina nos presenta. Las aportaciones psicológicas, retomadas por el *mainstream* institucional mundial, pueden resumirse en una secuencia relativamente simple: prevenir-detectar-desactivar el suicidio.

Hablando como psicólogos de formación, es inevitable reconocer que en este triple campo se juega una dimensión de suma importancia, debido a que las diversas corrientes psicológicas, en sus vertientes clínicas y educativas, cumplen un papel social fundamental siendo que las instituciones nacionales de salud pública, en concierto con la Organización Mundial de la Salud, instrumentan esquemas provenientes de estas, esquemas cuya pertinencia es indiscutible para sensibilizar a las familias, escuelas y sociedad en su conjunto. Desde el trabajo de nuestras colegas psicólogas en hospitales, escuelas, empresas y consultorios privados, se realiza un tenaz trabajo de psicoeducación, identificación y atenuación de factores de riesgo, así como de intervenciones terapéuticas que permiten a quienes son potencialmente suicidas ser aproximados por agentes de cuidado. En ese sentido, es muy valioso que las psicólogas clínicas cuenten con protocolos de atención acordes y adaptables a los recursos y capacidades institucionales. Los dispositivos cognitivo-conductuales dirigidos a desactivar riesgo suicida son más que adecuados en esos entornos.

Como les decía al inicio, podemos estar en condiciones de asumirnos como psicólogos y psicoanalistas, ambas cosas. Esa admisión implica apertura para reconocer las virtudes de cada lado de la conjunción, pero también responsabilidad para realizar un análisis crítico de las respectivas limitaciones. En nuestro camino y práctica de décadas, quienes respondemos a am-

bas formaciones hemos debido reconocer, por una parte, que es valiosísimo que una comunidad esté informada y alerta sobre fenómenos que amenazan su estabilidad emocional. Que una institución, población o país pueda contar con protocolos de prevención, detección e intervención en esquemas prácticos es fundamental; ahí la labor psicológica, como hemos dicho, es imprescindible (en ocasiones, hay que decirlo, desde posiciones dogmáticas psicoanalíticas esto no es reconocido).

Sin embargo, en honor a la verdad y desde la experiencia que tenemos como clínicos, formadores y supervisores de clínicos, así como constructores de teoría, también debemos decir que el alcance terapéutico de las aproximaciones psicológicas ante fenómenos tan complejos y multifactoriales como el suicidio, si bien pertinente, es en general muy limitado. Sobre todo, cuando nos encontramos con personas con historias complejas en las que han enfrentado por muchos años graves violencias y no han contado con un lugar y un trato mínimamente dignos ni en su familia ni en su grupo social, de forma que modificar esquemas cognitivos, actitudes o la calidad de sus interacciones con los demás no son cosas que se puedan habilitar ni con intervenciones de una racionalidad simple ni en tiempos reducidos. Es ahí donde el abordaje psicoanalítico aparece como una herramienta sumamente pertinente.

Justamente en la segunda parte de este libro, Cristina Ortega dedica varios capítulos a una revisión, lo más puntual posible, de conceptos y argumentos provenientes de diversos autores psicoanalíticos. Su apuesta es un reto para el lector pues, tras los primeros capítulos escritos en un lenguaje más común, este es invitado a realizar una inmersión en la lengua analítica.

Me parece que el reto que nos propone vale la pena. Si bien el recorrido es necesariamente sintético al presentar algunos conceptos y hay que redoblar la atención, la autora logra poner sobre la mesa un entramado muy útil, tanto para quien ya tiene un conocimiento de la teoría psicoanalítica como para el que apenas inicia en ello, que permite apreciar el valor de hipótesis de trabajo e investigaciones que desde Freud y hasta autores recientes se han aproximado al fenómeno suicida. Particularmente, la dinámica de la instancia superyoica, bien estudiada por Ortega, con todos sus vericuetos y complicaciones.

En efecto, la teoría psicoanalítica es compleja, densa, llena de paradojas; y es que, aunque a veces parezca que lo hace (o los analistas caigamos en la

tentación de hacerlo), su objetivo no es dar explicaciones generales a los fenómenos, explicaciones que puedan aplicarse protocolariamente a todos los casos por igual. Su objetivo es más complejo, tanto como apasionante: crear las condiciones para que quienes lo practicamos podamos acompañar lo más cerca y auténticamente posible a cada persona que acude a nosotros. Para el tema que nos convoca, digámoslo así, la teoría psicoanalítica buscaría posibilitarnos acompañar a cada paciente, con ***su*** idea o intención suicida, ***su*** historia, ***sus*** vínculos, ***su*** sufrimiento, singulares y diferentes a las de cualquier otra persona; ideación o intención detectables, prevenibles, escuchables y tratables de una manera que no podría ser igual a la que se instrumentase con cualquier otra persona.

Todo esto implica que su teoría sea de más compleja lectura que la de la mayoría de las corrientes psicológicas, de más difícil socialización y de no tan fácil asunción institucional. En el espíritu de ser psicólogos y psicoanalistas, cada elemento de la disyunción debe quedar en su lugar y con lo que le corresponde.

Por último, dos cosas que agradezco al psicoanálisis, y que de alguna forma en lazo de amistad he vivido de cerca con la autora de este libro, tanto en momentos de su historia —a los que ella alude al final del texto—, como de la mía.

Una, su capacidad intrínseca para dar lugar al no saber, a los límites de nuestra comprensión y de nuestra potencia transformadora. Ello es particularmente valioso en la clínica del suicidio, donde sí, algún paciente puede llegar a efectuarlo o intentar efectuarlo, y debemos estar en condiciones de sostenernos en nuestro lugar, lejos de la culpa, del callejón sin salida moral o de la frustración intelectual y la impotencia.

Y dos, su facultad acompañante, junto a la de la escritura, para enfrentar la posibilidad de la propia muerte, que puede presentarse como enfermedad, como deseo de no desear más o incluso como deseo de morir; acompañante para habitar la paradoja vida-muerte / yo-otredad; para continuar con el estilo de alguien que pudo haberse despedido el día de ayer, si así se desea.

Les dejo pues con la aventura de este libro y en compañía de su autora.

Francisco Landa Reyes
Querétaro, México, 13 de abril de 2026

Introducción

Hace aproximadamente dieciocho años, me dediqué a trabajar el tema del superyó y su sadismo, atravesando un tanto el fenómeno del suicidio. De ahí a la fecha, me he encontrado con el tema de manera recurrente, haciendo una tesis doctoral titulada Muerte, pulsión y suicidio y asesorando varios trabajos respecto a la problemática; aunque he tratado de dejar a un lado el tema, el tema no me ha dejado a mí. Retomé la escritura a partir de la muerte del Dr. Néstor Braunstein y la carta que nos dejó.

La intención de este texto no pretende ser el que diga la verdad absoluta sobre el suicidio o una especie de "todo lo que usted quería saber acerca de", hay muchos artículos, libros, blogs y más que abordan la cuestión; evidentemente el suicidio no es un fenómeno nuevo, ha existido desde cientos de años, pero la comprensión del mismo sí ha variado, se ha ido modificando con el tiempo, como la verdad misma lo ha hecho. Así, no pretendo encontrar el hilo negro del tema, sino quizás reiterar algunas cosas para ver si con ello se brinda alguna luz más en la atención de las personas con ideación suicida o que han sufrido la pérdida de alguien por suicidio.

Nunca un libro estará completo, siempre faltará más por decir, pero sí hay varias ideas que deseo que queden impregnadas en el lector, y una de ellas es que justamente será necesario siempre tener más lecturas sobre el fenómeno del suicidio, no una sola, ni una sola mirada ni de una sola vertiente. Es necesario que se siga produciendo conocimiento al respecto, desde todos los enfoques posibles, dado que es un fenómeno que puede mirarse desde muchas disciplinas: de la historia, la filosofía, la psicología,

la sociología, la biología, la medicina y la religión; también hay muchas formas de pensar la posible intervención y prevención al respecto en la clínica. Entonces, es importantísimo que se siga escribiendo y hablando sobre el tema, para poder quizás encontrar alguna noción que nos ayude a brindar una mejor escucha del fenómeno y de las personas que atraviesan por la ideación suicida o que sobreviven al suicidio de algún ser querido. Hay tantas personas en el mundo, tan diferentes, que eso nos puede llevar a pensar que no hay una sola forma de abordaje ni existe la mejor forma de hacerlo; entre más se conozca sobre esta variedad, quizás se logre prevenir lo prevenible y comprender lo que nos resulta incomprensible.

Durante los últimos años en el trabajo clínico, mi escucha, creo, ha cambiado; sin embargo, el tema de pensar la muerte y de la "ideación suicida" se han presentado con más frecuencia en mis pacientes. Tratando de no obturar cuando lo hablan, de que por inercia no gane mi necesidad de acallar esas ideas, de que inmediatamente busquen el sentido de sus vidas, escucho e intento entender… en eso que no es racional: el pensar en la muerte propia, aunque es un contrasentido, porque… ¿cómo pensar en algo que no se ha experimentado? Entonces es más preciso decir que el fantasear en la muerte propia resulta común, no solo les pasa a algunos, a los deprimidos, a los locos, a la gente rara… nos pasa a todos, es posible. Hay quienes lo fantasean con mayor claridad y otros no, no lo pasan por el área del pensamiento y la fantasía, sino por el acto o actuaciones. Otros, en los chistes y el humor negro que no todo mundo soporta, pero para quien lo usa es justamente la herramienta de la que dispone para hablar del tema.

¿Qué pasaría si muero? Me han preguntado algunos pacientes, y responden: "Nada… la vida sigue para los demás. ¿Quién sufrirá mi muerte?". Hacen una lista, dicen quién sí, quién no. "¿Qué significará para el mundo que yo deje de existir?". Pensamos que con el tiempo nos volvemos irrelevantes, quizás sea así, quizás dejamos una marca, otra más, otra falla, otra pérdida. Es común. Cómo hablar de nuestra muerte o de querer morir sin que el otro se asuste o se sienta ofendido, rechazado o no amado, y entonces, buscar: ¿Qué me detiene?

Eso es justamente lo que nos sucede cuando escuchamos a alguien hablar de que quiere morirse, nos espanta, por muchos motivos, algunos demasiado propios, o podría decirse, egoístas, puesto que nos cuestiona

nuestro propio deseo de vida o de muerte, lo que nos hará falta con la muerte del otro, ¿cómo podremos seguir? Como si el otro fuera parte de nosotros o un accesorio, como si nos perteneciera. También porque implica una herida narcisista, ¿cómo es que no somos suficiente para que el otro quiera estar con vida? A veces estos cuestionamientos parecen semejantes a los que se hacen las parejas que sufren de una infidelidad: "¿Cómo es que volteó a ver a otra persona?". Y puede ser algo parecido, una especie de traición, porque la persona quiere, piensa o ejecuta un suicidio. Todo esto por parte de quien sobrevive.

Entonces, cómo escuchar al otro sin que intervengan mis propios cuestionamientos, ¿será posible?

Ante esto, se nos ocurren mil cosas por hacer, para prevenir, para detener esta ideación suicida o los hechos suicidas, inventarnos formas de intervención, de capacitaciones, de poder proveer al otro de sentido de vida o de herramientas para su búsqueda.

Lo cierto es que, como veremos en este texto, hay suicidios prevenibles y otros que no lo son. Tampoco hay una manera ideal o la mejor para prevenir los que sí son prevenibles. Hay tanta literatura sobre el tema y, sin embargo, no por eso será suficiente. Tratamos de buscar patrones o señales para que podamos entenderlas y prevenir, y entonces surgen muchas ideas.

No se pueden prevenir los suicidios de manera eficaz, con ello me refiero a que no todos los suicidios se logran prevenir. Si escuchamos a alguien que habla de ello, no por eso lo hará, y quizás lo efectúa el que jamás dio señales sobre su intención. Pero sé que es un tema que a todos nos increpa, nos cuestiona, porque nos remite a que fallamos en el lazo social, en lo que nos ayuda a sostenernos unos a otros. Y entonces es más lo que nosotros perdemos en nuestro ego que la persona que ya no está. No queremos saber de nuestras fallas, no queremos saber de la pérdida, mucho menos de la muerte; y como si tuviéramos un pensamiento mágico, es mejor no hablar de la muerte para que no nos pase.

Nos sentimos infinitos, incluso cuando pensamos la muerte. Justo el día de la muerte de Néstor Braunstein, recuerdo que alguien me escribía: "Él está mejor ahora". ¿Por qué pensamos eso? ¿Quién nos dijo que la muerte tiene algo? ¿Que tendremos una experiencia de algo? Bueno, eso nos

consuela, al pensar en la infinitud, aunque la evidencia inmediata es que somos finitos.

Es un contrasentido también. Nuestra mente, nuestros pensamientos, las fantasías, el inconsciente… nuestro continuo mental nos dan una sensación, una intuición de no término, de sin fin. Pero el cuerpo, con su desarrollo, sus enfermedades, malestares y la muerte física, es la evidencia de lo opuesto. Pareciera que el inconsciente no reconoce la muerte.

Ahora, después de más de diez años de la presentación de mi tesis sobre suicidio, regreso al tema de otra manera, con los mismos temores, pero enfrentados desde otro lugar, con la vivencia de pensar, fantasear, hablar y escuchar de la muerte propia, con respeto, compasión y, espero, sabiduría, si es posible, para que estas palabras sirvan para entender que la cuestión del suicido, de la propia muerte, no es exclusiva de la locura o algún trastorno mental, es común en tanto somos sujetos atravesados por la finitud/intuición de infinitud.

Asimismo, no mencionaré ejemplos, solamente los que ya están plasmados y que tienen que ver con personajes conocidos, no los de mis pacientes, a quienes les debo estas palabras, esta escritura, pero no la mención de ellos, por respeto a su confianza, puesta en el dispositivo donde nos hemos encontrado. Pero sí diré que he escuchado este tema atravesando personas pequeñas, desde los 12 años hasta personas mayores de 76 años; de diferentes medios socioeconómicos, de diversas problemáticas; de diferentes identidades de género; y nunca una ideación suicida es igual a otra, como tampoco lo es un suicidio semejante a otro, aunque tratemos de clasificarlos.

También me he encontrado asesorando algunos trabajos de investigación sobre el tema, como lo había mencionado antes, relacionando este fenómeno del suicidio con problemáticas que van desde el registro estadístico o la falla en el registro, intencional o no, de las autoridades para poder confirmar que se trató de un suicidio o un "intento de", hasta otros temas, como la relación entre las crisis del desarrollo y el suicidio, principalmente las de la adolescencia y la vejez: o cómo sobreviven los amigos del que se suicidó y si no intentan replicarlo. La última idea escuchada sobre la materia es la posición del psicoanalista frente al discurso del que habla de suicidio. En algún momento, también hice otra investigación sobre la actitud de los bachilleratos ante el suicidio, así como revisiones teóricas relacionadas,

como la relevancia del masoquismo psíquico, los mecanismos de defensa y otros temas paralelos.

En la tesis que asesoré y fue presentada por Guerrero y Suárez en agosto del 2019, titulada *El suicidio en México*, hubo algunas complicaciones para la realización, puesto que originalmente se habían planteado indagar cuántos casos de intento suicida se llegaban a atender en los servicios de emergencias y cuántos eran suicidios consumados, en la ciudad de San Juan del Río, Querétaro; pero entre todos los obstáculos con los que se encontraron, uno fue que no eran registradas las emergencias como intentos de suicidio y, por tanto, no se informaban, no aparecen en las estadísticas. Además, aunque aparentemente la información es transparente, el acceso a la información no es nada fácil, a pesar de tratarse de suicidios consumados.

Como lo narran en su tesis, se encontraron con que la información que hay en gráficas de algunas instituciones no refleja la realidad o está incompleta, además de que en aquel momento les mencionaron que no existían protocolos de prevención ni de atención para estos casos. Por ejemplo, se enfocaron en lo proporcionado por el INEGI, quien en 2001 publicó un documento titulado *ABC de las estadísticas de intentos de suicidios y suicidios* en el que explican cómo recopilar la información. De acuerdo con las cifras mostradas por el Ministerio Público, donde se integran datos básicos sociodemográficos de las personas que cometieron el acto, se registran a través de un formato que se sella una vez al mes.

Otra de las razones de la falta de información certera es que, de acuerdo con lo dicho por el Centro de Salud Mental (Cesam) en el 2018, se modifica la información en actas de defunción por petición de la familia. El Cesam tiene como protocolo de actuación que, cuando alguien ingresa por intento de suicidio a una institución pública, se le estabiliza e informa al Cesam, donde se hace la evaluación y, de ser necesario, se le atiende; sin embargo, dependen de lo que las instituciones de salud pública les refieran. Entonces, sigue siendo información no tan real de lo que sucede en lo cotidiano.

La tesis titulada *Suicidio: el devenir de un cuestionamiento en la adolescencia y la vejez,* presentada en agosto del 2015 por García y Hernández, plantea que estas dos etapas de la vida son momentos en los que se presentan crisis: una de identidad o de conformación de la entidad y otra de acercarse a

valorar lo realizado en la vida. Ambas representan etapas de cuestionamientos sobre lo que se es y se quiere ser o lo que le hubiera gustado ser. De ahí que una de las salidas a los cuestionamientos y que denotan el pesimismo o resignación podría ser la elección del suicidio. Proponen entonces mirar al suicidio como decisión, producto de los cuestionamientos de dichas crisis, llevando las causas a un factor más interno que externo.

Isabel Martínez Padilla realizó otra breve investigación cuya pregunta fue: "¿Existe atención institucional hospitalaria de gobierno, especializada en casos de intentos de suicidio?". Realizada en San Juan del Río, Querétaro, en México, lo que le interesaba saber es si había algún protocolo especializado en ello, pero lo que se encontró es que la mayor parte de las veces no se registran como intentos de suicidio y, por tanto, no hay alguna atención especial.

Todo ello muestra cómo puede haber un sinnúmero de reflexiones ante el tema; no todo está dicho, menos en esta época en la que se ha disparado increíblemente el número de suicidios, en la que las crisis personales no son lo único que los ocasiona, también las problemáticas sociales, económicas y de salud, como lo fue atravesar una pandemia. Toda la ansiedad que provocó y que llevó al límite de tolerancia a cientos de personas, incluidos los que se encargaron de atender esta enfermedad, evidenciando no solo las patologías mentales, las depresiones y la enfermedad física, sino incluso la desigualdad social, económica y las carencias afectivas en las familias, el cansancio laboral la falta de apoyo a los trabajadores de "primera línea". Así, encontramos también casos de médicos cometiendo suicidio.

Seguiré pensando al suicidio como una falla del lazo social, del poco sostén que se brinda al sujeto; por eso nos asusta el asunto, nos conmueve y nos increpa. ¿De qué no nos damos cuenta? ¿Qué evitamos al escuchar al otro? ¿Por qué nos asusta que se mencione la ideación suicida?

La escucha psicoanalítica procura encontrar en la repetición la diferencia; entonces… escuchar cuantas veces sea necesario para que "caiga" lo no dicho. Lo cierto es que, si alguien lo dice una y otra vez, por lo menos está ese decir; o sea, se mantiene en el discurso… y, como creo que he podido observar, buscando desesperadamente dar sentido a todo, como diría Víctor Frankl, tratando de encontrarle sentido a la vida.

Las estadísticas nos dicen que el suicidio se da en cierta población, asociado con ciertas patologías, frecuentemente con depresión, con estrés postraumático y algunas otras, incluidas a las adicciones (Nota sobre adicciones: han comenzado el consumo los jóvenes desde los 12 a 17 años, de drogas ilícitas). Por ello, en México se ha creado el Consejo Nacional para la Prevención del Suicidio.

En la actualidad se ve gran influencia de los medios de comunicación masivos, donde se pueden manejar dinámicas nocivas para quienes están al alcance de tecnologías, que, si no son supervisadas o reguladas, pueden tener impactos importantes en las personas. Por ejemplo, algunos grupos virtuales se comunican por chats o mensajes e incitan a cometer actos que ponen en riesgo la integridad física y psicológica de quienes están dentro del grupo.

Algunos de estos grupos llevan estos actos al nivel de presionar para que alguna persona cometa suicidio, enfrente de todos, a través de una pantalla, ahí donde no puede ver qué hay detrás, pero hay muchos que la miran. ¿Qué miran? Cuál es el afán ahora de no solo morir por cuenta propia, sino hacerse ver y ver al otro morir.

Este fenómeno es importante, ya que cada vez hay más jóvenes interactuando mediante las redes sociales y cuyos padres o algún adulto no median el acceso a estos dispositivos, lo cual resulta en actos muy graves que ponen en riesgo su vida.

El suicidio es cada vez más preocupante, en primer lugar, por el índice de actos que se dan al año, que han ido incrementando; en segundo lugar, por la edad en la que se ha presentado últimamente, que va bajando; ya no se puede hablar de que los adolescentes de entre 15 y 18 cometan o presenten intenciones suicidas, sino que ya hay infantes con estas conductas. Durkheim (1858-1917) decía que el suicidio es un fenómeno de índole social, es decir, que tiene que ver con el grupo al que se pertenece y las formas en que dicho grupo puede proteger o no a sus miembros. Así, por supuesto, abordar el suicidio, tema que es complejo en el sentido de que no podemos tener un acercamiento verdaderamente experimental y por lo tanto tampoco explicativo, nos conduce por un sinfín de especulaciones que, al abrir interrogantes, concluyen sin necesariamente tener la respuesta de quienes lo cometieron.

El suicidio es actualmente considerado un problema de salud pública, es un acto sumamente complejo del ser humano en el cual intervienen factores neurobiológicos, psicológicos y sociodemográficos; en promedio, 3 000 personas se suicidan al día en el mundo: una cada 40 segundos. Anualmente, más de 800 000 personas mueren por suicidio cada año, y por cada una que lo consigue, otras 20 lo intentan. Mundialmente es la segunda causa de muerte de personas entre los 15 y los 29 años (OMS, 2018). Según la Organización Mundial de la Salud, en las estadísticas más recientes, el suicidio está entre las 20 causas de muerte a nivel mundial para personas de todas las edades.

Los países con mayor tasa de suicidio, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), son Corea, Lituania, Letonia, Eslovenia, Bélgica, Hungría, Japón, Finlandia, Estados Unidos y Estonia. Mientras que en América Latina son Chile, Brasil y Costa Rica (Rendón, 2021, p. 136). El suicidio se da más en países de bajos a medianos recursos, el 73% se da en países de bajos recursos. También podría vislumbrarse, relacionado con ello, no solo la carencia de recursos, sino su inequitativa distribución, lo que genera descontento y disturbios sociales; pero también hay sociedades donde hay mayor presión social con respecto al aspecto físico, por los estándares de belleza y las exigencias de tener éxito laboral y económico. Pese a que el 79% de los suicidios de todo el mundo se registraron en los países de ingresos bajos y medianos, la tasa más elevada (de 11.5 por 100 000 habitantes) correspondió a los países de ingresos altos, en los que, además, se suicidan casi tres veces más hombres que mujeres; frente a los países de ingresos bajos y medianos, en los que la tasa está más igualada (OMS, 2019).

Entre las personas de ingresos altos, el riesgo se da por el padecimiento de trastornos mentales, principalmente la depresión; también por el consumo del alcohol, por cuestiones económicas, problemas de pareja, enfermedades o dolor crónico. En los países de bajos recursos está en primer lugar como riesgo para el suicidio la guerra, los desastres naturales, la violencia, los abusos o pérdidas, así como sentirse aislados.

Hay poblaciones que, además de que podrían estar en situación de bajos recursos económicos o no, podrían estar padeciendo algún malestar psíquico que se ve potenciado por sus circunstancias particulares, lo que les

señala con mayor riesgo, por ejemplo: los refugiados, los migrantes, los indígenas, la población LGBTIQ+ y los reclusos.

Siguiendo un poco lo que mencionan de la poblaciones con mayor riesgo para el suicidio, hay una que casi no se reconoce como tal, pero es la comunidad de los médicos; precisamente en tiempos de pandemia, fueron quienes más padecieron el horror de la incertidumbre respecto a la cura del contagio por el virus del covid-19. No es desconocido para todos que no solo tuvieron que responder a la gran demanda de atención médica y de especialistas en emergencias o en enfermedades respiratorias, también tuvieron que encargarse los que pudieran o no, los que estuvieran ahí. Ya de por sí el trabajo de los médicos es realmente exigente, tanto que están sobrepasados, desde que son estudiantes o comienzan su residencia, pues los horarios son extremos por las horas de servicio en las que tienen que estar en alerta constante y en disposición total. "Desde 1858, en Inglaterra, se reportó que los doctores tenían mayor riesgo de suicidio que la población general" (Salame, 2021, p. 272).

La Dra. Latife Salame, médica que trabaja en bioética y que ha presentado investigaciones desde hace más de diez años sobre el suicidio, es quien hace más indagaciones sobre lo propio en los médicos. Argumenta que la población de médicos puede tener más trastornos mentales que otras profesiones, pero no solo sufren esto, sino también experimenta más problemas emocionales, familiares, de relaciones personales y laborales por su trabajo extenuante; también son propensos a tener adicciones debido a la facilidad con que pueden conseguir fármacos, ya sea para mantenerse despiertos o lo opuesto. "Los doctores tienen una tasa más alta de suicidios que los militares, a quienes se atribuye una alta frecuencia de estrés y trastornos psiquiátricos" (Salame, 2021, p. 272). Ambas profesiones, militares y médicos, son altamente señaladas para no cometer errores. No es extraño encontrar una actitud de presunción entre estas profesiones, por lo que, si llegan a padecer de alguna patología psicológica o se sienten rebasados, o estresados, difícilmente van a solicitar ayuda. No es su culpa, en realidad tiene también que ver con las expectativas que se forjan respecto a ellos. "Es el sistema explotador el que les ha fallado a los médicos, y no los médicos quienes han fallado al sentirse sobrepasados por su carga laboral" (Salame, 2021, p. 281).

Eso también nos lleva a pensar en los sesgos con los que se maneja la información de los suicidios, desconociendo la perspectiva de género. Suponer que los hombres se suicidan más que las mujeres porque son más efectivos puede ser un prejuicio, un "diagnóstico del poder" (Belausteguigoitia, 2021, p. 110); puede haber razones que producen más registros de los suicidios de los hombres que de las mujeres pero, siempre que se presenta la información, la estadística muestra cómo los hombres en general son más violentos, para matar a otros o a sí mismos, mientras que las mujeres no, y se dice que son menos exitosas por elegir métodos no tan efectivos o rápidos, pues suelen elegir fármacos, sin embargo, lo intentan más. Las causas generalmente también son distintas, porque, aunque coinciden en temas de relaciones de pareja rotas o en conflicto, a las mujeres se les agregan motivos de haber sufrido abusos sexuales, incesto y la fuerte desigualdad social.

En lo personal, no me atrevo a decir quiénes sufren más, creo que ambos sufren; el ser humano sufre, pero sí que hay mayor vulnerabilidad quizás cuando se van agregando más condiciones de desventajas, no biológicas, sino de género, esa construcción social que, de nuevo, como en el caso de los médicos, genera cierta expectativa. Entonces, a las mujeres se les piensa como cuidadoras; aun cuando trabajen o sean independientes económicamente, se mantiene esa expectativa. En el caso de los hombres, se espera que sean proveedores o fuertes emocionalmente. No es el caso de este libro, hablar sobre estas expectativas patriarcales; sin embargo no hay que dejarlas de lado cuando se pretende trabajar con alguien que manifiesta ideación suicida: es revisar todo su contexto. y esto implica algo no tan sencillo. Por ejemplo, en lo que retoma Belausteguigoitia sobre la investigación hecha en Chiapas: "Imberton-Deneke señala a autores como Spencer y Counts, quienes plantean que en las sociedades patriarcales pequeñas son las mujeres las que recurren mayoritariamente al suicidio" (2021, p. 109) debido a que se marcan más fuertes las desigualdades entre hombres y mujeres, quienes padecen de la violencia por parte de sus parejas y no encuentran salidas posibles a los conflictos. Curiosamente, en la investigación de Imberton-Deneke los hombres casados son los que están más propensos a suicidios. No hay que dar por sentado lo que la estadística muestra, pero sí considerar la vulnerabilidad de algunos grupos que, al padecer más la violencia del contexto, agudizan

su sufrimiento, como es el caso de las mujeres, de las y los indígenas, de las y los pobres, de quienes están en guerra, de las disidencias sexuales, condiciones que se pueden ir sumando al padecimiento subjetivo, además de las condiciones socio-económicas que promueven el desanudamiento del colectivo, aíslan a las personas promueven el individualismo.

Se sabe que hay momentos en los que se presentan más casos. El suicidio aumenta "en recesiones y crisis económicas que conllevan inestabilidad política, colapso social, desintegración y desempleo" (Rendón, 2021, p. 143). Por ejemplo, en Brasil hay 14 000 casos por año, lo que implica que se suicidan de 38 a 42 personas al día; la explicación que ofrecen las páginas oficiales tiene que ver con patologías mentales que no han sido diagnosticadas a tiempo o correctamente, o que se han tratado inadecuadamente, lo que también implica que se podría haber evitado, de existir un acceso libre a los tratamientos.

Hay un dato que llama la atención: cada año mueren más por suicidio que por VIH, malaria, cáncer de mama o guerras (de acuerdo con los datos publicados, que seguramente han variado últimamente).

En México, para el 2018, el suicidio ocupó el quinto lugar entre causas de muerte de niños y adolescentes de 10 a 14 años, de acuerdo con la información del INEGI. "Los fallecimientos por lesiones autoinfligidas son la cuarta causa de muerte en la población de 15 a 29 años, solo por debajo de las agresiones, accidentes y la covid-19" , según un informe publicado para el 2022, cuya información hace el corte del 2021. En hombres se presenta como la tercera causa, mientras que para las mujeres es la quinta. En información más reciente, para el 2024 se registraron 9 051 defunciones por suicidio y, si se observan las gráficas, ha ido creciendo (INEGI, s/f). Esto también se ve traducido en que una de cada 100 muertes es por suicidio a nivel mundial.

La OMS estableció además un Día Internacional de la Prevención del Suicidio, el 10 de septiembre, en el que busca hacer conciencia sobre la no discriminación y el correcto abordaje de las enfermedades mentales, considerando que el adecuado manejo y disminución de estas, así como atender adicciones, servirá de prevención para el suicidio. El Día Mundial para la Prevención del Suicidio fue establecido en 2003 por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, junto con la Organización Mundial

de la Salud (s/f). El primer informe que hizo sobre el tema de suicidio fue en el 2014; de ese año a la fecha, ha ido en aumento y, por lo tanto, han estado implementando varias estrategias para combatirlo, como establecer el día internacional de la prevención.

Sin embargo, aun con estos esfuerzos, solo hay 38 países que tienen considerada la prevención del suicidio dentro de sus planes respecto a la salud. En México, "sólo 19 de las 32 entidades federativas han legislado sobre atención psiquiátrica, además de que se trabaja sin estrategias de prevención, sin infraestructura y sin presupuestos específicos" (Rendón, 2021, p. 154), a pesar de que se han asociado ya algunos trastornos mentales y adicciones a sustancias con la conducta suicida.

Más allá del impacto que produce esta información estadística, considerando que es solo el acercamiento de un fenómeno y no la realidad tal cual, pues siempre hay datos que no aparecen en la información estadística, saber sobre un suicidio, aunque sea uno solo, es ya de gran relevancia. Alguna vez escuchaba a varios pacientes, no con ideación suicida, sino atravesados por la noticia de un chico de 21 años que se quitó la vida, arrojándose del noveno piso de un edificio de consultorios. Era relativamente cercano a alguno de ellos, pero no a todos, sin embargo, fue tal el impacto que pareciera como si fuera muy cercano; algo afecta, algo de eso mueve. No hay manera de quedarse sin sentir algo. Lo más frustrante para alguno de ellos era que no se hablaba del asunto, que el silencio se había establecido como una forma de borrar el hecho. Pero ¿qué pasa cuando intentamos borrar un trazo? En ocasiones se marca más. Se cree que, al hablar del tema, habrá una especie de contagio, o es que no se puede enfrentar lo que nos refleja el hecho de que alguien haya decidido lo que quizás quisiéramos nosotros poder hacer.

Un paciente dice: "Si muero, desaparezco del todo, y es como si no hubiera existido, nada de lo que hice y nada de lo que soy, y lo olvidarán pronto". Tiene esa fuerte necesidad de desvanecerse, dice que no puede soportar ya ni tolerar lo que sucede alrededor de él; aunque no son cosas aparentemente graves, dice no poder. Pero, al mismo tiempo, no se da cuenta de que justamente ese acto dejaría una marca imborrable, tal como la narran los otros pacientes ante la simple noticia del chico de 21 años.

Acerquémonos pues a este fenómeno del suicidio, veamos varias vertientes que nos podrían ayudar a la comprensión. Comencemos con la historia, con lo que significa la muerte, cómo se ha interpretado al suicidio a lo largo del tiempo. Veamos también las propuestas de prevención y de tratamiento, entendiendo que hay suicidios prevenibles y otros que no lo son; entonces; reflexionemos sobre el suicidio asistido. Miremos lo que plantea por su parte el psicoanálisis, desde la teoría y su clínica, para el abordaje del suicidio.

1. La historia

Dámelo, Carlota; no tiemblo al tomar el horrible cáliz en que voy a beber la embriaguez de la muerte. Tú me lo presentas y yo no titubeo. De este modo se cumplen los deseos de mi vida. ¡He ahí en lo que vienen a parar todas nuestras esperanzas…! ¡Todas… todas…! En venir a estrellarse con esta sangre fría, con este entorpecimiento, contra las puertas de bronce de la muerte.

Goethe

Tanto la muerte como el suicidio en la historia han atravesado formas diferentes de ser abordados, dependiendo de cada disciplina, pero también de los fenómenos sociales que se han suscitado. Parece, por tanto, importante hacer un recorrido a través de esos cambios históricos, para finalmente comprender cómo se han dado esos cambios y cómo se piensa en la muerte y el suicidio en estos días, en esta época, con lo propio de lo que se ha llamado la modernidad (o posmodernidad).

La modernidad

La modernidad —para colocarse en el hoy en día— se ha descrito por algunos teóricos como una época o etapa de la humanidad; esto tiene una manera de interpretarse, algo así como un momento en la historia. Sin embargo, es complicado determinarla en un lapso, en un límite de fechas, aunque sí se ha pretendido ubicarla de esa manera.

Lo que sí es posible es verla como un fenómeno, es decir, detectar las características que la distinguen de otras maneras de ser de la humanidad. De su raíz etimológica poco se puede extraer, cuando la referencia es a "modo"; así, la modernidad solo hace una alusión a una forma, mejor dicho, manera. También tiene que ver con costumbre, pero es a partir del siglo xiv a una cuando se le considera como lo reciente o actual. Que se diga que desde el siglo xiv se habla de la modernidad es un intento, como se dijo

anteriormente, de situarlo en el tiempo. Eso aporta, de cualquier manera, indicios sobre lo que caracteriza a este fenómeno. Ese siglo en particular marca el final de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. ¿Por qué considerar a esto modernidad?

Simplemente se sabe que la Edad Media, el oscurantismo, termina por un fenómeno de alumbramiento, podría decirse; en otras palabras, de la llamada "Ilustración" y/o "Renacimiento". Estos términos implican un sinfin de cambios en lo geopolítico, en lo social, en el arte, etc., en todo lo que atañe al ser humano. De ahí la relevancia de estos cambios que para encuadrarlos se les cataloga con el nombre de modernidad.

A esto se atribuye, por ejemplo, el descubrimiento de nuevas tierras, la apertura de nuevos horizontes, no solo espaciales, sino en cuanto a dominio de otros —considerados inferiores—, la colonización, el engrandecimiento de los feudos y la reorganización de los reinos, además lo relacionado con las cuestiones comerciales; todo esto, impactando también en la forma de ver el mundo, la naturaleza y al hombre mismo. De tal suerte que, además, modifica el arte y el pensamiento.

En la ciencia, la invención de la pólvora y de la imprenta demuestran un avance significativo para la tecnología, pero también para la relación del hombre con el mundo. En primer lugar, la pólvora da lugar al poder de matar al otro a distancia, sin el cuerpo a cuerpo de las luchas antiguas, y de ahí los avances llevan hasta la opción de poder eliminar a los demás con apretar un botón. Mientras, la imprenta representa una forma de comunicarse, a distancia también y con numerosa producción, con personas que ni siquiera tienen que resultar conocidas, hasta llegar al día de hoy, en que con un botón se puede acceder a la información que se desee. Esto es justamente la Ilustración o el surgimiento de la industria. El triunfo del *animal laborans*, según lo dice Arendt.

Con todo esto, el reconocimiento del hombre por su capacidad de manipular su mundo, de crear, de destruir, de ser libre para tomar decisiones sobre su destino.

Es así como en el conocimiento, más bien de tipo filosófico, aquel lazo que unía a este saber con la religión por medio de la teología, se rompe, lo que lleva a un regreso de la idea del hombre como era pensado en la Grecia antigua: un hombre de la civilización, que puede elegir su gobierno.

Bernstein (1991) dice que esto es "lo característico de la vida moderna: la fluctuación entre las esperanzas apocalípticas, con sus fantasías de un rompimiento total con la historia, y la desesperación paralizante que se hace presente cuando esas esperanzas se ven frustradas" (p. 32).

Específicamente en la religión, este declive está enmarcado por la reforma, por el cuestionamiento acerca de la salvación, ya no como un asunto de una raza, sino, según el Nuevo Testamento, algo que le corresponde a cada individuo buscar. El conflicto principal es por el sacramento de la confesión, que supone la reflexión sobre los propios actos, para llegar al arrepentimiento y ser perdonado por medio del otro, del sacerdote con la autoridad para ello. Esta incursión del sacramento es un quebrantamiento de la identidad del hombre con Dios, pues ya no pueden ser tan a imagen y semejanza debido a que el hombre es capaz de cometer pecado. Esto, al mismo tiempo, lo hace libre de decidir sobre sus actos.

La reforma acepta esta diferencia, pero propone un trabajo de reflexión y de intimidad con Dios, mientras que el catolicismo genera la culpa ante el otro; de ahí la inquisición, la pregunta por la verdad y la identidad, con su método peculiar de provocar el límite para que se pueda liberar la verdad, a través del dolor y la purificación, y de esta manera ser develada.

La modernidad es, pues, la pregunta por la verdad. Se dejan atrás los determinismos de las estructuras, de la Iglesia y del Gobierno o Reinado, pues ahora se puede elegir, se puede reflexionar, se puede cuestionar desde uno mismo, sin recurrir forzosamente al otro. No hay sometimiento al rey. Aparecen las nuevas formas de organización, como el marxismo, donde se pretende que el pueblo se gobierne a sí mismo, y el capitalismo, donde lo gobierne el mercado o el dinero. En ambos sistemas podría decirse que no hay claridad de quién es el "otro" al cual referirse, sino que es "el pueblo" o "el dinero"; no se le puede identificar con alguien, sino que es algo.

Es, también puede decirse, la caída de la visión teológica dando paso a la científica. La muerte de Dios. La ciencia se coloca como lo verdadero, con su método para conseguirlo, que es a través de la observación; o bien, por medio de caminos racionales, pura y solamente racionales de acuerdo con ella misma; o sea, que guarden una lógica, que posean condiciones de posibilidad. Esto significa la caída de la autoridad de los dioses, pues, aunque la ciencia usurpe ese lugar, no deja de pertenecer al dominio humano y no

a otra dimensión fuera de él; es así como el hombre se convierte en la medida de todas las cosas, en la medida de sí mismo. ¿Dando paso al sujeto autorreferencial que menciona Dufour?

Ya no es Dios quien sabe a dónde va el hombre, ahora son el Estado, el Capital y la Ciencia quienes le proveen un sentido. Lo que determina el pensamiento es él mismo y no un Ser supremo. Lo existente son los hechos físicos, el lenguaje y la historia. Es una forma de rebelarse ante lo dado, una forma crítica.

Como dice Habermas (1989) respecto de la modernidad: "Solo constituye ya una última época en la historia de la racionalización que viene de muy lejos y que se inició con la disolución de la vida arcaica y la destrucción del mito" (p. 2). Esto implica también que la modernidad es un proceso de crítica de todo, definiendo a la crítica como aquello que cuestiona para encontrar qué de verdadero existe en el hecho o cuál es la razón que lo sustenta.

Esto complica un tanto el acercamiento a la verdad, pues se pone en riesgo de relativizar todo, por cuanto el hombre se muestra escéptico ante todo saber o ante toda experiencia, y que al final de cuentas conduce a la inmovilidad. Esto lleva, además, a un "interminable juego de diferencias, y ninguna promesa de síntesis" (Bernstein, 1991, p. 22). Esto es, simplemente, que se ha reconocido la falta del sujeto, la carencia, la incompletud y, por tanto, la necesidad del otro sujeto.

La experiencia en la modernidad está dividida porque pertenece al sujeto autorreferencial, autorreflexivo, crítico, y no a una referencia absoluta. Así, dentro de este contexto, ¿qué sucede con la experiencia de la muerte? Si la experiencia en la modernidad está dividida y la muerte es aquello que todos experimentan.

La muerte

Michel Foucault (1992) dice, en su texto *El orden del discurso,* que uno de los procedimientos de exclusión del discurso más evidente es la prohibición; es decir, no todo está permitido decirse, ni en cualquier momento ni cual-

quier persona puede decir algo. Así se ha presentado en lo concerniente a la muerte y al suicidio.

Con respecto a la muerte, por lo menos a la propia, es algo que, aunque inevitable, es impensable. En el decir, se piensa desde lo bien visto por la sociedad que es imprudente hablar de la muerte de alguien cuando no ha sucedido, o ¿qué esperar del desear la muerte propia o de otro? Son cosas que no se deben hablar. Resultan ser temas tabúes.

El temor a hablar de la muerte o de tocar a los muertos no siempre ha existido, antes era un asunto aceptado, pues se conseguía la paz eterna, era algo deseable, por lo menos hasta lo que se considera como la primera Edad Media. En el momento en que surge la noción de pecado, pero del pecado de orden social, por el que un sujeto debe confesar su culpa ante otro y este debe perdonarle o condenarle, se convierte en algo temido, pues existe una consecuencia de los actos, y puede no ser algo agradable. Es así como la muerte, unida al pecado y a la confesión, se convierte en algo complicado. Incluso hay quienes afirman que el hecho de colocar lápidas sobre los restos mortuorios, encerrados a su vez en un féretro, es una forma de separar el mundo de los vivos y de los muertos, pero también evitar el contacto directo con estos, como si se tratara de un contagio.

Aunque esta manera de ver la muerte no es algo que siempre ha existido en el hombre, más bien aparece a partir del siglo xx, "el miedo de la muerte señala el espíritu de previsión, de organización, una concepción razonable y voluntaria del mundo: la modernidad" (Ariés, 1992, p. 27). Esto lo prueban el circo romano; las ejecuciones públicas de los delincuentes en la Inglaterra hasta 1868; la morgue de París exponiendo sus cadáveres, cerrada hasta 1920. "En tales circunstancias, la muerte es una especie de pornografía, a la vez emocionante e irreal: 'la muerte, sí, da pavor, pero trae excitación'" (Álvarez, 1999, p. 83).

Tal vez esto refleja que no había miedo a los muertos, a los cadáveres, y que este temor a los muertos es reciente, aunque tal vez no el miedo a la muerte en sí.

Así, lo que se define como la muerte domada de la primera Edad Media está caracterizada porque siempre es anunciada y, por lo tanto, bienvenida, además, se vive como un hecho social, en grupo o en estirpe; por tanto, era un acto público. Naturalmente, la creencia predominante era un más allá

religioso; así, la muerte era más bien un nuevo nacimiento. ¿Qué se hacía con los cadáveres? Convivían con los vivos en lugares comunes, en los cementerios situados en las iglesias y cercanas a los santos. Siempre juntos, aunque no se ubicara exactamente el lugar de la sepultura, mientras que los lugares solitarios, las sepulturas solitarias, provocaban horror.

Antes de la Edad Media, en el paganismo, se cuidaban los lugares de los muertos, se les protegía; en el fondo, por el temor de que volvieran a perturbar a los vivos, costumbre que se dejó en el oscurantismo inicial.

Luego vino una época de la vuelta al sentido individual: la segunda Edad Media, dejando el destino colectivo, preocupándose entonces por ganarse el paraíso eterno mediante actos piadosos o misas y donativos que les aseguraran ese futuro después de la muerte, dando mayor importancia a la hora de la muerte, al Juicio Final, en la que se pueda arrepentir y pedir perdón por lo realizado a lo largo de la vida, en la que el interés primordial es afirmar la identidad. El miedo a la muerte de esta época es, sin duda, el temor generado por el Apocalipsis o por el miedo al infierno. Mientras que con los muertos la costumbre fue ocultarlos encerrándolos en cajas de madera, siendo opuesto lo mostrado en el arte macabro, en el que se veía lo que en la realidad se escondía. El infierno era contado como aquella descomposición que los cuerpos sufrían al morir. El duelo se vivía de manera dramática y ostentosa.

Luego surgió otra forma de relacionarse con la muerte, en el siglo XIX, y que era la conciencia de la muerte del otro, pero sufriéndola de manera privada, en la familia nuclear. Aparece la belleza de la muerte, un bien deseado para reunirse con el ser amado. Se disocia por completo la muerte del mal, se piensa en el purgatorio. Surge el espiritismo —naciente en América con la formalidad que le da su representante, Allan Kardec—, como reflejo de la esperanza por encontrarse o permanecer en comunicación con los seres queridos. La muerte se ha borrado y quedan solo sustitutos del cuerpo. Los cementerios quedan fuera de las ciudades y se crean lugares privados que cobran para realizar los rituales funerarios. Después de las grandes guerras, se erigen tumbas en el lugar del martirio, para ser objeto de culto colectivo.

En la entrada a la modernidad, la muerte, "en lo que entonces tenía de lejano, fue acercada y fascinó, provocó las mismas curiosidades extrañas, las mismas imaginaciones y las mismas desviaciones perversas que el sexo

y el erotismo" (Ariés, 1992, p. 504). El miedo se orientó a ser enterrado vivo, convencidos de que existía un estado intermedio o un cierto grado de vida en el cadáver. La costumbre de la época para los ricos era tener un laboratorio de anatomía. Se crearon amuletos para bien morir, como escapularios, rosarios, etc. El drama del duelo y la avaricia por las cosas se sustituyó por la sobriedad. Se dividieron los cementerios por clases sociales y se separaron de las ciudades e iglesias, por razones de higiene principalmente. Se inició la idea de la vivencia de la nada que supone la muerte, y ya no será más un acontecimiento tranquilo, sino algo violento.

Finalmente, la muerte pasó al hospital. Se le miente al moribundo sobre su estado grave; así, él deja de tener decisión o poder sobre sus bienes y el resto de vida; sus últimos momentos ya no son suyos, sino de lo que queda bajo los efectos de los sedantes suministrados para evitar el dolor. Es así una época de anestesia, tanto del conocimiento de la muerte propia próxima como del sufrimiento físico. Ya no hay reunión previa con la familia o los seres queridos, dadas las circunstancias hospitalarias. La muerte se ve como algo antihigiénico que es mejor trasladar al hospital. Es también un fracaso de la medicina. El luto queda en calidad casi de prohibido, pues si dura más de lo esperado, se considera un trastorno —el duelo es una enfermedad—; mientras tanto, al sujeto en duelo se le aísla, que sufra en privado y furtivamente —como la práctica masturbatoria—, como si su tristeza fuera contagiosa. Se vive la muerte como algo vergonzoso, y la muerte misma como si no existiera. "La sociedad no tiene ya pausas: la desaparición de un individuo no afecta ya a su continuidad. En la ciudad todo sigue como si nadie muriese" (Ariés, 1992, p. 467). Ya no hay culto a la tumba, sino solo al recuerdo.

Schopenhauer dice que, al tener conciencia de la muerte, siendo esta un final tan terrible para el hombre, se puede pensar en que es un castigo y que la vida ha de ser el pecado más grave, puesto que la consecuencia es algo tan terrible como la muerte: "Que nuestra existencia implica de suyo una culpa, lo demuestra la muerte" (Shopenhauer, 1999, p. 71). Podría decirse entonces que la muerte es un término inevitable para la humanidad, un encuentro con la verdad más íntima y total, ontológica y filogenéticamente hablando.

La modernidad no ha acercado más a la muerte, en el sentido de que no ha provocado la muerte, tal vez sí de la fe. Lo que sí ha otorgado es el acce-

so a la posibilidad del pensar sobre ella como algo improbable de ser pensado. "El crecimiento de la tecnología moderna ha vuelto absurda la propia muerte, reduciéndola a un suceso fortuito del todo desvinculado del ritmo interno y la lógica de las vidas destruidas" (Álvarez, 1999, p. 289). Si se piensa en lo que representa a su vez la posmodernidad, es entonces que la muerte pierde también esa idea de que se obtendrá un premio o castigo dado el comportamiento en vida, pues, no habiendo un Dios en el cual creer o un sistema religioso, al ya no solo criticar, sino perder la fe, ahora no se sabe absolutamente nada de lo que representa lo que sigue a la muerte.

Se generan rituales, vestimentas, música, costumbres, etc., para acercarse de formas diferentes a la muerte, de las que el oscurantismo había enseñado. No significa que se haya perdido el aprecio por la vida, solo que se está más consciente de la realidad, de eso que se sabe que sucederá, aunque no se sepa qué sucederá, y porque ese orden que se desea tener sobre los hechos de la muerte finalmente provee tranquilidad.

Puede decirse que una de las herencias de la modernidad es la nostalgia de la muerte; dentro de toda su búsqueda de la verdad, del encuentro y reconocimiento de la libertad y la identidad del sujeto, inevitablemente se topa con la realidad de la muerte. Pero no de cualquier manera se enfrenta a este acontecimiento, no como antes, pues la modernidad es símbolo de la ilustración, del cuestionar, de la discusión, del abandono de las creencias, es decir, del abandono de la religión como la institución que gobierna y, por ende, controla el saber.

De tal manera que la respuesta religiosa judeo-cristiana —principalmente— ante el cuestionamiento sobre la muerte es más que simple, con la promesa de una vida eterna, menospreciando un tanto el significado e importancia. Así, la muerte es tan solo un paso a otra cosa, a una vida plena, una vida en unión con su dios.

Es cierto, sigue siendo un paso a otra cosa, sin embargo, difícilmente se podrá demostrar a qué lleva ese paso, qué es esa "otra cosa", pues es un pasar a algo que no se conoce, de lo que no se sabe la forma; "el propio lenguaje no está hecho para expresar la muerte" (Jankélévitch, 2004, p. 101). De tal manera que hablar de la muerte conduce a especular, a reflexionar, a abstraer, pero nada más. El empirismo no sirve para proporcionar respues-

tas, irónicamente no se puede responder —desde ese lugar— sobre lo único que todo ser vivo experimenta sin excepción.

Resulta innegable que, al enfrentarse ante esta realidad, se presenta la carencia del saber, del conocimiento, de la experiencia, de aquello que el ser humano siempre ha perseguido. Es así como la nostalgia, proveniente de esa añoranza de lo perdido o de lo que no se puede tener, invade. Ya como Freud menciona con ese deseo de retornar al origen, esa nostalgia que —en su raíz griega— significa el sufrimiento por no poder regresar. Por supuesto, es inevitable llegar a la muerte, sin embargo, no se sabe cuándo sucederá. Kundera (2000), al revisar la palabra *nostalgia*, encuentra asociación con añoranza, que a su vez es derivado del latín *ignorar*; así, "la nostalgia se nos revela como el dolor de la ignorancia" (p. 12). A la luz de La Odisea, comenta cómo Ulises, a pesar de poder estar en una vida placentera junto a Calipso, deseó regresar con Penélope; es decir, prefiere lo conocido a lo desconocido; en otras palabras, "a lo infinito (ya que la aventura nunca pretende tener un fin) prefirió el fin (ya que el regreso es la reconciliación con lo que la vida tiene de finito)" (Kundera, 2000, p. 14).

Sin embargo, Ulises conocía su origen en Penélope, en una vida que al menos había vivido un poco. Con respecto a la muerte, el problema es que, si ya se transitó por una experiencia de inanimación y se tiende a ella, es algo totalmente desconocido para el hombre, es entonces esa nostalgia ligada a la ignorancia.

Esta nostalgia no es solo por saber sobre la muerte, sino por la muerte misma. Algunos quieren la tranquilidad, la paz, la armonía, sin saber que eso se contrapone al movimiento. Sí, es cierto que también está en contra de la guerra y el desorden, pero querer que las cosas se estabilicen es esperar el no-movimiento, y la vida es movimiento. Es un "puro signo de interrogación" (Levinas, 1998, p. 25), un sin respuesta.

En esta intención, también se encuentran los creyentes en otra vida después de la muerte, esperando que esa otra vida sea mejor, llena de paz, de un lugar donde no exista la posibilidad de elegir, porque todo está relacionado directamente al Bien. No decidir, no desear, no necesitar, no buscar más, pues ya se tiene lo que faltaba. Un estado de contemplación extasiada. Así de simple: un estado es la estática. Pero eso no es la vida, pues se parece más a lo que se conoce —raquíticamente— como muerte, como lo dice

Savater (1995): "Esa vida que comienza al morir, esa vida sin injusticias ni contrariedades, que ya nunca acabará porque ninguna muerte vendrá a interrumpirla… ¿no se parece demasiado a lo que habitualmente llamamos 'muerte'" (p. 233).

Lacan lo señala en su texto sobre la familia, cuya traducción lo refiere como "el apetito de muerte" y la nostalgia del todo. Al plantear el complejo de destete, dice que el sufrimiento que puede representar esta separación no es por la necesidad fisiológica o vital más que por la tendencia psíquica a la muerte, a ese deseo de estar en la totalidad del ser, en la perfección, en la fusión: "Formas todas de la búsqueda del paraíso perdido anterior al nacimiento y de la más oscura aspiración a la muerte" (Lacan, 1938), pues volver al vientre materno significaría la desubjetivización.

Esta idea del retorno al origen o de que la muerte como destino es al mismo tiempo el inicio es, sin duda, herencia del pensamiento que predominó en la modernidad, llamado energeticismo.

Es claro que, para hablar de muerte, se tiene que nombrar su opuesto, que es la vida, e incluso jugar y definir a la muerte como el término de la vida, o a esta como el camino hacia la muerte. O decir que solo se está viviendo la muerte, que la vida es un irse muriendo. "Se puede decir entonces que lo que no muere no vive" (Jankélévitch, 2004, p. 18).

Puesto que en los seres vivos se está dando todo el tiempo una forma de muerte, que es la división celular, la muerte es un camino que empieza en el nacimiento, como lo dice Bello (2003): "La muerte biológica de los organismos no ocurre estrictamente en un momento dado, es un proceso que inicia con el nacimiento y concluye hasta donde los hombres y las mujeres de ciencia han acordado, con la llamada 'muerte neurológica' o 'muerte cerebral'" (p. 20).

En fin, no hay términos medios para definirlos, si acaso la enfermedad sería un signo o una señal de la muerte, que además les afecta tanto a sanos como a los que no lo están. Aunque la enfermedad puede terminar en la continuidad de la vida o en la muerte, no se puede decir que sea semejante a nada de ambas. Se cuenta con otro referente además de la enfermedad, que podría ser el sueño, el dormir, como lo menciona Morin: "El sueño es la primera apariencia empírica de la muerte" (Morin, 1999, p. 131); léase que no es la primera experiencia o vivencia, sino apariencia, algo que es

parecido, no idéntico, sino que sirve simplemente como un ejemplo distante. Puesto que mientras se está dormido hay una desconexión con la realidad concreta, hay un distanciamiento con lo material, con lo diurno, hay, diría Freud, un retiro del interés o de la libido del mundo exterior. También hay otro referente que es conocido como *la petit mort,* la pequeña muerte, que es el orgasmo, en el que confluyen las sensaciones hasta llegar a un punto clímax que después produce el descenso de las sensaciones, ese periodo de meseta, de extrema relajación.

El energeticismo o energetismo plantea, en Freud, que hay dos fuerzas que se contraponen luchando entre ellas, y que esa lucha mantiene de alguna manera el equilibrio, conocidas como *pulsiones de vida y muerte* o Eros y Tánatos. Esta idea de la existencia de pulsión como principio de vida lleva a Freud a pensar a partir del concepto del *principio del placer*, por el que el sujeto o todo organismo,busca atenuar el dolor, evadir el sufrimiento, como si esa fuera la única intención del ser humano. Por lo tanto, es una búsqueda de disminuir la tensión, la tendencia de todo organismo a encontrar la homeostasis o tranquilidad. Todo organismo tiende a su origen y su origen, es el no movimiento: "Todas las pulsiones quieren reproducir algo anterior" (Freud, 1920/1999, p. 37).

Esta búsqueda de equilibrio energético es conducida por la pulsión de muerte, pues lo que sí se sabe sobre la muerte es que no hay nada, que es un no-movimiento, y lo que lleva a vivir es la lucha de su contraparte, la pulsión de vida. Si los seres humanos experimentan momentos de júbilo, de éxtasis, de tranquilidad, de enfermedad, de sufrimiento, de felicidad, de paz, es simplemente por la lucha de estas dos pulsiones.

Todo organismo que es fruto de la multiplicación celular o de la pluricelularidad, es decir, requiere del otro para dar vida, es sujeto de la muerte.

Dicho en otras palabras, el destino del hombre es la muerte. El deseo, por más que vaya en diferentes direcciones, llevará al final de cuentas a la muerte, a ese estado anterior del organismo, de la nada a la existencia y de la existencia a la nada.

En nadie hace más mella la muerte que en el ser humano, pues el animal no se pregunta por ella, no la cuestiona, no la trata de evitar de la misma manera que el hombre, ni tampoco la desea como algunos lo hacen. Los seres humanos están definidos así, porque saben de su existencia, pero sobre

todo de su término. Savater dice que no es el intelecto, la voluntad o el lenguaje lo que distingue a los seres humanos, sino esa certeza de la muerte.

Shopenhauer (1999) lo dice de esta otra manera: "La capacidad de conocimiento es la que hace que la vida del hombre sea más rica en sufrimiento que la del animal" (p. 32), puesto que, aunque es capaz de buscar el placer, el padecimiento es más grande en cuanto sabe cuál es el final, mientras que el animal simplemente reacciona ante el dolor o el placer sin saber de las consecuencias.

Ante esta certeza, los seres humanos actúan de diversas maneras. El mismo lazo social es una manera de contrarrestarla, pues es por este que se genera la historia, que hay recuerdo, que hay una suerte de inmortalidad. El poder no es otra cosa que buscar la eternidad. Conquistar para que una civilización prevalezca, aunque sea en detrimento de otra; provocar la muerte del otro, para evitar la propia.

De hecho, el hombre se enfrenta a la muerte, pero siempre del otro, no porque la haya vivido, por más que se piense en lo que esto significa. Sin embargo, es algo que es propio, lo más propio, lo intransferible, aunque es impensable, pero recurrentemente se intenta pensar. Jankélévitch dice que se puede tener una relación con ella desde tres lugares: en tercera persona cuando no importa quién ha muerto y es reemplazable; en primera persona, cosa difícil de poder pensarse; y en segunda persona, "la muerte de alguien cercano, que es la experiencia filosófica privilegiada, porque es tangencial a dos personas allegadas" (Jankélévithc, 2004, p. 15). Heidegger, por su parte, desde la lectura de Levinas, diría que se vive la muerte del otro con culpa por sobrevivirle.

Es así como lo que le pertenece al hombre es lo que desconoce, un significante cuyo contenido es incognoscible, tal vez vacío por lo mismo, aunque ni eso se sabe, si es vacío o lleno, o cuál sea su contenido en realidad. No obstante, es lo único que se tiene por completo para cada quien, de manera única. En el *dasein* heideggeriano, este se presenta como algo incompleto: "Hay algo aún ausente, con una ausencia que pertenece al propio ser, y esa ausencia es la muerte" (Levinas, 1998, p. 44). Diría este filósofo que la muerte se anunciaría, en lo más propio del ser, en lo que se puede decir mío. Es decir que, si el *dasein* busca la totalidad, la completud,

solo la obtiene por su final en el tiempo, que es la muerte, al mismo tiempo que es el término del "estar en el mundo" y lo inevitable.

Tan es así que es individual, que la muerte termina con cada uno y se pasa a conformar el grupo de los muertos, de lo que a todos les pasa, como afirma Savater (1995):

> La conciencia aguda de nuestra individualidad es conciencia aguda de la muerte que nos toma de uno en uno para que engrosemos la masa indiferenciada de lo que los romanos llamaban "la mayoría": morir es pasarse a la mayoría y dejar de ser uno, uno mismo. (p. 237)

Es a lo que Freud nombra como ominoso, pues es aquello familiar y a la vez terrorífico.

De la muerte se puede saber el *cómo*, *cuándo*, *a quién*, pero nunca el *qué es*. Equipararla a otro tipo de vida es no conocerla o desvirtuarla —si es que puede hablarse de que posea alguna virtud. Representarla a partir de la vida resulta *inútil*, pues es un sin-sentido (no sentido o ausencia de sentido) que, al mismo, tiempo, provee de sentido a la vida. Si se cree entender o saber qué es la muerte, seguramente eso que se cree no lo es. Como diría Epicuro: "Si tú estás, no está la muerte; si está ella, no estás tú" (Levinas, 1998, p. 30).

De ahí que se pueda entender a Levinas (1998) —leyendo a Heidegger— cuando afirma que la muerte no puede identificarse como la nada, pues resulta más bien "como una exclusión distinta a la negación —la misma que descarta la contradicción entre ser y nada— en forma de tercero excluido" (p. 50). Por tanto, sería falso decir que es un "no-ser" o la nada misma, puesto que estos se encuentran en una especie de simetría; se le adjudicaría una categoría dentro del ser, aunque sea de lo que no es, pero eso ya sería acercarse desde la lógica del ser.

Para Heidegger, no es la madurez, no es un término del camino, sino una de las posibilidades, pero una de las que se darán con seguridad sin importar si se maduró o no el ser.

La muerte sí es total porque es para todos. Al mismo tiempo, es lo más íntimo, porque cada quien tiene su morir. Savater (1995) lo dice así: "Es el único secreto que conocemos de todos nuestros semejantes y también de nosotros mismos" (p. 225), en tanto que es lo común en el humano, pero

que es lo más íntimo y a la vez tan desconocido como podría ser un secreto. Al respecto, Jankélévitch se contrapone en relación a ver la muerte como un secreto, en tanto que los secretos pueden descubrirse, se puede saber el contenido; más bien, para él resulta más claro identificarlo con un misterio, pues, aunque se revele, no se puede descubrir, es decir, aparece, más no se conoce. "Ahora bien, la muerte es a la vez problema y misterio, lógica y misteriosa" (Jankélévitch, 2004, p. 54), porque como problema es algo que puede contemplarse fuera del sujeto, verla como un objeto, pero en tanto que es propio y no se reconoce el contenido, sigue siendo un misterio. Lógico, porque sucederá siempre, tal como una consecuencia; después de la vida, sobrevendrá la muerte. Así como tampoco puede ser algo aprendido ni aprehendido: "En principio es una cosa que se hace una vez en la vida, y esta primera vez es la última, por definición" (Jankélévitch, 2004, p. 31), imposible que se convierta en un hábito.

De lo que no hay duda es que es tan individual como general, como lo podría decir Heidegger, la muerte es solo de aquel que puede decir "yo", es decir, solo de aquel que tenga conciencia de sí mismo, por lo tanto, de su final también.

Aun así, para Jean Améry (1999); "la muerte no es nunca natural" (p. 43) como un hecho aceptado o normal, no es algo deseado o esperado, es algo sabido, más no esperado para el que muere. De ahí que, generalmente, el primer impacto sea de desaprobación, de no aceptar la muerte. Se vive la mayor parte del tiempo como un acto de violencia, porque existe la posibilidad de que sucediera en otro momento y porque la causa siempre será externa; nadie muere por la edad, sino por alguna falla del organismo en todo caso. Por otra parte, es tan natural, en el sentido de que es banal, sucede todo el tiempo, es cotidiano. No hay elección en si morir o no, solamente puede existir decisión con respecto a la manera y el tiempo de morir; como un ejemplo, el suicidio.

Respecto a la muerte y al suicidio, encontré un texto de Beatriz Vanda, que tituló "¿Los animales también se suicidan?", que está en una compilación que realizara Arnoldo Kraus. Por supuesto que la primera reacción de muchos podría ser una respuesta tajante de que no es posible que los animales se suiciden, no es el tema por ahora, pero sí lo que ella escribe respecto a la muerte por apoptosis. Ella, cómo veterinaria con estudios avanzados y de-

dicada a trabajar por el bienestar animal, habla de este fenómeno que ella considera suicidio a nivel microscópico, pues esta palabra: *apoptosis*, hace referencia a "la muerte celular fisiológica o programada genéticamente" (Vanda, p. 210), que se describió desde 1972 sobre las células que por una señal externa involucionan o desaparecen para favorecer el desarrollo, por ejemplo, lo que sucede con un embrión. Entonces esto, mucho mejor explicado por ella, da pie a entender la muerte de manera distinta, siendo un proceso. En sus palabras:

> Ya no era algo desconocido, violento o ajeno que provenía de afuera, sino que también podía surgir desde nuestro interior, y nos es tan cercana que incluso la llevamos inscrita en nuestro genoma. De hecho, la idea de Martin Heidegger de "el ser para la muerte" podría ser cambiada por la de "el ser con la muerte".

Es decir, para ella, la *apoptosis* es una especie de suicidio, de muerte celular que da pie a otra cosa, pero que indica que los organismos que tienen estas alteraciones o modificaciones (como los seres humanos, pero también animales o plantas) tienen en su información celular la muerte. Evidencia que la muerte es parte de la vida, pero también implica que las células "deciden" morir para mejorar las condiciones o porque ya no hay condiciones ideales. Entonces, hablemos de suicidio.

Suicidio

El suicidio podría situarse en esa otra manera de excluir el discurso, que es entre lo razonable y lo que no lo es, o que está del lado de la locura, a pesar que el suicidio ha sido exaltado por algunos filósofos y por la religión en sus primeros albores.

El suicidio, representando esta decisión de la manera y el tiempo de morir, ha sido criticado y se ha opinado mucho sobre él. El suicidio, en su concepción más simple, es el darse muerte voluntariamente. Los filósofos lo han exaltado, la moral y la religión —en algún momento— lo han condenado. Algunas sociedades lo han tachado de acto cobarde o una salida fácil para quienes no pueden enfrentar la vida. También ha sido calificado de crimen.

Tal como se puede ver en la declaración del juez Antonin Scalia, "está absolutamente claro que el derecho a morir no existe […] la ley nunca ha permitido el suicidio" (Szasz, 2002, p. 53), dejando en evidencia que es un acto ilícito.

Tan ilícito es que la ley fue muy clara durante siglos pasados sobre los castigos. Así, se pueden encontrar registros de las condenas para los cuerpos de los muertos por suicidio, tales como colgarlos por los pies, arrastrarlos por las calles, donarlos a los colegios de medicina para su disección, quemarlos, arrojarlos al basurero, enterrarlos lejos de la ciudad y de los demás difuntos, o colocarlos en las encrucijadas. También existieron leyes en Inglaterra, como un caso asombroso rememorado vía la literatura, en el que se cuenta de un hombre condenado a la horca por haber cometido el delito de intentar darse muerte a él mismo.

Se puede pensar que estas normas tenían un lazo fuerte con la idea de la religión —principalmente la judeocristiana— de que el suicida es un pecador, faltando al quinto mandamiento. De hecho, el suicidio como pecado fue instaurado no desde el principio del cristianismo pues, como se sabe, en sus inicios estuvo plagado de suicidas por la fe que, venerando el martirio, pensaban en que esa era la forma de salvarse y hacer que la nueva doctrina adquiriera respeto, además de conseguir estar pronto en el paraíso y dejar esta vida de penurias. Incluso los primeros padres de la Iglesia, como Tertuliano, hablaban de la muerte de Cristo como una entrega voluntaria, es decir, una especie de suicidio que, si se observan sus características, sería irrefutable. Fue hasta el siglo VI, con san Agustín, cuando se convirtió el suicidio en pecado, como una estrategia para detener la búsqueda del martirio, ya visto como un fanatismo y también por sus construcciones teológicas, claro está, sobre el cuerpo humano como un templo y en sí el ser humano como imagen y semejanza de Dios, así como la idea de que la vida es un don de Dios. También porque se considera un pecado contra el mandamiento de "no matarás". De tal manera que para el Concilio de Toledo del 693 ya se habían negado los ritos funerarios por parte de la Iglesia a los suicidas y se había dictado la excomunión a los que lo intentaran. En la literatura aparece desde Dante, cuando describe el séptimo círculo del infierno, donde por debajo de herejes y asesinos están los suicidas.

Para la teología moral moderna, el suicido sigue siendo un pecado grave, más no imperdonable, es decir, sigue siendo algo que contradice el regalo de la vida, que solo otorga Dios; sin embargo, el perdón de los pecados, que también solo lo otorga Dios, no es por el tipo de pecados, sino por la aceptación de la gracia, de conservar la relación salvífica de Dios, o sea, de confiar en la misericordia de Dios. De ahí que hay formas más compasivas, en algunas corrientes religiosas dentro del catolicismo o el protestantismo. El asunto de la religión sé que sería una discusión más amplia y se abordará un poco en otro capítulo.

En épocas posteriores, el Estado imponía en algunas ocasiones la cárcel para el que intentaba, sin conseguirlo, darse muerte; y para el que sí lo lograba, el decomiso a los sobrevivientes de los bienes del difunto, eliminando la vieja costumbre de la desacreditación pública del suicida y la demolición de sus bienes.

En esta actitud se puede observar cómo se castiga a los otros —la familia— del crimen del suicidio, descargando en ellos la culpa, como si la decisión del darse muerte hubiera sido efecto de su entorno. Los sociólogos estarían de acuerdo con esto.

Esta práctica dejó de efectuarse, no porque la ley cambiara, sino porque los jueces y magistrados dejaron de querer aplicarla, pareciéndoles injusto el castigo a la familia que ya de por sí podía quedarse sin el sustento principal, y arrebatarles lo que les correspondía como herencia resultaba cruel.

Así, se comenzó a exculpar el suicidio. Afortunadamente para los jueces en tal dilema, apareció un estudio de Robert Burton llamado *Anatomía de la melancolía*, en 1621, con el que, después de haber sido un pecado, luego un crimen legal, el suicidio se convirtió en una enfermedad del alma o de la mente, y la ley tuvo entonces el pretexto para rechazar la responsabilidad de la familia y del mismo sujeto suicida sobre el acto: *non compos mentis*. Por su parte, Sir Henry Moudsley trata al suicida como un enfermo que supone peligrosidad para uno mismo y para los demás.

Una vez quitándole el control al suicida, es inimputable. Sin embargo, no deja de ser un acto negativo que solo un hombre loco podría llevar a cabo; es decir, no se ve en el suicidio —o su intento— un acto voluntario y en plena conciencia del mismo, según las autoridades en salud mental.

Edwin Shneidman dice:

> Cada suicidio es una acción del dictador o emperador de tu mente. En cada suicidio, la persona está siendo mal aconsejada por una parte de la mente, el círculo privado de consejeros, quienes padecen un ataque de pánico temporal y no se encuentran en disposición de servir los intereses a largo plazo de la persona. (Szasz, 2002, p. 112)

Como primera impresión, esta idea no parece tan ajena al inconsciente freudiano. El hecho es que el impacto de este pensamiento servía de salida para no ejecutar la condena acostumbrada. Ya se verá que sostener esta afirmación tiene otras consecuencias no tan diferentes, como ser encarcelado o decomisar bienes.

Considerar al suicida como un enfermo mental, que de sobrevivir debe ser enviado a tratamiento, no cambia en mucho la reclusión de la persona, además de que, en estos casos, el tratamiento no es a voluntad del enfermo, pues se le quita el derecho a decidir. Como se ha visto en la historia, un enfermo mental es considerado un alienado sin la capacidad de elegir.

Dejando a un lado las cuestiones moralistas y/o legales, algunos pensadores lo han defendido y planteado incluso como una de las obligaciones o problemas únicos de la filosofía. Lo han nombrado como el acto filosófico por excelencia, pues consideran a la filosofía como aquella que busca el saber sobre el ser y lo único cierto en el ser es la muerte.

Algunas culturas incluso veían la muerte voluntaria como un acto glorioso para mantener el espíritu guerrero, como una salida honrosa para evitar sufrimientos. Así, fue vista por ellas como negativo el esperar pasivamente la muerte. Esto se puede ver en el seppuku oriental y en los suicidios mayas, que se hacían en una especie de veneración a la diosa del suicidio, Ixtab, cuyo rol era el psicopompo, es decir, guiar a las almas —también se le llamaba la divinidad de la horca—; o los ideales hedonistas de ver la muerte como un placer, más que como algo desagradable.; y también están los múltiples ejemplos en la mitología, donde la muerte voluntaria tiene más motivos nobles que otros.

En México también tenemos la Leyenda de los Soles que tiene que ver con el sacrificio de los dioses en Teotihuacán para dar vida al quinto sol:

"Por medio del sacrificio y muerte de los dioses, el Sol tenga movimiento. Si no hay movimiento, no habrá día y noche" (Matos, 2021, p. 262).

En el Romanticismo del siglo XIX, el suicidio era un acto ideal, precedido por la influencia del *Werther* de Goethe o la muerte espectacular de Chatterton. En general, en la literatura se pueden encontrar vastos ejemplos sobre la aceptación y la tendencia de los escritores hacia el suicidio, una salida honrosa que aseguraba la vida eterna en la parcela de los artistas recordados.

En el arte, el suicido pasa también por la época del Dadaísmo, donde no había necesidad de razón alguna para cometerlo o no, simplemente, si resultaba de un acto que rompiera con el orden, entonces era oportuno hacerlo. "Para los dadaístas, el suicidio habría debido ser un simple chiste lógico, si hubieran creído en la lógica. Como no creían, preferían que el chiste fuera levemente psicopático" (Álvarez, 1999, p. 289).

En la época de los racionalistas, el suicidio, aunque ya no como un acto de valentía amorosa, sí se defendió, pero esta vez desde argumentos como los planteados por Hume. Ya para el siglo XX no se habla más del Romanticismo, sino más bien de una imposibilidad de pensar en un mañana; dadas las circunstancias, la guerra y postguerra, fue difícil cavilar en cómo ser recordado por la humanidad y, más bien, si habría una futura humanidad era la cuestión. "El crecimiento de la tecnología moderna ha vuelto absurda la propia muerte, reduciéndola a un suceso fortuito del todo desvinculado del ritmo interno y la lógica de las vidas destruidas" (Álvarez, 1999, p. 289).

Lo cierto es que, al parecer, quien decide morir no es porque desee sufrir; por el contrario, desea dejar de sufrir, dejar de ser. "Hay entonces entre la desesperación y el suicidio un vínculo inmediato, directo, la única solución, que es la ausencia de solución. Un desesperado no puede tener necesidad sino de matarse" (Jankélévitch, 2004, p. 93).

Los filósofos preguntan por qué no habría de ser valiosa la decisión de morir cuando se sabe que la vida es terrible o ya no tiene manera de mejorarse. Es, pues, la única libertad que posee el sujeto. Hume dice que, si es permitido intervenir para resguardar la vida, debe ser igualmente permitido lo contrario, sin que por ello sea más criminal el último acto que el primero:

> Si el disponer de la vida humana estuviera tan reservado a la esfera del Todopoderoso que el que los hombres dispusieran de su vida fuera traspasar los límites de su derecho; sería igualmente criminal actuar para la preservación de la vida como para su destrucción. (Hume, 2002, p. 183)

Schopenhauer afirma, después de reconocer que la muerte es lo que más asusta al ser humano, que el suicidio debe ser una decisión que atraviesa lo más temido para el sujeto y, por lo tanto, debe ser porque la vida representa un peligro u horror peor.

No podría afirmarse si el suicidio es un efecto de la modernidad o un síntoma, pues, aunque se puedan observar más conductas autodestructivas, más suicidios o más guerras, tal vez es simplemente que antes no se escribía sobre ello o no se tenía el acceso a la información de lo que sucedía en el mundo como ahora.

El suicido es algo no tan extraño o sorprendente pues, como ya se había señalado, existe la tendencia de regresar al inicio, pero no sería esto lo que se persigue en primera instancia, aunque al hablar del inicio exista una fuerte tendencia a pensarlo como el seno materno, y no resulta raro, entonces, que se asocie a la madre y a la muerte como metáfora del inicio y el final encontrados en el mismo punto.

Se podría decir que no es solo una cuestión de pulsión de muerte lo que se juega en el suicidio, no es una búsqueda de la muerte por la muerte misma, sino que es un deseo de otra cosa que esta vida: "Creo que ningún hombre se ha deshecho de la vida cuando valía la pena conservarla. Porque tan grande es nuestro horror natural por la muerte que los pequeños motivos jamás serán capaces de reconciliarnos con él" (Hume, 2002, p. 188).

Camus, por su parte, lo dice así: "Matarse, en cierto sentido, y como en el melodrama, es confesar. Es confesar que se ha sido sobrepasado por la vida o que no se comprende esta" (Camus, 2005, p. 17). Es un acto que tiene justificación y que proviene de lo racional del hombre. Es confesar el fracaso, como el divorcio. O el Échec, como lo dice Améry.

Le parece más lógico aquel que puede decidir sobre su propia vida y matarse que aquel que vive sabiendo que morirá, pero dejando a algo más la decisión, como si fuera un condenado a muerte. Es así como el suicida es un rebelde o aquel que se contrapone al orden universal, por llamarlo de

alguna manera. Incluso se podría decir que es aquel que deniega lo inevitable. Al respecto, Camus (2005) dice: "Se trata de morir irreconciliado y no de buena gana. El suicidio es un desconocimiento" (p. 17); se podría agregar, de ese orden establecido por la vida en el que se tiene la certeza de morir, pero en el que no se puede decidir ni la manera ni el momento. Un desconocimiento de la obligación a vivir:

> Aun antes de que se le pregunte, el que busca la muerte voluntaria grita: ¡No! O dice, con voz bronca: se debe, quizás, pero yo no quiero, no me doblego ante un deber que se me impone angustiosamente desde fuera como ley de la sociedad y desde dentro como *lex naturae,* ley que, sin embargo, ya no quiero seguir reconociendo. (Améry, 1999, p. 24)

El suicidio, si ha estado prohibido, si se le ha adjudicado como pecado, es también porque es un acto de desvinculación del otro, sea quien sea, el padre o Dios. Es, en otras palabras, el pecado de la separación, del abandono. Por tanto, es una acción deliberada y no accidental, con las variantes quizás de la anorexia, la resistencia o la interrupción de tratamiento médico.

Explicar por qué alguien se suicida puede llevar años de estudio, de entrevistas, etc. Definitivamente, es una labor a ciegas. Lo que sí se puede hacer es suponer o especular en que el desarrollo o las causas tienen múltiples variables. Es como con el autor de una obra: no puede limitarse ahora la comprensión a solo lo que pretende decir con ese acto, sino que hay que ver su contexto, su historia, lo que dice, pero sobre todo lo que no dice en ese acto. ¿Y en común? Podría afirmarse tal vez que siempre es una decisión, que es una acción a futuro, una especie de anticipación, ¿"una red de seguridad existencial"? (Szasz, 2002, p. 57). Pero es una anticipación a algo que, de por sí, no se sabe qué es o no hay posibilidad de recreárselo, convirtiéndolo en algo más claro que es la muerte. Es darle la espalda a la vida, pero también a su lógica. Al orden del discurso.

Así como, toda muerte voluntaria es una decisión individual, personal, que, no obstante, tiene una afectación social, no en tanto el grupo como su causa, pero sí en cuanto que es ir en contra de la misma. Los sociólogos, la religión y muchas líneas de pensamiento afirman que es un acto social y que

incluso afecta a la sociedad. Tal vez será en el punto en que la cuestiona, o mejor dicho la confronta con un no estar en ella.

Aunque se pudiera hablar de que el suicidante es el que sabe de la muerte, sería también un equívoco, pues no puede saber quién ya no es. La muerte, además, es una negación en sí misma. Sí se puede saber de la acción o del "acto". De vivir y de morir. De la afirmación del ser, aunque sea en pasado —aunque el ser desconoce su negación y no es el opuesto a la muerte. No del *estar*, sino del *fui* o *era*, que se acerca más al *ser* que el *estar*, estrictamente hablando.

Durkheim (1994), el sociólogo, intentó dar una explicación a través de la estadística para favorecer un sentido científico a las causas del suicidio, para desligarlo de la enfermedad mental, de la connotación de delito, del alcoholismo, de la raza, de la imitación. Encuentra relación con las horas del día, diciendo que el suicido se da más en horas y días de mayor actividad social.

Por otra parte, también revisa la influencia de la religión en el suicidio, tomando aquella que está más preservada como la que convoca a una sociedad más integrada. "La fuente del malestar no se ubica en la religión ni en las angustias existenciales o metafísicas, sino en la misera fisiológica del cuerpo social" (Bartra, 2021, p. 200); también ve en el suicidio altruista una falta de individuación, por ejemplo. En lo que respecta al estado civil y la edad de las personas, también tiene que ver más el hecho de que sea una familia integrada o que existan hijos.

En general, Durkheim propone como conclusión que el suicidio es un hecho social, no personal, sino producto de las costumbres, de las ciudades, del movimiento social; así, es posible analizarse y preverse tal como la ciencia requiere. De esta manera, el suicido como hecho social es un mensaje de que el grupo al que se pertenece no está del todo bien, lo cual no significa que a partir de las explicaciones de Durkheim y la demostración del fenómeno como producto o síntoma de la sociedad se ha podido prevenir; por el contrario, se sabe que es uno de los actos que menos se evita mediante las campañas que lo intentan, y hasta parece que tienen el efecto de estimularlo, sin devaluar algunos intentos que aparentemente hasta hoy en día sí realizan acciones importantes con respecto al suicido, tal como lo que hace el grupo llamado Los Samaritanos. De ahí en más, es trabajar por eliminar un síntoma y no el problema, si es que se pudiera considerar proble-

ma. Sobre todo, cuando se sabe que es una decisión racional, y que quien se quiere suicidar, lo hará con, sin o a pesar de los demás. Como un hecho social donde el otro no logra ser un sostén para el que se quiere suicidar, "no es que el otro no existe, sino que el otro no alcanza ni pulsionalmente ni simbólicamente para que sea un semejante" (Ferreyra, 2012, p. 19).

Bartra analiza algunos hechos históricos, sobre todo de guerras, que para él podrían ser ejemplo de colectivos suicidas; más allá de los grupos que, de forma literal, se suicidaron por supuestas causas religiosas o por la manipulación de líderes "religiosos", están estos movimientos bélicos que han llevado a naciones a resquebrajarse. Entonces, se pregunta: "¿Puede pensarse que una revolución o un golpe de Estado tienen peculiaridades suicidas?" (2021, p. 204). Esta pregunta lo lleva a reflexionar si no es por la decadencia de los grupos sociales que existe la posibilidad de ser influidos por estos líderes políticos populistas que aprovechan estas tendencias suicidas y son llevados a la guerra, a la autodestrucción o a la violencia contra otros.

Este asunto de que tenga que ver el grupo social en el que está inmerso el sujeto y que por tanto sea más o menos responsable de los suicidios también fue pensado por Karl Marx, evidentemente al revisar los estragos de las formas económicas que crean desigualdad e injusticias. Para él, el suicidio es un resultado, y en 1846 publicó un texto sobre suicidio, a partir del informe que realizó un archivista de la policía de París, donde usa algunos casos de ejemplo para poder dar sentido a sus ideas.

En la introducción, el presentador que retoma este texto de Marx (1846/2012) dice:

> Una sociedad no solo se conoce por sus logros, sino por sus víctimas. Todos aquellos cuya percepción de sí mismos, de lo que son y de lo que podrían ser desacuerda trágicamente con la experiencia de eso que es su vida. Eso presenta Marx en estas páginas. Historias de personas que, atrapadas por lazos sociales que los sepultaban y los sepultaron, no podían saber lo que valían. Y si lo sabían, no podían demostrarlo. (p. 43)

Y así pueden leerse los registros de algunos casos, donde esta decisión de suicidarse está permeada por las expectativas sociales, las costumbres

que vuelven insoportable la vida para algunos. "El suicidio no es más que uno de entre mil y un síntomas de la lucha social general" (1846/2012, p. 72). Pues para Marx es esta necesidad de liberarse del yugo de la imposición social, de los ideales y las buenas costumbres.

"Viendo todo esto, cuesta ver cómo podría ordenarse al individuo que respete, en sí mismo, una existencia que no es tenida en cuenta por nuestras costumbres, prejuicios, leyes y modo de vida" (Marx, (1846/2012, p. 70). Así, hemos visto en las crisis sociales el fenómeno del suicidio, como lo fue en la pandemia, cuando se evidenció la desigualdad social y, ante la incertidumbre del tratamiento efectivo, muchos prefirieron decidir por su cuenta. No es de extrañar que en las guerras suceda, pero también en sociedades donde hay más exigencia, en sentido económico, pero también en otros, como lo que tiene que ver con la imagen corporal o el significado del éxito, o el ganarse muchos *likes* para sentirse vistos. En este enunciado de Marx también pueden reconocerse las llamadas "minorías", término que personalmente me parece ya una forma despectiva de nombrarlas.

En la introducción de su obra, se le califica a Marx (1846/2012), curiosamente, como "'masoquista moral', con una tendencia suicida inconsciente que se verifica en el suicidio de sus hijas, posterior a su muerte" (p. 31), en tanto que no tomaba sus medicamentos. ¿Cuántas veces no hemos sabido de esas historias en las que el fantasma del suicidio recorre familias enteras, atraviesa generaciones, unos lo cumplen, otros no, o no de la misma manera? Así como lo que trabaja Mirta Pipkin sobre los Lugones. Cierto, no cualquiera escribe sobre el tema, tiene su atracción.

La psicología, por su parte, no se hace a un lado de tratar de cientifizar todas sus explicaciones sobre la conducta humana, sin embargo, hay quienes han reducido el suicidio a un problema de autoestima o de heridas de autoestima. Con esto, el tratamiento posiblemente resultaría exitoso. El asunto está en que, al parecer, la mayoría de los trastornos giran alrededor de la baja autoestima o de una compensación ante esta. La psicología se ha adherido a los temas de salud pública, por tanto, con una visión patologizante para darle un tratamiento y tener entonces una posibilidad de cura del síntoma. Más adelante retomaremos la intervención de la psicología y la posibilidad de la prevención del suicidio.

Lo cierto es que aquello que lleva a la muerte voluntaria es complejo, y en cada sujeto seguramente distinto. Ya se decía que era de una lógica diferente, más parecida, dice Álvarez, a la de la pesadilla. O en todo caso, un despertarse de la pesadilla que ya no se tolera seguir soñando. Y en un intento por encontrar cosas en común, dice que el suicidio se convierte en una obsesión, no tanto ya el resultado, sino los medios, "así como el fetichista goza más con sus ritos que con el orgasmo que le procuran" (Álvarez, 1999, p. 165). No es de extrañarse que sea inamovible la forma en que se ha decidido morir.

Para Jean Améry (1999), "El échec, sin embargo, existe como una amenaza latente en el fondo de toda existencia y de una manera más evidente que la muerte" (p. 51); es decir, no es tanto la tendencia a la muerte por sí misma lo que conduce a ella, sino lo que le precede, esa sensación de fracaso o de desgano, eso que conforma también la obsesión por los medios. Por eso no ha de pensarse que aquel que desea suicidarse está libre del miedo.

Laura Emilia Pacheco (2021) escribe: "Dice Emil Cioran —siempre Cioran— que no vale la pena suicidarse porque uno siempre se suicida demasiado tarde" (p. 254), puesto que ya se sufrió demasiado cuando se llega a tomar esa alternativa.

Este perfeccionismo por las formas puede llevarlos incluso a simplemente pensar todo el tiempo en el acto, sin que por ello lo cometan. También se podría considerar, como ya se dijo, a quienes lo hacen de manera lenta o crónica, como los anoréxicos, los alcohólicos o drogadictos; y están quienes buscan la muerte sin saberlo, a través de conductas de riesgo.

Tal pareciera que el suicidio es una forma de salirse o apaciguarse, que existe además de la locura. Una especie de búsqueda de libertad. Si fuera producto de una pulsión, como parte del ser humano, simplemente habría que dejarse llevar, pero es una elección, pues se está en contra de algo más fuerte que tal pulsión.

El suicidio, la medicina y la escuela

Hoy en día, sin embargo, no es un juez quien dice qué tan malo es el intento de suicidio, sino un médico quien lo hace y quien ofrece una solución al

"deprimido" mental. El suicidio y/o el intento de suicidio constituyen un alto porcentaje de las urgencias psiquiátricas (Garmendia, 2013).

Cuando se asocia al fenómeno de la depresión, no es tan simple, quien la padece lo sabe, lo vive, como dice José Woldenberg (2021): es una especie de *brainstorm,* tempestad, tormenta en el cerebro, que no siempre termina en suicidio. Efectivamente, puede existir ideación suicida, pero no es lo único, es un sinfín de pensamientos, fantasías, ideaciones que se acumulan y atacan, que pueden inhabilitar tanto a la persona que no hay posibilidad de la ejecución de un suicidio. El escritor William Styron afirma: "Si la depresión no tuviera término, el suicidio sería, ciertamente, el único remedio" (Woldenber, 2021, p. 94), cuando es retomado por Woldenberg para ejemplificar cómo la depresión puede ser terrible y la escritura, de alguna manera, funciona para menguar sus manifestaciones. Es decir, la depresión no siempre termina en suicidio si es tratada adecuadamente, pero pensar que todo el que se suicida está deprimido tampoco es tan cierto.

Se habla del suicidio como un asunto de salud mental, es decir, relacionado con trastornos mentales, como se presenta en los documentos de la OMS, en los cuales se relaciona con varias patologías; sin embargo, tiene que ver con mirar al síntoma como la causa y no como la manifestación, pues patologías como el estrés postraumático, el trastorno por déficit de atención, la depresión, la ansiedad y cualquier otra que se pudiera mencionar y relacionar son esos cuadros sintomáticos, son un listado de condiciones, como indica el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM), pero no se mencionan las causas. Así, se podrá medicar para disminuir la ansiedad, como una manifestación orgánica o biológica que tiene que ver con aceleración cardiaca, sudoración, palpitaciones, estupor y sensación de falta de aire, pero ahí no se trata lo que da pie a todas esas sensaciones. Cuando se ha asociado el suicidio a trastornos mentales más graves como cuestiones psicóticas, es el mismo tema de disminuir con medicación la posibilidad de alucinaciones y de sensaciones extrañas.

Entendemos entonces que es el médico ahora, quizás mayormente el psiquiatra, quien tendrá la solución para el tratamiento del suicidio, pero asociar este fenómeno a trastornos mentales es un tanto desresponsabilizar al sujeto, puesto que, si tiene ideación, intentos o logros de suicidio, será por un trastorno mental que padece, porque está enfermo, no porque lo quiera

claramente; es decir, tiene una "visión de túnel" propiciada por la enfermedad mental que lo hace tomar decisiones equívocas.

El psiquiatra Jesús Ramírez-Bermúdez dice que la conducta suicida puede ser producto de una patología. En un caso que ejemplifica, se refiere a un virus herpes simple que puede inflamar el sistema nervioso y llegar a destruirlo si no se da el tratamiento adecuado, provocando pérdida de sentimientos, familiaridad con el mundo y con uno mismo; entonces, menciona que "induce impulsos suicidas, pero estos no revelan, forzosamente, un deseo estable de morir, consistente con los valores más auténticos del enfermo: más bien son estados transitorios" (Ramírez-Bermúdez, 2021, p. 171). Entonces, para él no sólo hay trastornos mentales asociados, sino también patologías físicas.

En esto vemos claramente que, cuando hay una enfermedad física que pudiera provocar intenciones de morir, que contradicen lo que supuestamente la persona en salud completa no tendría, hay una desresponsabilización de la ideación. ¿Puede una enfermedad física provocar algo tan opuesto a lo que siempre se ha querido o es que devela algo que yacía en el fondo de la persona?

Este mismo autor dice que, aunque los suicidios se asocian, principalmente a depresión mayor, sólo el 4% de las personas con esa patología se suicidan. Ya otros pueden preguntarse qué hacen las instituciones como los hospitales, clínicas o quienes reciben las llamadas de alerta ante estos fenómenos, pero faltaría ver qué hacen quienes conviven el día con día ante esto, no solo las familias, sino la escuela, que representa la segunda casa, y sobre todo saber que las opiniones o actitudes a veces no enunciadas, sino actuadas, pueden estar sirviendo como protectoras o produciendo el efecto contrario.

En una investigación realizada en 2013, se solicitó a 15 escuelas de bachillerato de San Juan del Río, Querétaro, contestar algunas preguntas sobre si tenían protocolos de atención ante amenazas de suicidio o cuando ya hubiera pasado algún suicidio dentro de su comunidad, cuáles eran las medidas que se tomaban para evitar un contagio o simplemente cómo abordarlo con el resto de la comunidad. Sólo cinco instituciones aceptaron contestar. "De las cinco instituciones que participaron en la investigación, una cuenta con un protocolo de actuación ante el suicidio

establecido; las cuatro instituciones restantes tienen las nociones y métodos de actuación, sin estar formalizado en documentos oficiales" (Valadez y Ortega, 2019, p. 48).

Entendiendo con esto que se veía en aquel entonces que el suicidio era algo aislado o para lo cual no necesariamente había que estar preparado, aunque la mayoría de las escuelas considera tener atención psicológica, se ve al suicidio como un tema del estado de ánimo y las emociones que podría ser prevenible si se ven las señales de que algo así está en riesgo de suceder.

En síntesis…

Se ha visto cómo la muerte y el suicidio, desde sus intentos por conceptualizarlos y la vivencia de ambos, han estado impregnados de los efectos de la época en que se vive. Así, han pasado por muchas formas de enfrentarse. En el caso de la muerte, cómo ha ido, de ser considerada un bien deseado, hasta convertirse en algo despersonalizado, fuera de la familia, tema incluso tabú o que se quiere evitar lo más posible. Producto de la época actual moderna, se traslada la muerte al hospital, al ámbito de lo individual.

Por otra parte, el predominio de la razón, como signo de la modernidad, ha querido ahondar sobre la única experiencia que todo ser humano atraviesa; sin embargo, no se pueden tener evidencias de lo que es, ni por lo observado ni por lo especulado, pues no se le puede dar un grado de ser. Lo cierto es que sucede violenta e inevitablemente, irreversible. Es un misterio que hasta hoy no se ha aclarado.

La única forma de intervenir con respecto a la muerte es provocándola, por ejemplo, con el suicidio. Tal es la relación entre lo más propio del hombre, como lo es la muerte y el suicidio, que también comparte ese movimiento en el pensamiento de la humanidad a través de la historia, siendo aceptado, ensalzado y otras veces rechazado, y las más de ellas incomprendido. Sea o no una decisión bien pensada, los que sobreviven no tendrán claro lo acontecido en el sujeto que decide terminar con su vida.

De tal manera que la muerte y el suicidio están rodeadas por una marea de cuestionamientos, de incomprensión, de prejuicios, de acercamientos y especulaciones, pero no de certezas, y mucho menos de objetividad. Ni las

ciencias naturales, la religión, el derecho, la filosofía, la antropología y/o la medicina han podido responder del todo a lo que son la muerte y el suicidio.

Al reconocer que es algo tan perteneciente al sujeto, la muerte es por tanto algo que tiene que suceder, y una de las maneras más cercanas de explicarlo es que la muerte, como ese estado de inmovilidad, es algo que antecede y prosigue a la vida.

Ahora veamos cuáles son las propuestas de prevención y/o tratamiento del suicidio que existen desde la psicología o algunas otras disciplinas que se conjugan con este esfuerzo.

2. Propuestas de prevención y tratamiento

Deseó con todas sus fuerzas que ella viviera y al mismo tiempo se preguntó qué significaba aquello. Había sentido una especie de arrinconamiento vital cuando ella había querido echar por la borda su vida de ese modo.
Han Kang

Hay, dentro de las nuevas explicaciones, el llamado "enfoque ecológico del suicidio", en el que obviamente se habla de multiplicidad de factores de riesgo para el suicidio. Esto ya se abordó en el apartado anterior desde la Sociología, es decir, el contexto como situación económica, los lazos sociales, la cuestión laboral, la vivencia de experiencias graves en la infancia, pero también la predisposición a enfermedades físicas, así como la disponibilidad de las herramientas para quitarse la vida; todo ello se agrava por la existencia de una patología de las mencionadas por el DSM, como lo decíamos anteriormente, por ejemplo, el abuso del alcohol o sustancias psicoactivas combinadas con la depresión o algún otro trastorno afectivo. Uno de los trastornos también asociados fuertemente es el de control de impulsos. Este enfoque apuesta a pensar que el trastorno mental no va solo como causa, sino que se unen varias condiciones, incluso entre los mismos trastornos; por ejemplo, la depresión puede propiciar conductas adictivas, pero también el uso de sustancias puede causar o agravar un estado afectivo, sumado con otras situaciones, como falta de alimentación nutritiva, alguna enfermedad física, relacionando también cuestiones sociales, rupturas amorosas o aislamiento, así como problemas laborales y carencias económicas que pueden tener como consecuencia el poco acceso a un sistema de salud que pudiera ayudarle.

No hay que olvidar que dentro de los datos estadísticos habrá sustancias que representan un mayor riesgo, por los efectos y el daño en general que tienen en los organismos, no solo por la intoxicación del momento, sino

también por el consumo continuo y prolongado, por ejemplo, las metanfetaminas y el cristal.

Al mencionar, sobre todo, el asunto de las adicciones, existe la intención por parte de la OMS para dar un tratamiento a las adicciones pues, según sus datos, disminuye el 50 por ciento de riesgo de suicidio. Entonces, este enfoque ecológico dice: "La evidencia indica que las personas que cuentan con más habilidades sociales y de vinculación, así como aquellas que tienen redes de apoyo familiar y comunitario, presentan menos pensamientos antisociales o conductas suicidas" (Rendón, 2021, p. 147).

La Dra. Eunice Rendón, apoyando este modelo, sobre todo en relación con los peligros de la era digital, que aumenta el riesgo de suicidio, indica que el uso de las redes sociales agrava la ideación suicida porque expone, sobre todo, a niños y adolescentes a riesgos de ver contenido no deseado e inapropiado, incluidos temas de suicidio y autolesiones, así como establecer relaciones con personas incorrectas o peligrosas y propiciar conductas psicopáticas.

Para la Dra. Rendón (2021), la violencia a distancia tiene consecuencias más graves puesto que "recrudece la agresión de quien las comete al no ver la reacción inmediata de la víctima ni el daño directo que puede ocasionar" (p. 151). Esto, al formarse una fuerte dependencia a la aceptación virtual, genera sensaciones de desesperanza y soledad. Entonces, evidentemente llama a que los adultos estén más presentes en el uso de estos medios digitales o realidades virtuale,s para poder detectar los riesgos, pero también, dentro de su propuesta para atender la prevención del suicidio, primero es considerarlo como problema de salud pública, y con ello dejar de estigmatizarlo, para evitar el subregistro, dado que ese es justo un gran problema que sucede con los suicidios: no están todos registrados, porque sigue siendo un tema tabú, un tema difícil de aceptar para muchas familias el que uno de sus miembros haya muerto de esta forma.

Como se mencionaba anteriormente, en México se ha establecido ya una ley que implica al suicidio como un problema de salud pública, aunque no en todas sus entidades se haya especificado o se haya atendido esta ley general. Pero con esta legislación se creó el Consejo Nacional para la Prevención del Suicidio, con lo que es de suponer que hay un presupuesto para ello.

Este modelo ecológico que planteamos aquí es justamente en el que se basa la OMS para presentar estrategias que incluyan a los sistemas de salud, la sociedad, la comunidad y la esfera individual:

> Recomienda políticas de salud mental en las que contempla el combate a las adicciones y el uso nocivo del alcohol con el fin de reducirlo, el acceso a los servicios de salud, la restricción de medios letales, el reporte responsable de los medios y la concientización de la importancia de la salud mental y la prevención del suicidio… líneas de auxilio, intervenciones para grupos vulnerables, el entrenamiento de guardianes de las comunidades… seguimiento y el apoyo comunitario, la evaluación y el manejo de conductas suicidas, de los trastornos mentales y del uso de sustancias. (OMS, en Medina-Mora y López, 2021, p. 192)

Por eso, la OMS ha publicado no solo el primer informe del 2014, sino algunos otros documentos al respecto; particularmente ha echado a andar campañas de prevención en las cuales maneja frases impactantes *(slogans)* que inspiran la comprensión de quienes están pasando por momentos terribles y consideran como posibilidad el suicidio.

Especialmente, ha publicado una guía para prevenir el suicidio, llamada *Vivir la vida*, en la que recomienda lo siguiente:

- Restringir el acceso a los medios utilizados para suicidarse (por ejemplo, plaguicidas, armas de fuego y ciertos medicamentos).
- Educar a los medios de comunicación para que informen con responsabilidad sobre el suicidio.
- Fomentar aptitudes socioemocionales en los adolescentes.
- Detectar a tiempo, evaluar y tratar a las personas con conductas suicidas, además de hacerles un seguimiento. (OMS, 2025)

Esto, también de la mano con la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio, quien, en su página, promueve el cambio de la "narrativa" sobre el suicidio:

> Hemos desarrollado una gama de actividades y recursos para garantizar que todos puedan participar de forma significativa. Tanto si está empezando a aprender sobre la prevención del suicidio como si está muy involucrado en la defensa de derechos, existen oportunidades para que contribuya y apoye esta causa vital. (Asociación Internacional de Prevención del Suicidio, s/f)

Ahí lo que ofrecen son paquetes de información con actividades o estrategias para diferentes actores, como las comunidades, los individuos, las organizaciones y el gobierno, todo para realizar la campaña de prevención.

Por parte de la psicología, que principalmente atiende la ideación suicida o los intentos suicidas relacionados con crisis o psicopatologías, hay algunas propuestas para el trabajo. Partiendo del Modelo Cognitivo Conductual, que se ha dado paso como una opción muy práctica, rápida y aparentemente resolutiva de muchas problemáticas psíquicas, también se ha enfocado en el trabajo con este tema, en el que, como en su enfoque plantea, se centrará en las distorsiones cognitivas y las habilidades de resolución de problemas.

Hay un protocolo para el tratamiento de adolescentes suicidas, propuesto por Wenzel, Brown y Beck del 2009 (Suárez, 2023, p. 61), que trabaja en tres fases: temprana, intermedia y posterior. La particularidad de este protocolo, a diferencia del tratamiento con adultos, es el involucramiento de la familia.

La Terapia Cognitivo Conductual se enfoca en el involucramiento del paciente en el tratamiento, desde que se intenta reconocer cuáles son los pensamientos que están detrás de los sentimientos y que pueden producir las conductas; con este enfoque tridimensional, se observan además las habilidades o estrategias que se han usado o que se podrían usar para afrontar las problemáticas, además de contar con un plan de seguridad.

Hablaremos de esto último, pues digamos que es lo central ante una crisis, adaptado en 2012 por Stanley y Brown:

El primer paso es observar las señales o signos de alarma y ver si se cuenta con las herramientas que van de lo más inmediato o sencillo hasta lo más complejo y externo: estrategias de afrontamiento interno, de socialización para distracción y apoyo, contactos que puedan ayudar a resolver la crisis suicida, contactos de agencias y profesionales que ayuden a resol-

ver la crisis suicida. A todo esto, se agrega la restricción de los medios de riesgo suicida.

La fase intermedia tiene que ver con el fortalecimiento de las razones para vivir y la mejora de sus relaciones familiares; dicho de otro modo, de fortalecer sus medios para la sobrevivencia. La fase posterior tendrá que ver con observar qué estrategias funcionan más, las habilidades que se establecieron para poder evitar recaídas.

Dado que la terapia cognitivo conductual hace énfasis en un entrenamiento, en este caso, de acuerdo con modelos breves de esta terapia, es un "entrenar a las personas para desactivar lo que ellos llaman modo suicida" (Santillán, 2023, p. 121), partiendo de la idea de que hay tres elementos a considerar:

1. Una predisposición genética, o mejor dicho, una "vulnerabilidad" genética hacia la depresión, lo que intensificaría la tendencia al suicidio.
2. Estar expuesto a eventos estresantes o traumáticos.
3. Impulsividad.

Estos se activarían al estar en una crisis, y entonces es lo que se intentaría desactivar en las 12 sesiones tipificadas para los tratamientos breves. ¿Cómo intentan lograrlo? Lo que impulsan es la autobservación de detalles, cognitivos, emocionales y conductuales, la triada con la que trabajan estos modelos. Identificar los detalles, las señales, para poderlos desactivar.

Por otra parte, está también el enfoque de solución de problemas basados en la emoción, para centrarse más en el sentimiento que prevalece ante el cúmulo de pensamientos negativos, que nombran como "desesperanza individual" (Santillán, 2023, p. 125), teniendo un plan de seguridad, con lo mencionado ya anteriormente, de estrategias internas y externas para pasar la crisis.

Además, existe la terapia dialéctico conductual para autolesiones no suicidas. La diferencia con las estrategias anteriores es la comprensión, "a diferencia del enfoque de la psicoterapia cognitivo conductual, más orientado a controlar, reducir o eliminar conductas, síntomas físicos o cogniciones" (Santillán, 2023, p. 129). Aquí hay que instar a la comprensión, a la autoaceptación de características con las que tendrá que aprender a vivir, lo

que llaman "aceptación incondicional", cosa mencionada desde tiempo atrás por Rogers para la terapia centrada en el cliente.

Como una opción que se ha ido trabajando a nivel nacional en México, derivado de la propuesta de la OMS del 2014, impulsado también desde el trabajo de la Dra. Eguiluz Romo, al parecer desde 2013, está la de los Guardianes para la Prevención del Suicidio, en que forman a personas interesadas, estudiantes universitarios, para estar en los ámbitos donde pudieran detectar de manera temprana el riesgo suicida. Esto, replicando modelos de otros países.

Un elemento indispensable para esta formación es tener mayor conocimiento "sobre las bases biológicas de la sintomatología depresiva"; se les entrena en la entrevista motivacional, procurando la autonomía o independencia, o el hacerse cargo de las personas con riesgo suicida.

Estos guardianes se presentan en algunas comunidades facilitando información epidemiológica; sosteniendo la idea de que "la mayoría de las conductas asociadas al suicidio pueden prevenirse", se habla de los factores de riesgo, las señales, la literatura sobre el tema (desde su perspectiva) se discuten mitos.

La idea principal es que "las personas nos debemos cuidar unas a otras" (Santillán y Eguiluz, 2023, p. 139), pero sabiendo que las habilidades conductuales se pueden adquirir. Se aplican algunos cuestionarios para poder identificar y canalizar si es necesario.

Para el trabajo específico con niños, niñas y adolescentes, sugiero un texto argentino, obviamente tendrá sus particularidades respecto a las leyes de prevención del suicidio y la de salud mental de allá, pero no dista mucho de lo que se ha hecho en México. El texto se titula *Autolesiones y situaciones de suicidio en adolescentes*, de Kaniel Korinfeld y Daniel Levy. En el libro van paso a paso indicando lo que se realiza: el antes, durante y el después de una crisis. Hacen un repaso de las evaluaciones hechas cuando reciben un caso, una emergencia, y cómo la atención tiene que ser multidisciplinaria; por ejemplo, hablan de que, para anticiparse, desde el sentido de la prevención, se formen "mesas interseccionales" que impliquen a toda la comunidad, porque el suicidio no es tema solo de algunos. Hacen también una serie de indicaciones importantes de lo que no se tiene que hacer en ese antes, durante y después.

Hay una frase que me llamó la atención y que es con la que terminan el apartado de qué no hacer durante la crisis o emergencia: "Sabemos que es difícil aceptar que hay momentos en los que es indispensable operar incluso sin comprender, una actitud que no es exclusiva de esta problemática" (Korinfeld y Levi, 2024, p. 170). Dicho enunciado está escrito después de sugerir que no se interrogue a la persona en crisis, obviamente la información en una crisis puede estar alterada, en primer lugar, pero también es para no intentar cuestionar a la persona, que diga porqué lo hizo, desde cuando lo pensó, o sea, tratar de encontrar las causas, las señales, explicaciones que de momento no son relevantes, sino la atención de la crisis. Si la persona comenta algunas cosas, simplemente se tienen que escuchar, así, quizás sin que lo comprendamos, porque lo importante no es que lo comprendamos lo que estamos atendiendo, sino que la persona lo hable para que pueda elaborarlo.

¿Es suficiente todo esto para la prevención de los suicidios?

Podemos reconocer que hay un gran esfuerzo para la prevención del suicidio. El hecho de que la OMS haya tomado la batuta en ello es entendible, aunque lo haya hecho tardíamente. Es decir, ¿por qué a partir del 2014 es cuando brinda un primer informe? Evidentemente existía la inquietud desde antes, por lo que se decidió presentar un informe. Sin embargo, ¿qué lleva a la OMS a interesarse por el suicidio? ¿Será que se comenzó a ver no solo el suicidio, sino el tema de la salud mental, con mayor seriedad por su afección en las sociedades? ¿Responderá a otro tipo de intereses?

Seguramente recordarán que el DSM, en su edición quinta, fue muy cuestionado por la tardanza en su publicación, por las discusiones que planteó en cuanto a las modificaciones de las agrupaciones de trastornos por el agregado de trastornos, por la eliminación de algunos de ellos. Desde la crítica, llegó a pensarse como un manual hecho a la medida de las farmacéuticas y no de estudios clínicos, lo que ocasionó, a su vez, un fuerte rechazo por las clasificaciones presentadas en esta edición.

Sin embargo, la OMS y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) —encargada de la elaboración del DSM— han trabajado en conjunto desde hace tiempo para publicar sus manuales de diagnóstico de enfermedades, incluidas las mentales, obviamente.

Resulta pues que, aunque en el DSM ya se hablaba de los riesgos suicidas de algunos trastornos, fue hasta el 2014 cuando la OMS lo hizo palpable.

Pero como dicen algunos grupos, el punto a favor para todos es que se pueda visibilizar, que sea nombrado y que mueva a la intención y la implementación de estrategias para la prevención.

¿Funciona? Hasta hoy, vemos que no del todo, porque sigue habiendo suicidios. Quizás tengamos que desandar un poco el camino, donde suponemos que conocemos las causas del suicidio y que además es prevenible. Podemos pensar que hay algunos que lo son y para esos funcionan esas estrategias, funciona la terapia cognitivo conductual con sus modelos derivados, funciona el acompañamiento terapéutico, funciona la escucha.

Tal vez, como lo dijo el Dr. Juan Ramón de la Fuente sobre las adicciones, esas campañas de prevención se dan para las personas alfabetizadas, para las personas escolarizadas, pero los que no pertenecen a estas condiciones no pueden acceder a esos programas. Quizás haya quien, a pesar de todos los esfuerzos, decide darse muerte por su propia mano.

Revisemos pues, otra explicación de este fenómeno, la que proporciona el Psicoanálisis, para luego pensar si, con estas nociones teóricas y su propuesta de escucha, es posible comprender, para abordar la ideación suicida y prevenir el suicidio.

Antes de abordar la propuesta del Psicoanálisis, hablemos de lo que puede suceder cuando existe la decisión clara de suicidarse y ni todos los esfuerzos terapéuticos, familiares, sociales ni médicos hacen cambiar la voluntad, y qué se ha hecho al respecto, es decir, hablemos del suicidio asistido.

3. Suicidio asistido

Nada me preocupa ya fuera de los sordos gritos
que lanzo sobre el papel. Poseo la confianza de quien
se asume derrotado y ha decidido no buscar más,
seguro de la imposibilidad del encuentro. O mejor:
de su irreversibilidad, el asfixiante hecho que demuestra
que no tenemos otra opción que la libertad del deseo.
Jorge Cuesta

Hoy en día, no es un juez quien dice qué tan malo es el intento de suicidio, sino un médico quien lo hace y quien ofrece una solución al "deprimido" mental. Szasz (2002) lo dice así:

> Recluir a una persona deprimida para evitar que se suicide, recetar una droga letal a un paciente terminal […] son intervenciones médicas legales, pero en modo alguno son tratamientos médicos porque los síntomas que tratan no son propios de ninguna enfermedad. (p. 142)

Su labor es comparar y encontrar las diferencias entre lo que ahora es llamado el "suicidio asistido" —eutanasia— y el suicidio, lo que es, al parecer, un intento de la ley de reconocer el derecho a morir. Pero la distinción es clara: mientras que el "suicidio asistido" está relacionado con la existencia de un problema físico, derivado de enfermedad prolongada, síntomas físicos graves, enfermedad terminal, de cualquier manera, el asunto del suicidio no es físico. Por otra parte, es diferente darle a otro el permiso de matar que matarse por sí mismo.

La muerte asistida, mejor dicho, sería en todo caso darle al otro el permiso de cometer homicidio. Sea por imposibilidad física o el motivo que subyazca, es un homicidio; o bien, de la índole de un acto compartido, mientras que el suicidio es un acto solitario. Para Jankélévitch, la eutanasia no representa un problema filosófico, sino médico, que cuestiona más bien

el poder y la autoridad de este último y quien se enfrentará al "tabú" de su misión en la ciencia, que es prolongar la vida y aliviar el dolor.

Ahora, para hablar del derecho a morir, así, como un derecho, es probable que se requiera de otra discusión. El tema ha sido abordado ya, con mucha insistencia, para también lograr legalizar, como ha sucedido en algunos países. De hecho, uno de los textos que más me atrapó la lectura fue el coordinado por Arnoldo Kraus, quien falleciera hace unos meses y quien, sin duda, fue más que líder de todo este movimiento para reflexionar y legislar sobre este derecho. En el libro que coordinó sobre suicidio se presentaron muchos de los textos con esa connotación de defensa al derecho de morir. Iremos a algunos de ellos para comentar lo que indican, además de algunas otras lecturas que ya había presentado en mi propia tesis doctoral sobre el suicidio.

Hablar de que un médico tiene que respetar la última voluntad del enfermo es también enfrentarse a lo que Jankélévitch llama tabú; son asuntos intocables estos de la última voluntad, puesto que "el hombre es un ser de tiempo que puede cambiar y que, además, tiene un mal que también evoluciona" (Jankélévitch, 2004, p. 87). Por lo tanto, puede tomar una decisión equivocada en el último momento, pensando que su enfermedad es incurable, cuando dados los avances de la ciencia puede ser curable más adelante. De lo único que no se puede curar es de morir, y al firmar un permiso para que el otro lo mate se puede decir que sí está cometiendo suicidio, pero un suicidio que tal vez no ha sido razonado o bien pensado y solo provocado por la desesperación de ese instante.

Los jueces han dejado su lugar de poder (castigar o remediar) a los médicos, a la psiquiatría, y esto es un efecto de que la muerte se ha convertido en un hecho público. Perdió su privacidad al convertirse el hospital en el lugar para morir en vez del hogar.

Así, quien tiene el control de la muerte es la medicina. Se supone que el objetivo o fin último de la medicina es mitigar el dolor, cosa que se utiliza como subterfugio para la muerte asistida, aunque no se sepa a ciencia cierta quién sí deba morir o no, eso lo determina el médico, no el que padece el dolor.

Por otra parte, en el juramento hipocrático existe la prohibición clara del asesinato. Pero ya lo señaló Freud, no se prohíbe aquello que no se desea o se ha hecho:

> Las autoridades —sacerdotes, políticos, médicos— siempre han ostentado el poder de matar y no han dudado en emplear este poder, en su propio interés. Lo que les horroriza a las autoridades es que las personas se puedan quitar la vida por sí mismas, puesto que reconocen (acertadamente) en esta acción una rebelión individual contra la autoridad y una afirmación de la autonomía personal. (Jankélévitch, 2004, p. 173)

Así que lo contrario, es decir, legalizar el suicidio, sería poner en manos del Estado o del médico la decisión por la muerte, pues serían ellos quienes determinarían quién sí puede suicidarse y quién no.

Como ha sucedido, según Michael Foucault, con el resto de las minorías sociales — ¿o sería más adecuado llamarlas objetos del racismo?—, han sido reconocidos sus derechos por el Estado después de intensas luchas: los indígenas, los negros, las mujeres, los homosexuales, etc. De tal manera que ya está normativizada su vida, derechos, obligaciones y comportamientos en el mundo. Ventaja o no es que el *suicidario s*iga siendo la gran excepción. Por lo menos es desventaja para que se le pueda comprender, tolerar y permitir lo que desea; pero es una ventaja en cuanto a que sigue siendo un tanto privada la decisión del morir, "tanto menos cuanto que un día cualquiera, que con toda seguridad ha de llegar, ya no *tendremos* que vivir, sino que *podremos* no vivir" (Améry, 1999, p. 68).

Esta discusión sobre si el médico decide quién puede morir o si el Estado permite el suicidio queda fuera de la realidad cuando se puede distinguir entre los que consiguen matarse —*suicidantes*— y los que solo lo intentan —*suicidarios*—,[1] pues el problema con la medicina, la psiquiatría y todo aquel que se empeña en "salvarlos" es justo para estos últimos, a menos que no lleguen a ser expuestas sus tendencias al suicidio, mientras que los que pueden develar la realidad de lo que significa el suicidio son

[1] *Suicidante* y *suicidario* son términos usados por Jean Améry (1999).

los suicidantes, aunque sea paradójico, pues no se puede contar con su testimonio.

Hagamos una revisión muy breve sobre los términos relacionados:

- *Suicidio médicamente asistido*. Es cuando se provee a las personas de los medicamentos para que terminen con su vida sin dolor. "Esta ayuda se permite en los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá" (Álvarez del Río, 2021, p. 71), en algunos estados de Australia y de Estados Unidos de América. En Nueva Zelanda se está legalizando esta opción, además de la eutanasia. Como se nombra de esta manera, "médicamente" tiene que estar auxiliada por un médico y, por tanto, solo utilizar las sustancias pertinentes que consideran otorgar a quien tenga una condición médica incurable, así como su capacidad clara para decidir.

  > A veces, la decisión es tomada por el paciente de manera deliberada, con un juicio claro, y la muerte sobreviene como un suicidio lúcido, si el paciente mismo realiza la acción final, o como un proceso de eutanasia, si el personal médico es quien lo hace. (Ramírez-Bermúdez, 2021, p. 175)

- *Eutanasia*. Se considera cuando se le ayuda a un paciente a morir, pero se le aplican los medicamentos necesarios para ello, con el fin de aminorar el dolor, pero sin reversibilidad; es decir, la consecuencia es ir bajando los signos vitales, a petición del paciente. Sin embargo, en muchos países está prohibida, aunque de pronto los médicos lo suplen con el nombre de "sedación paliativa", que puede ser reversible. "Se puede distinguir entre 'eutanasia activa' y 'eutanasia pasiva', que se reduce a la distinción entre provocar la muerte y dejar morir" (Linares, 2021, p. 301). Esta segunda, la pasiva, es ya no recibir el tratamiento paliativo, sabiendo que no mejorará la condición, y puede que sea peor que morir, es decir, que implique mayor sufrimiento.
- *Homicidio a petición.* Es en el que se solicita a otro ayuda para darse muerte, lo decide el que solicita, no el que lo ejecuta. En la Ciudad de México, el Código Penal, en su artículo 127, confiere una pena mucho menor a quien ayude a otro a morir, siendo por razones humanitarias.

Es decir, se castiga, pero no como un homicidio como tal. Es de dos a cinco años, mientras que el homicidio mínimo es por ocho años.

- *Voluntad anticipada.* Se refiere a cuando la persona, antes de morir, ha decidido y registrado de forma legal su voluntad de ser desconectado de los medios que podrían sostenerle con vida si ya ha perdido la conciencia.

Respecto al suicidio asistido, queda una pregunta compleja: ¿Por qué sería un delito ayudar a suicidarse, si el suicidio ha dejado de serlo?

En México, hemos visto que se ha creado el Consejo Nacional para la Prevención del Suicidio, mientras que en otros lugares, como en Suiza, existe la organización llamada Dignitas, cuyo lema es *To live with dignity—To die with dignity.* Perspectivas distintas. En México se apuesta por impedir el suicidio, por seguir sosteniendo la obligatoriedad de vivir, mientras que en otros países donde ya se ha legalizado la muerte asistida no solo se habla del derecho a vivir, sino del derecho a morir, dignamente. Porque cuando hablamos de vida con dignidad, en México, nuestra sociedad, economía y situación en general es de una precariedad evidente, quizás por ello hablamos de cuestiones mínimas, como el salario mínimo, así como… vivir por mínima obligación.

El suicidio en etapas tan delicadas como la infancia, la pubertad o la adolescencia, que clasifica la psicología evolutiva, donde podemos reconocer la "psicopatología normal", es decir, los momentos de crisis "naturales" o propios de dichas etapas, es parte de ese cuestionamiento a todo, a las leyes, al Otro e incluso el "deber vivir", así como un mandato u obligación. Enrique Graue (2021) dice: "Casi siempre toman estas letales decisiones porque no les hemos podido iluminar el camino, llenarlos de esperanzas y generar en ellos la suficiente autoestima para superar sus crisis" (p. 29).

¿De qué manera implementar el suicidio asistido podría ser benéfico? La ejecución de un suicidio debe también ser un acto responsable y cuidadoso… no solo por lo que uno dejará de sufrir, sino por el impacto que tendrá en los demás, en la comunidad; a los sobrevivientes nos queda la "resignación"… o sea, volver a signar, volver a significar, nos queda a los demás hacerlo. Entonces valdría la pena que el que quiere suicidarse reflexionara sobre lo que sucederá y si con eso está de acuerdo o qué tanto le

puede importar. Por otra parte, el que disponga de los medios para que lo lleve a cabo, puede disminuir los fallos y daños colaterales inesperados, así como los juicios de los demás. ¿A qué me refiero? No es desconocido que quienes sobreviven a intentos suicidas no siempre son bien tratados por paramédicos que los asistieron o por la familia, quizás algunos recibirán compasión y otros muchos no, un verdadero enojo por haber intentado romper lazos. Aunque no se vea como un pecado, en el fondo sigue provocando enojo o desprecio. También pueden recibir ese "exceso" de compasión por el que la persona que sobrevive se convierte en alguien que pierde su privacidad, su derecho a decidir, a quien no se le puede dejar a solas; es decir, no es alguien digno de confianza, y entonces hay que hipervigilar y sobreproteger. Ambas cosas no dejan de ser una agresión. Quizás eso es lo que esperaba, o tal vez si es peor para la persona haber sobrevivido. Si lo que experimentan antes del intento es no poder hacer cosas o lograr cosas, se corrobora con el fallo en el suicidio y el que en adelante ya no se le permita ser libre de tomar decisiones sobre sí mismo.

El que en Suiza exista este organismo Dignitas, Life Circle, Pegasos, como lo fuera en 1980 la Sociedad de la Cicuta, no produce más suicidios, no se ha hecho una epidemia, solo tratan de que la decisión sea mejor tomada, más consciente; que se hayan analizado todas las opciones de vida, que se evalúe la propia vida. Si en verdad después de ese proceso aun se desea el suicidio, entonces es proveer de los medios efectivos. Obviamente hay ciertas restricciones para los extranjeros, así como ha sucedido con la eutanasia. El objetivo es corroborar que la persona que solicita el suicidio no está siendo coaccionado, manipulado y tiene toda la claridad para poder decidir su muerte. Sin embargo, en Suiza si está penalizada la eutanasia.

Obviamente esto es complicado por el asunto legal, puesto que para la mayoría de los países asistir o ayudar a alguien a suicidarse se considera delito. "En Suiza, el Código Penal de 1937 establece en su artículo 115 que comete delito quien, por motivos egoístas, ayude a suicidarse a una persona" (Álvarez del Río, 2021, p. 76), pero si es por una razón de ayuda, de compasión, no es un delito. Esto provocó que surgieran organizaciones que apoyan pero que no tienen fines de lucro, para tener mayor control.

La complicación de lo legal, como hemos dicho, ronda en lo profundo de las decisiones libres y voluntarias, si eso es posible para el ser humano,

pero lo que nos enseña el suicidio es que la persona decide a pesar de los demás o por causa de los demás. Por otra parte, como veíamos en el Psicoanálisis, es una forma de transgresión; la sociedad lo vive como una separación, así se trata de legalizar, de evitar, de prevenir, pero "ni la sociedad ni el Estado pueden obligar a los individuos a alcanzar el extremo de la virtud y del heroísmo para darle sentido al sufrimiento corporal y mental" (Linares, 2021, p. 304), se trate de enfermedades médicas o de malestares subjetivos.

Claro, tiene que ver con aquello que mencionamos anteriormente, suicidios que sí se pueden prevenir y los que no, como lo menciona Asunción Álvarez del Río (2021): "John Hardwig lo dice así: hay suicidios éticos y suicidios no éticos; suicidios prudentes y tontos; suicidios causados por enfermedades mentales y suicidios resultado de una decisión sabia y valiente" (p. 67).

¿Hacia dónde vamos? Creo que hacia donde debemos ir, por derecho y por piedad" (García, 2021, p. 244). Habrá que seguirlo pensando, porque ciertamente apoyar el suicidio asistido para quienes están desahuciados por alguna enfermedad física, incluso una mental grave, nos parece comprensible, no para quien ya no parece tener expectativas para vivir, aun teniendo las condiciones para ello. Más allá de que para algunas religiones esto no será algo tolerado, aun así habrá que respetar los fundamentos de las mismas y cómo esas premisas pueden impactar en el sujeto, de tal manera que a la clínica no nos corresponde decirle al otro qué de sus creencias están o no equivocadas, o si son correctas o no, o nuestra propia opinión. No corresponde a nuestros alcances teóricos distinguir entre la compasión para aceptar la voluntad del suicidio del otro y la de evitárselo para, con ello, salvarlo de un mal mayor. Solo puede dilucidar su deseo a través de la idea de morir.

4. Algunas nociones teóricas del Psicoanálisis

[…] nada, nada podrá ser más amargo
que el mar que llevo dentro, solo y ciego.
El mar antiguo Edipo que me recorre a tientas
desde todos los siglos,
cuando mi sangre aún no era mi sangre,
cuando mi piel crecía en la piel de otro cuerpo,
cuando alguien respiraba por mí que aún no nacía.
Xavier Villaurrutia

Para poder tener claro cuál es la postura del Psicoanálisis respecto al suicidio, me enfocaré en Freud y Lacan principalmente. Evidentemente no es posible abarcar toda la teoría psicoanalítica ni todo lo que dice Freud o Lacan; entonces, tomaré algunos elementos que nos puedan servir para el objetivo de este libro. Así, es indispensable hacer un repaso por el constructo teórico que se requiere para lograrlo, de tal manera que, para hablar de suicidio, es imprescindible retomar la noción de muerte y para ello, a su vez, abordar la noción de *pulsión*. Comenzaremos por ahí.

En Freud, se sabe que el concepto de *pulsión* comenzó siendo un término enlazado con lo biológico o lo somático, como él lo nombra, pero que también está propiamente en lo anímico o psicológico.

La pulsión en Freud

Noción de pulsión

Freud introduce el término de *pulsión* en sus escritos tempranos, sobre todo en el *Proyecto de una psicología para neurólogos*, aunque de manera primitiva le llamase *Qn* o cantidad de estímulos internos o de excitaciones endógenas; de cualquier manera —reconoce— es de naturaleza desconocida.

En un principio, dice que los organismos reciben tres tipos de estímulos: los externos al cuerpo y otros dos, que provienen del interior del cuerpo;

estos son, uno de naturaleza fisiológica y otro pulsional, y ambos afectan a lo psíquico. También son llamados estímulos endógenos, de los cuales no puede el organismo deshacerse de igual manera que lo hace con los externos, ya que del exterior el organismo puede defenderse o sustraerse; en todo caso, reaccionar por arco reflejo y volver a su estado de tranquilidad o reposo. Ya aparece aquí lo que se llamará "principio de placer", es decir, un estado sin tensiones o excitaciones, que sería lo que el organismo tiende a buscar.

Aunque la terminología es más bien propia de un neurólogo, va siguiendo la idea de que el organismo evita la estimulación lo más que puede y tramita los estímulos para que pueda conseguir volver a su estado de menor tensión posible.

Esto, para Freud, es fácil de conseguirse con lo que proviene del mundo exterior, no así con lo interior, pues al mismo tiempo la pulsión no pertenece del todo a lo interior; es decir, es un estímulo que no proviene de fuera del organismo o del cuerpo, que está por tanto en el interior, incitando, pero que no es del psiquismo, puesto que "la pulsión sería un estímulo para lo psíquico. Pero enseguida advertimos que no hemos de equiparar pulsión y estímulo psíquico" (Freud, 1915/1999, p. 114), lo que indica su "afuera" por ser un estímulo para lo psíquico sin provenir de él, y al mismo tiempo su "adentro", pues no proviene del exterior del organismo. Así, no puede tramitarse por medio del arco reflejo por ser de naturaleza distinta a esto. Entendiendo este asunto de ser un poco ajeno este estímulo a la conciencia, es decir, no nos podemos percatar de ello totalmente.

En el texto del *Proyecto*, Freud distingue entre tres tipos de sistemas neuronales, que parecen un antecedente de su primera tópica, pues consisten en llamar sistema *f* al grupo de neuronas que tienen relación con el exterior y se encargan de la percepción; no retienen, mientras que el otro sistema, nombrado *y*, contiene neuronas que reciben lo interno y retienen información, de tal manera que se encargan de lo que se puede memorizar. Ya que provienen del interior, son las que guardan relación directa con las pulsiones. Además, está el sistema w, para quien registra o recibe la cualidad, pues no pueden recibir *Qn*, y estaría más asociado con lo consciente y con la temporalidad. El asunto es que Freud hace recaer la mayor importancia no en estos sistemas, sino en la cantidad de excitación con que tienen que enfren-

tarse, es decir, con *Q*. El dolor, por ejemplo, sería grandes cantidades de *Q* en los dos sistemas, *f* y *y*.

Lo que hace diferente al sistema *y* es que es quien recibe y tramita la *Q* interna (*Qn*) y ante quien está desprovisto, "y en esto reside el resorte pulsional del mecanismo psíquico" (Freud, 1895/1999, p. 360). De ahí que también lo identifique más adelante como el Yo, donde se realizan los procesos mentales, no solo el recordar, sino también el juzgar.

Q es definida en el apéndice C al proyecto como energía psíquica indiferente que deja de ser material para convertirse en algo psíquico, dando un breve seguimiento del paso de esta visión sobre la pulsión, que sería aquella *Qn* o, mejor dicho, los estímulos endógenos.

En *Tres ensayos*, justamente lo dice de esta manera:

> Por "pulsión" podemos entender al comienzo nada más que la agencia representante {Repräsentanz} psíquica de una fuente de estímulos intrasomática en continuo fluir; ello a diferencia del "estímulo", que es producido por excitaciones singulares provenientes de fuera. Así "pulsión" es uno de los conceptos del deslinde de lo anímico respecto de lo corporal. (Freud, 1905/1999, p. 153)

Se puede notar cómo en esta definición de *pulsión* dice que es uno de los conceptos "del deslinde" entre el cuerpo y el psiquismo, mientras que en otros momentos dice que es la frontera. Lo que queda claro es que está en el borde de lo corporal y lo psíquico; está entre los dos mundos, por decirlo de otra manera, solo que no pertenece a ninguno de ellos exclusivamente; representa a lo que acontece o afecta al cuerpo, en lo psíquico, pero al estar en la frontera tampoco se puede decir que le pertenezca totalmente al cuerpo.

Es en este momento cuando ya no habla de una Qn, de la cantidad de estímulos endógenos, sino de algo que lo representa. Como lo retoma en otros textos, de la pulsión no se puede saber nada si no es a través de sus elementos, de su representación o de sus destinos. Así, también es definida después en el texto llamado *La represión*.

Definir a la pulsión como algo en movimiento es lo que puede llevar a decir que "toda pulsión es un fragmento de actividad; cuando negligentemente se habla de pulsiones pasivas, no puede mentarse otra cosa que pul-

siones con una meta pasiva" (Freud, 1915/1999, p. 118). Así, *pulsión* es una energía, una fuerza, algo que mueve, un esfuerzo que afecta desde dentro del cuerpo a lo psíquico.

Hasta aquí se ha podido ver algunos momentos de cómo Freud construyó el concepto de *pulsión* a través del tiempo. De hecho, fue un tema que atravesó toda su construcción teórica, elaborando y redirigiéndose a entenderlo; pero si vemos el tiempo desde el *Proyecto de psicología para neurólogos*, hasta *Pulsiones y destinos de pulsión*, por lo menos son 20 años. A veces podemos encontrar contradicciones en lo que dice de la pulsión, lo cierto es que siempre aceptó que es un término rodeado de controversia, oscuridad y desconocimiento profundo, así que, para entenderla más, la fue relacionando con otros conceptos, o bien, con el comportamiento que podría verse e intuir, a partir de ahí, lo que es la pulsión.

Es importante considerar que hablar de pulsión también lleva por un camino de las diferentes acepciones que se le dio o con que se relaciona, como pulsión de conservación, sexual, yoica y parcial, y otro concepto importante, como el de libido.

En los primeros textos, Freud nombra la *pulsión de conservación*, por ejemplo, en el caso de Schreber, cuando este personaje está describiendo a dios, que hay un dios superior y un dios inferior, además de decir que se relaciona con los hombres debido a la atracción que ejercen sobre él en estado de excitación, y que al no soltarse de los hombres, dios corre el riesgo de perder su existencia, por tanto queda prendado de Schreber, pero esto solo le trae un constante estado de excitación y sometimiento a ese dios, ya que "por esa vía se puso en movimiento la pulsión de autoconservación de Dios" (Freud, 1911/1999, p. 24).

Así, en primer lugar, se menciona esta fuerza tanto de Schreber como de dios, sobre todo para conservar la propia existencia, y cómo la pulsión de dios resulta más poderosa, es decir, aquella pulsión que, dado que la coloca fuera de él, en la alucinación le resulta más potente que la propia, aunque al final de cuentas sea la suya. Es evidente la misma ambivalencia que maneja antes con respecto a lo superior y a lo inferior.

Posteriormente, Freud habla de pulsiones sexuales diferenciándolas de las yoicas que, en un principio, dice, están mezcladas, dado el autoerotismo. Esta separación de pulsiones sexuales y yoicas tiene que ver con la función

doble que posee el ser humano; es decir, que lo que hace emerger a la pulsión, por un lado, es la búsqueda de preservación de la especie y, por otro, la conservación del sujeto o de sí mismo. Al constituirse el Yo como la instancia que media entre el exterior y el interior del sujeto y seguir siendo el propio cuerpo quien provee la satisfacción, se construye el narcisismo, que solamente queda aparentemente suplantado cuando el objeto se busca fuera de sí.

Es de suma importancia en este momento hablar de otro de los constructos agregados alrededor de la pulsión, como es la *libido*, que describe como "fuerza susceptible de variaciones cuantitativas, que podría medir procesos y trasposiciones en el ámbito de la excitación sexual" (Freud, 1905/1999, p. 198). Si se retoma lo escrito en el *Proyecto*, se verá cómo permanece aquí la idea de "cantidad". De tal manera que libido y pulsión están unidos.

Masotta (1990) la define como "la energía misma del deseo sexual" (p. 18). Entendamos, pues, la relación de la libido y el Yo en el narcisismo. Pero aclaro que el narcisismo del que habla la teoría psicoanalítica dista mucho de lo que hoy en día se ha proliferado, como un trastorno. Efectivamente, para la Psiquiatría, dentro de los trastornos de personalidad existe el de la personalidad narcisista, en donde el cuadro sintomático tiene marcados los rasgos de egoísmo, de un sentido del Yo aumentado o de tener ideas, algunas veces rayando en lo delirante sobre la propia grandeza, conocida como la megalomanía, así como la idea de que se tiene que recibir un trato especial y distinto al del resto de los humanos. En fin, habría que consultar al DSM para ver todos los rasgos que ahí son enlistados. Además de ello, recientemente por las redes sociales se ha plagado de información sobre esto, entonces ya se dan recomendaciones para reconocer al narcisista con el que convives y que te puede estar haciendo daño y cómo liberarte de relaciones con narcisistas, de madres narcisistas o padres narcisista; en fin, terminó por hacerse de un uso popular, y quizás con ello pierda el verdadero sentido que se pretendía en la psicopatología descriptiva, es decir, la psiquiátrica.

Pero el narcisismo del que se habla en Psicoanálisis no es nada de eso, por el contrario, es una condición necesaria para la sobrevivencia del sujeto, es imprescindible; obviamente tiene sus riesgos, pero digamos, en otras palabras, el narcisismo es estructurante, no una patología.

En la explicación del narcisismo, Freud dice que habrá un narcisismo primario cuando la libido "originaria" esté vuelta sobre sí mismo y el Yo tome al propio cuerpo como su objeto de satisfacción, y cuando haya un objeto externo se hablará de libido de objeto. Cuando el sujeto retire la libido del objeto externo para replegarse sobre sí mismo (como se puede ver de manera un tanto exacerbada en el paranoico o en cualquier rompimiento amoroso), se hablará de un narcisismo secundario y, por lo tanto, de una vuelta de la libido, ahora llamada narcisista. Ya que el organismo no posee más que cierta cantidad, no puede aumentarla o disminuirla, solo distribuirla, y es absolutamente necesario que una parte de esa cantidad se dirija al Yo para que siga viviendo. Sin embargo, generalmente se da un cambio de esta libido para darle prioridad a la de objeto.

Laplanche (2001) dirá, sosteniendo la misma idea freudiana, que "el narcisismo se sitúa, cronológica o dialécticamente, después del autoerotismo" (p. 101), para eliminar la separación entre uno primario y secundario, pues el que estrictamente es narcisismo es la vuelta de la pulsión sobre el Yo, colocándose este como objeto externo, a partir de la identificación. Dado que el autoerotismo no tiene que ver con amor a sí mismo, sino con haber erogenizado al cuerpo que provee de satisfacción, el autoerotismo es la condición necesaria para la sobrevivencia, pero posterior a la simple necesidad; es el momento de la emergencia de la sexualidad, que todavía no admite una organización pulsional; es decir, aún no se comporta separada de las yoicas. Así, están mezclados el autocuidado y el placer en el propio cuerpo con la búsqueda de la satisfacción de necesidades básicas.

Del *narcisismo,* Freud dice que es un "complemento libidinoso del egoísmo inherente a la pulsión de autoconservación, de la que justificadamente se atribuye una dosis a todo ser vivo" (Freud, 1914/1999, p. 72), pero esta afirmación deja fuera el hecho de que, si está libidinizado como objeto, tiene que ver también con las pulsiones sexuales.

La libido narcisista, que toma al Yo por objeto, se puede considerar libido yoica, es decir, pertenecería a las pulsiones yoicas y de conservación, mientras que la libido de objeto estaría del lado de las pulsiones sexuales, en tanto que inviste objetos externos para su satisfacción sexual. En el único momento en que podrían converger estas dos pulsiones, sería en el narcisismo, pues ambas tienen el mismo objeto investido, que sería el Yo. La

conciencia de sí estaría justamente en estas pulsiones yoicas, dependiendo, por tanto, de la libido narcisista. Masotta (1990) diría a este respecto que "si el Yo está también libidinizado, no hay ya lugar para las pulsiones no sexuales" (p. 24).

Freud (1905/1999) señala que "esta libido yoica solo se vuelve cómodamente accesible al estudio analítico cuando ha encontrado empleo psíquico en la investidura de objetos sexuales, vale decir, cuando se ha convertido en libido de objeto" (p. 198). Luego, también habla de pulsiones sociales, que en realidad tendrían explicación en el cambio de meta sexual para sublimarse y unirse a las pulsiones yoicas, y así relacionarse con el exterior:

> Se conjugan entonces con sectores de las pulsiones yoicas para constituir con ellas, como componentes "apuntalados", las pulsiones sociales, y gestan así la contribución del erotismo a la amistad, la camaradería, el sentido comunitario y el amor universal por la humanidad. (Freud, 1911/1999, p. 57)

Cabe aclarar que justamente el concepto de *apuntalamiento* es imprescindible para entender la relación entre las pulsiones sexuales y las yoicas o de conservación, pues las primeras dependen de las segundas para su surgimiento. Es decir, es un principio en el cual el organismo busca su supervivencia, y para eso recurre al otro que le provea de lo necesario. Las pulsiones sexuales no han aparecido o están mezcladas, se desprenden una vez que ese otro alimenta, cuida y satisface las necesidades básicas. Es entonces cuando ese otro es percibido como un objeto deseado también. Ya no solo necesario, sino deseado; así, la pulsión sexual investirá tal objeto. Y ya que las necesidades son parciales, es decir, dirigidas a satisfacer algunos estímulos por separado del cuerpo, "el sujeto erogeniza las partes de su cuerpo que cumplen una función biológica" (Masotta, 1990, p. 13) (autoerotismo); los objetos también lo serán; por tanto, la pulsión, de igual manera, será parcial.

Es así como de un hecho biológico se parte a lo psíquico. De una necesidad básica para vivir se traslada a lo pulsional, "la derivación de la pulsión en el hombre a partir del instinto" (p. 18) o la perversión del instinto da como resultado la pulsión, diría Laplanche (2001).

Por eso cuando se dice que el deseo o el amor son esenciales es un error, ni siquiera lo sexual lo es. Digámoslo así, para la especie; es esencial la sexualidad porque, de no haber intercambio sexual, se extingue, pues es la forma de la reproducción y sostenimiento de la especie, pero a nivel individual no lo es, no es la sexualidad una necesidad: el ser humano puede sobrevivir sin actividad sexual. Así también lo entendió Maslow en su pirámide, al colocar la sexualidad como necesidad básica para la especie y en las necesidades afectivas para el individuo, en un nivel más alto, en donde puede estar siendo parte del amor, propio y hacia los demás. Entonces, podemos ver que hay instinto de supervivencia, mas no instinto materno, pues eso tiene que ver más con el deseo y con el amor; ambos, instalados después de lo básico en el ser vivo.

Otra precisión que es pertinente sobre sexualidad, para tener en cuenta cuando el Psicoanálisis habla de sexualidad con esta connotación que acabamos de ver, está relacionada con la necesidad del otro para sobrevivir; es decir, reconocer al sujeto como incompleto, o sea, parcial, por eso cuando habla de la pulsión sexual, pero en general de la pulsión, dirá que es parcial. No puede haber, por tanto, una satisfacción total, sino también parcial.

De hecho, esto es muy cercano al concepto de *seres neotenos*, como califica Dufour al hombre, diciendo que este nace incompleto o no totalmente desarrollado, pues los nueve meses que vive en el vientre materno no le dan toda la capacidad al nacer, y por tanto depende del cuidador y se tarda un largo tiempo en terminar de evolucionar dentro de su misma especie, como se observa en los sistema nervioso, óseo y hormonal, por ejemplo. Esa característica de seres incompletos es precisamente lo que provoca que un Yo, tal vez primitivo, como un simple organizador, no ya tan conformado por identificaciones y lo que viene a suceder después, se dé primero que la sexualidad, o por lo menos perciba antes y le sirva a esta en un principio: "La evolución del Yo se superpone mal a la evolución de la libido, la primera se adelanta a la segunda" (Masotta, 1990, p. 61).

Pero ¿qué es lo que hace que se presenten la pulsión sexual y la libido? Esto tiene que ver con los *objetos*, término que se abordará más adelante. Sin embargo, aquí se puede decir que cuando el objeto de satisfacción de las necesidades se pierde o desaparece, se comienza a desear; por tanto, se in-

viste libidinalmente, convirtiéndose en el objeto de la pulsión y del deseo, es decir, erotizándolo.

Se sabe que esta relación con el otro, por la necesidad, es lo que además provoca después el conflicto edípico, la forma de negociar con el otro la satisfacción, por lo que Laplanche (2001), en sentido estricto, afirma que "lejos de ser el Edipo el que nace de la sexualidad, sería la sexualidad la que nacería del Edipo" (p. 137).

Como el objeto de satisfacción inicial es parcial, pues solo se percibe lo más inmediato, por ejemplo, el pecho que provee el alimento, dice Freud que, una vez que se alcanza a entender o a darle el carácter de objeto total o completo, es cuando ya se está en un asunto pulsional; sin embargo, como se busca ese primer objeto y ese era parcial, estará condenado a un eterno desencuentro. Ante objeto parcial, será pulsión parcial, que es una de las características de la pulsión, como se verá en el siguiente apartado.

Características de la pulsión

Desde el *Proyecto* se pueden deducir algunos de los rasgos de la pulsión, uno de ellos es que "son de naturaleza intercelular, se generan de manera continua y solo periódicamente devienen estímulos psíquicos" (Freud, 1895/1999, p. 360). Es decir, le pertenece al cuerpo, en el sentido de que se da en el cuerpo, es duradera o constante, pero no siempre afectará lo psíquico. Tal vez esto último dependa de la cantidad acumulada para que pueda ser algo considerable de afectar. Ahora, hay que recordar que el término *estímulo* no es, al final de la teoría freudiana, el más apropiado para mentar a la pulsión.

Como ya se había mencionado, la pulsión tiene carácter atemporal, más bien resulta monótona y repetitiva. "La pulsión, en cambio, no actúa como una fuerza de choque momentánea, sino siempre como una fuerza constante" (Freud, 1915a/1999, p. 114).

Otra característica sería que, en un principio, al ser desvalido el sujeto, la manera de satisfacer o darle trámite a esa *Qn*, a esa pulsión, es por el auxilio de una persona en el exterior. Esto quiere decir que necesita del exterior para su "satisfacción". Es decir, por sí misma no tiene satisfacción.

Necesita estar apuntalada. Inicia aquí la dependencia que se establece hacia el otro.

Además, marca la dificultad de que una pulsión pueda ir al exterior de manera directa, señalando que "la conducción *f-y* cumple en todo caso más fácilmente que la conducción *y-f*" (Freud, 1895/1999, p. 385). En otras palabras, es más fácil que algo externo llegue al interior, a que suceda lo contrario. Hay que recordar cómo esto puede parecerse a la primera tópica, en tanto que lo que está en el consciente o en la percepción puede ir hacia el inconsciente, mientras que lo inconsciente tendrá un acceso casi imposible hacia el consciente, a menos que sea en formaciones, pero no de manera directa. Tal como la pulsión no se presenta tal cual, sino por medio de una agencia que la representa.

Ya que la pulsión está enlazada al sistema de la memoria, al ser tramitada por las células y encargada de la memoria, esto mismo dificulta su retorno a la percepción; se puede ver ahí una especie de amnesia que, sin duda, tendría que ver con un proceso de represión o de desplazamiento (si su aparición se diera en los sueños, por ejemplo).

Este enlace de las neuronas y con la memoria, con el juzgar y otros procesos mentales, le da también la asociación con las imágenes sonoras, con las palabras. "La inervación lingüística es originariamente una vía de descarga que opera a modo de una válvula para *y*, a fin de regular las oscilaciones de *Q3n*" (Freud, 1895/1999, p. 414); sería una de las formas en que la pulsión podría hacerse consciente.

Por otra parte, es también propio de la *Qn* que se detenga de investir todo aquello cuanto le pueda proveer satisfacción, pues existe una forma alucinatoria de investir, que le procura displacer en caso de una descarga prematura. Es decir, tiene que distinguir entre "las investiduras-percepción real-objetivas de las investiduras-deseo" (Freud, 1895/1999, p. 419).

Lo que caracteriza también a *Qn*, es que resulta "algo que es susceptible de aumento, disminución, desplazamiento y descarga" (Freud, 1895/1999, p. 446), asociado totalmente con el término de economía que usará en toda la teoría psicoanalítica referida a la pulsión. Sin embargo, estos movimientos de *Qn* se referirán, más bien, a que aumente o disminuya en relación con un objeto y no en sí misma.

En *Lo ominoso* (1919), por otra parte, dice que la pulsión tiene por naturaleza la compulsión a la repetición, y lo reitera en *Más allá del principio del placer*, donde dirá que aquello que quiere repetir es "algo" anterior; sin lugar a dudas, la compulsión a la repetición es esencial a la pulsión, porque esto implica la búsqueda continua. Texto en el que además comienza diciendo que la pulsión (o la cantidad de excitación = *Qn)* está fuertemente ligada al principio de placer y de displacer, que se encarga de tratar que exista el mínimo de tensión o el mínimo de cantidad *Q*, o que sea constante; de ahí que el principio de placer derive del de constancia. Tiene a su vez que ver con el displacer, por tanto que en un tiempo la pulsión ha sido reprimida y, al encontrar una vía de salida, se vive como displacentero; tomando en cuenta que tiende a la repetición, buscará incesantemente:

> El estímulo pulsional no proviene del mundo exterior, sino del interior del propio organismo. Por eso también opera diversamente sobre el alma y se requieren diferentes acciones para eliminarlo. Además: Todo lo esencial respecto del estímulo está dicho si suponemos que opera de un solo golpe; por tanto, se lo puede despachar mediante una única acción adecuada. (Freud, 1915a/1999, p. 114)

Y ya que ante la pulsión no se puede hacer lo mismo que con los estímulos externos, Freud dice que se realizan diversos movimientos para tramitarla; como ya se ha visto, una es la alucinación, su ligazón con el lenguaje y con los demás procesos mentales, como la memoria, el pensamiento y el juicio; también existirán algunas defensas contra ellas, como pueden ser los diferentes destinos. "Los destinos de pulsión pueden ser presentados también como variedades de la defensa contra las pulsiones" (Freud, 1915a/1999, p. 122).

Otra vía de trámite de la pulsión es enlazarse al afecto, en cuyo caso, si la angustia es un afecto, queda esta como defensa ante la salida pulsional: "El apronte angustiado, con su sobreinvestidura de los sistemas recipientes, constituye la última trinchera de la protección antiestímulo" (Freud, 1920/1999, p. 39).

Componentes de la pulsión

Habiendo definido y revisado las características de la pulsión, así como sus diferentes destinos, es momento de descomponerla en partes, para luego reunirla de nuevo en la *pulsión de muerte*.

En el texto de *Pulsiones y destinos de pulsión,* Freud menciona cuatro componentes de la pulsión; ya antes los había nombrado, excepto uno de ellos. Los tres ya conocidos son la fuente *(Quelle),* el objeto *(objekt)* y la meta *(Ziel).* El último agregado es el empuje o esfuerzo *(Drang).*

El esfuerzo o empuje es ese carácter de movimiento, de tendencia al trabajo exigida; la meta, como se sabe, es la satisfacción o cancelación del estímulo; la fuente es de donde surge, y el objeto es quien le provee esa satisfacción.

El *Drang*, que en otros textos no se había mencionado, es tal vez la parte esencial de la pulsión, en cuanto indica su carácter móvil, su actividad constante, y quizás por eso no se había escrito sobre él, mientras que los otros tres componentes han sido más estudiados. La meta está totalmente abordada desde el proyecto y en el resto de los textos que se refieren a la pulsión, pues no hay vuelta de hoja con respecto al fin de toda pulsión. Sucede igual con la fuente y el objeto.

Con respecto a la fuente, es el componente que hace a la pulsión estar en lo somático: "La *Quelle* es un proceso somático desconocido pero cognoscible de derecho, una especie de X biológica cuya traducción psíquica sería precisamente la pulsión" (Laplanche, 2001, p. 22). Así, la fuente puede ser un órgano interno, o externo como la piel, pero también, por el proceso que vive al trasladarse a lo psíquico, puede ser el intelecto, la fantasía o el afecto, es decir, todo aquello que esté relacionado con las funciones vitales. Sin embargo, siempre estará referido a lo biológico, así parezca provenir de lo psíquico, pues esto no será otra cosa que una rememoración, fantaseo o alucinación de lo vivido biológicamente. Esta inevitable referencia a lo biológico se debe al apuntalamiento de la pulsión sexual en las de conservación. Es aquí, en la fuente, donde se efectúa tal apuntalamiento. El hecho es que la fuente es un componente, no la pulsión misma; por tanto, la primera puede estar situada en lo biológico, en el cuerpo; eso no hace que la pulsión sea toda del cuerpo, solo en una de sus partes.

Como se vio anteriormente, la represión solo actúa sobre ciertas partes de la pulsión, dejando otras que se enlacen de otra manera para poder emerger; eso mismo es lo que sucede, pues, con los procesos psíquicos. "De este modo, protegida de todo desgaste gracias al proceso de represión, la fantasía se transforma en una fuente permanente de excitación libre" (Laplanche, 2001, p. 62); lo que apoya la idea de que no es solo el cuerpo lo que puede fungir como fuente, sino algunos procesos mentales, como la fantasía en este caso —aunque ya se dijo de su relación con el cuerpo—, e incluso puede ser más tramitable, pues no le representan un riesgo en la realidad al sujeto.

El objeto, por su parte, será aquello que facilite la satisfacción. Para la pulsión sexual, los primeros objetos tendrán que ver con aquellos que también lo son para la pulsión de conservación, es decir, la mujer que lo crio y luego él mismo.

> Objeto, fin y fuente están estrechamente contenidos en una proposición muy simple que permite describir lo que acontece: "eso entra por la boca". "Eso" es el objeto; "entra" es el fin, y, ya se trate de un fin sexual o de un fin alimentario, el proceso consiste, en ambos casos, en un "entrar"; "por la boca": en el nivel de la fuente vuelve a encontrare la misma duplicidad, la boca es a la vez órgano sexual y órgano de la función alimentaria. (Laplanche, 2001, p. 29)

Hablando de las pulsiones de conservación, su objeto sería, más estrictamente hablando, el alimento, o el pecho materno; es decir, es un objeto parcial. Cuando este objeto desaparece, no a voluntad del sujeto que lo necesita, sino de él mismo, se comienza a percibir como objeto total, y es ese momento cuando se da la pérdida de objeto. "Tal vez el objeto parcial se pierde en el preciso momento en que empieza a perfilarse el objeto total" (Laplanche, 2001, p. 31).

En este instante la pulsión sexual emerge para investir al objeto que se ha perdido y que ahora no solo es objeto de la pulsión de conservación, sino que también se transforma o, mejor dicho, se desplaza a ser objeto de deseo, sin importar ya la función del objeto en cuanto a lo biológico, sino a la

presencia o ausencia de este. De ahí que devenga la fantasía o alucinación de tal objeto.

Ese objeto parcial, fantaseado, es el que buscará la pulsión sexual. Se habla entonces de una búsqueda que no tendrá encuentro, ya que no existe tal objeto, pues el que se busca es un objeto sustituto del objeto perdido que pertenecía a la función biológica.

Al no encontrar ese objeto, ni el de la pulsión sexual, ni el de la de conservación, el Yo, que para entonces se ha conformado rudimentariamente, se pondrá de señuelo para mantenerse en pie, de tal manera que el Yo, como conjunto o sistema de representaciones, es también un objeto sustituto. "El *yo* es por cierto un objeto, pero es un objeto de relevo, susceptible de manifestarse ante nosotros en forma más o menos usurpadora y engañosa, como un sujeto que quiere y desea" (Laplanche, 2001, p. 92), dando lugar al narcisismo que, como se ve en este movimiento pulsional, es por tanto un segundo tiempo, no algo inicial en el sujeto; es más bien un producto de la pérdida del objeto.

El *Objekt,* para Freud, es lo más variable de la pulsión, pues solo lo será a condición de que muestre posibilidades de satisfacción o de alcanzar su meta. Así, no importa qué o quién sea, ni donde esté. Es parcial, por lo que puede estar fuera o ser una parte del propio cuerpo.

El objeto de amor vendrá a aparecer en un tiempo posterior, una vez que se ha introducido el narcisismo, aunque se podrá diferenciar entre aquel que se parece más a la relación con el objeto perdido y, por tanto, con la satisfacción; o sea, será igual a la necesidad. Aquel otro amor que provenga del narcisismo, de la identificación con el otro, será como el libidinal orientado por el objeto: "El amor al complementario, a aquel capaz de asegurar la supervivencia, y la segunda, por oposición, como el amor al idéntico o al semejante" (Laplanche, 2001, p. 104).

Lo cierto es que la pulsión no es sin sus componentes, no es sin objeto: "el objeto es el revelador de las pulsiones" (Green, 1998, p. 72), aunque no tenga uno en específico, porque eso la cancelaría y eliminaría su carácter pulsional. Así que no es sin esfuerzo, fuente ni meta, pero tendrá que cambiar todo el tiempo de objeto para permanecer. La pulsión puede variar de meta o desplazarla, al igual que de objeto.

De todo lo anterior, puede decirse que el objeto de la pulsión es el fantaseado, el parcial, mientras que el de amor es el objeto total parecido al que satisface las necesidades o remedia el desvalimiento.

Hasta ahora eso es lo que se ha visto sobre la pulsión sexual, pero también es así para la de conservación o yoica, división que se encontrará entre varios psicoanalistas actuales; aunque Masotta insista en que solo hay pulsión sexual, luego vendrá Lacan a afirmar que la única pulsión es la de muerte, pulsión que, a diferencia de las mencionadas, estaría en contraposición con ellas, pues todas estas tienen que ver con la pulsión de vida. Así pues, se adentrará en esta otra pulsión, la de muerte.

Destinos de la pulsión

Ya se habló de que la pulsión tiene "destino", que sería la satisfacción, pero los caminos son diversos. Ya Freud había dicho que se necesitaba una única acción para la descarga, siempre y cuando fuera así de directa, pero se observa que no es así de simple, además de que se pueden vislumbrar varias acciones paralelas, como ya desde el *Proyecto* decía que se enlazaba a los procesos mentales, de tal manera que está atravesado por la lingüística,

Hay que señalar, inicialmente, que la pulsión no puede ser objeto de la conciencia, solo lo será su representante de la manera en que se verá a continuación, pero aun así en el inconsciente la pulsión tampoco aparecerá sola, sino que permanece con su representante.

En el primer apartado podría verse que dependerá del tipo de pulsión para saber hacia dónde se dirige o qué hará; así, pueden mezclarse u oponerse entre ellas. "Los destinos de las pulsiones libidinosas cuando, aisladas de las pulsiones yoicas, se encuentran en oposición a estas" (Freud, 1914/1999, p. 89), al mezclarse o "apuntalarse" unas con otras, tendrán el mismo objeto.

Cuando las pulsiones sexuales se dirigen a otra meta que no es lo sexual, se hablará de sublimación. Cuando se inviste al objeto como algo superior por la libido de objeto y/o la yoica, será idealización.

Pero hay algo más que puede suceder con la pulsión, que es la represión, por la cual en un primer momento le niega el acceso en lo consciente a la

agencia y a la pulsión, y después, en un segundo momento, también lo hace sobre "retoños psíquicos" de la agencia reprimida. Lo primero es lo que ya decía Freud en el *Proyecto*, donde había quedado evidenciado que la pulsión no puede pasar directamente a la conciencia. "El destino general de la representación representante de la pulsión difícilmente puede ser otro que este: desaparecer de lo consciente si antes fue consciente, o seguir coartada de la conciencia si estaba en vías de devenir consciente" (Freud, 1915b/1999, p. 147).

Sin embargo, que sea reprimida no significa que desaparezca; así, "la agencia representante de pulsión se desarrolla con mayor riqueza y menores interferencias cuando la represión la sustrajo del influjo consciente" (Freud, 1915b/1999, p. 144), haciéndose más fuerte y buscando vías alternas para su salida, de tal manera que, mientras está en el inconsciente, va aumentando el factor cuantitativo, lo que asegurará un conflicto posterior. Puede ser que encuentre alguna de esas otras salidas y que no resulten tan displacenteras, como sería el chiste, por ejemplo.

Ahora que, con este fenómeno de la represión, que actúa tanto en la agencia como en la pulsión, ya que son cosas distintas, aunque estén juntas una sirviendo a la otra, Freud dice que pueden tener destinos de represión diferentes, y entonces quedar una parte en el inconsciente y otra enlazarse, como se había dicho, a otras vías mejor llamadas formaciones del inconsciente, y que puedan así tener su descarga en el exterior. También se encuentra entre estas alternativas el "monto de afecto", de tal manera que "el factor cuantitativo de la agencia representante de la pulsión tiene tres destinos posibles […] la pulsión es sofocada por completo […] o sale a la luz como un afecto coloreado cualitativamente de algún modo, o se muda en angustia" (Freud, 1915b/1999, p. 148).

Los afectos, como se sabe, son conscientes, como lo describe Freud en uno de los capítulos de *Lo inconsciente*; pero también es cierto que algunos de ellos están relacionados con el inconsciente, como la culpa y la angustia, dado que tienen su origen junto con la pulsión y en contenidos primordiales. "'Afecto inconsciente' y 'sentimiento inconsciente' remiten en general a los destinos del factor cuantitativo de la moción pulsional, que son consecuencia de la represión" (Freud, 1915c/1999, p. 174).

La angustia merece un estudio aparte, pues, en los últimos escritos, Freud encuentra que no es la represión la que origina la angustia, sino la angustia la que echa a andar la represión, por la amenaza libidinal con que se enfrenta al interior.

Así pues, la pulsión se queda en el inconsciente acumulándose, sofocada, como dice Freud, pero buscando enlazarse para descargarse, por medio de las formaciones del inconsciente y de los afectos. No se puede dar cuenta de la pulsión ni de su representante, pero sí de los afectos: "Las representaciones son investiduras —en el fondo, de huellas némicas—, mientras que los afectos y sentimientos corresponden a procesos de descarga cuyas exteriorizaciones últimas se perciben como sensaciones" (Freud, 1915c/1999, p. 174).

Ahora bien, todo aquello cuanto es sujeto de represión y que es pulsional es totalmente de índole sexual, no hay otro tipo de pulsiones que se repriman, ya que es el Yo quien ejecuta la acción; no podría rechazar pulsiones yoicas o de conservación, sino solo aquello que venga a desestructurarlo o que amenace con ello. El Yo es un sistema de representaciones también, pero que provienen del exterior, pues se estableció dada la relación del organismo con el exterior, con los otros; así, no son más que representaciones culturales, de valores, de significaciones sociales, entre otros. El conflicto que se le presenta al Yo es la oposición de la cultura y el sexo. Solo se reprime lo sexual, que tendrá que ver con lo originario de lo sexual, es decir, con aquel primer investimento que, en otros términos, se acerca a los objetos prohibidos por la sociedad y, con ello, a la prohibición del incesto, por un lado, y a la del parricidio, por otro.

Sadomasoquismo

Especial atención hay que darle a uno de los destinos que Freud menciona y que es la vuelta hacia la persona propia, pues es aquí donde hallaremos el contenido agresivo de la pulsión sexual y que precede al concepto del siguiente apartado.

Freud coloca el *par sadomasoquista* para explicar que la pulsión del sádico, al dirigirse hacia él mismo, se convierte en masoquista, y viceversa, colocando al sadismo como primario, aunque en otros de sus textos, como *El problema económico del masoquismo* y *Pegan a un niño*, dirá que el masoquismo es primero.

En esencia, de lo que se trata en el sadomasoquismo, para Freud, es de la culpa. Si el sadismo fuera primario, se explicaría por aquella agresión que va dirigida al que se interpone entre la satisfacción y el sujeto, y luego debido a que quien se interpone es el padre, sobrevendría la culpa por aquellos deseos parricidas junto con los incestuosos, de tal manera que ahora se buscaría el autocastigo, sometiéndose el Yo masoquísticamente, al haber introyectado el conflicto edípico, dando por resultado la conformación del Superyó. "En todos los casos es la conciencia de culpa el factor que trasmuda el sadismo en masoquismo" (Freud, 1919/1999, p. 186).

Recordemos que la pulsión se recargó —apuntaló— en lo biológico, en la necesidad; y pensando en la necesidad del alimento, encuentra satisfacción en quien se lo provee, generalmente la madre —aunque pensemos que es más una función de nutrición y no la persona misma— Es ahí donde el objeto que satisfizo la necesidad biológica se convierte en el objeto de la pulsión, después también de deseo y de amor. Así, cuando esta satisfacción se interrumpe por algo externo, algo que distrae a la madre de su función es que la parte agresiva se dirigirá hacia el obstáculo. Cuando pasan los años y se puede personificar ese obstáculo, resulta ser, según la novela familiar, el padre, igual como función de obstáculo y no como persona misma.

"Decir que hay un masoquismo de origen es significar que en el principio está el Cuerpo" (Assoun, 2005, p. 91). El masoquismo como inicial lo explica debido a la dependencia biológica por la que pierde el objeto y que, al erotizarlo, el Yo se identifica con tal objeto, pero sobrevendrá la no identificación total con él, y es por ello culpable de no ser ese objeto de satisfacción. El Yo intenta sostener una relación erotizada con el Superyó (figura parental introyectada), pero esta nueva instancia ha surgido de un proceso de desexualización, lo que impide lo esperado y, por el contrario, lo que obtendrá será el continuo castigo del Superyó, quien solo posee la parte no sexual, es decir, la agresiva o mortífera. "El masoquismo es más antiguo que

el sadismo, y este es la pulsión de destrucción vuelta hacia afuera, que así cobra el carácter de la agresión" (Freud, 1933/1999, p. 97).[1]

La fantasía del niño de ser pegado evidencia su componente masoquista. Freud, al hablar de este par sadomasoquista, lo hace diciendo que en la forma de la fantasía tendrá el componente sádico, mientras que en la experiencia o en la satisfacción será masoquista. Solo aquel que ha pasado por el dolor puede pensar en provocarlo a otro. Quiere decir que en un mismo sujeto se tiene esa vuelta de la pulsión, no está hablando de una correspondencia en cuanto a personas, como lo ejemplifica con el caso de Dostoievski: "En las pequeñas cosas era sádico hacia fuera; en las cosas mayores, sádico hacia dentro, y por tanto masoquista" (Freud, 1928/1999, p. 177). Así, dice que, una vez satisfecho su autocastigo, el escritor era capaz de crear sus obras.

Esto concuerda con lo que Deleuze dice del masoquista, pero ya en cuanto a la personificación, de tal manera que el castigo es condición para el acceso al placer. Es decir, el masoquista se sabe culpable y busca su castigo, que puede ser a través de agresión física, verbal y humillación, o la simple larga espera, y luego puede con ello dar el paso siguiente al placer: "El masoquista espera el placer como algo esencialmente retrasado y prevé el dolor como una condición que hace posible, por fin (física y moralmente), el arribo del placer" (Deleuze, 2001, p. 38). La culpa que asume es la de transigir la ley del incesto, la de cometer incesto y acceder a la madre, en una manera de aceptar por adelantado la castración, el castigo al trámite de la pulsión y, por tanto, tener así el derecho al placer. Por eso habla de la mujer como la auténtica masoquista, en tanto asume su castración.

Es una especie de obediencia previa para desobedecer, pues recibe el castigo antes de infringir la ley. Es vivir la castración o la falta antes, para luego poder permitirse el placer incestuoso. Por eso, para Deleuze (2001), el masoquista es realmente el perverso, pues es quien deniega la ley: "A la denegación magnificadora de la madre ('no, a la madre no le falta simbólicamente nada') corresponde una denegación anuladora del padre ('El padre no es nada' es decir, está privado de toda función simbólica)" (p. 33).

[1] Para una revisión más detallada del complejo de Edipo y la segunda tópica freudiana, sugiero consultar el libro *Introducción al sadismo superyoico.*

Lo que castiga el masoquista en él mismo es a ese padre con quien se ha identificado, ese padre que ha quedado fuera, pues la madre —en sus tres versiones— es quien está presente: la madre primitiva o uterina, la edípica o amante y la oral o mortífera.

El masoquista, colocándose en un tiempo de espera, de voz media reflexiva, hace del otro el sujeto, para él convertirse en objeto, ser "pegado"; "el sujeto masoquista se encarna como objeto poseído" (Assoun, 2005, p. 78). Es voz media reflexiva, es la que caracteriza a la pulsión; no hay un sujeto que realiza la acción, no importa el sujeto, sino que la acción sea realizada. Por ello la traducción más precisa del texto de Freud, conocida como "pegan a un niño", donde podemos alcanzar a ver la ausencia del sujeto que pega, sería "un niño es pegado". Tampoco importa quién es pegado, sino que está la acción pero que ya se realizó, sin considerar por quién ni hacia quién.

Por parte del sádico, este se institucionaliza, se coloca del lado del que establece la ley, se identifica con la ley; así, es una identificación con ese padre que marca la castración del otro, siempre demostrando lo que puede hacer más allá de toda ley. Aquí hay negación, pero de la madre. Esta identificación con la ley no es otra que también con el Superyó. El sádico es puro Superyó; por tanto, está desexualizado y formado de pura pulsión de muerte porque ha tomado el lugar del criminal, de aquel que señala la ley a través de su transgresión, de su excepción.

Se dice que uno de los conflictos del sujeto está entre las demandas del Superyó y la necesidad de preservarse del Yo. En el sádico, no hay tal tensión, pues se identifica con ese Superyó, pero dirigiendo su agresión hacia fuera, hacia el otro, pues no tiene porque castigarse a sí mismo o a su yo, cuando se le ha permitido todo.

Para Orozco, no hay esa negación de la madre que dice Deleuze en el sádico; al contrario, en el acto del sádico hay un "crimen de traición de la madre al padre, de la madre a su deseo por el padre, a su deseo de padre" (Orozco, 2007, p. 94). Hay un traspasar la ley, la del padre, pero contando con la anuencia de la madre. Ya que la ley es contra el parricidio y el incesto, es ella quien da paso a ese crimen:

> No hay masoquismo sin reactivación de Edipo, sin "resexualización" de la conciencia moral. El masoquismo se caracteriza no por el sentimiento de culpa, sino por el deseo de ser castigado: la punición viene a resolver la culpabilidad y la angustia correspondiente, abriendo la posibilidad de un placer sexual. (Deleuze, 2001, p. 55)

Se ve en esta frase que están en los opuestos el sádico, en la desexualización y en la pulsión de muerte, y el masoquista, en la resexualización edípica. Esta resexualización del masoquismo será más fuerte si lo ha sido la desexualización previa, de donde se puede concluir que no hay posibilidad alguna de que un sádico sea masoquista o viceversa, puesto que están en polos opuestos. Para Deleuze es claro que, mientras el sádico es puro Superyó en el que queda fuera de sí el Yo, el objeto y el sujeto se anulan; pretende la aniquilación del otro como sujeto diferente; en cambio, el masoquista es un Yo que lo que pone en escena, pero fuera de sí, es un Superyó a través de las mujeres golpeadoras, que al final no dejan de ser grotescas. Es una especie de burla al Superyó, como lo ejemplifica Sacher Masoch en *La Venus de las pieles*.

Si existe un sadismo en el masoquismo, tiene que ver con la expiación. Si existe un masoquismo en el sadismo, es para no reparar nada. Es claro que estando en posiciones diversas con respecto a la pulsión, por lo menos como lo maneja Deleuze, ahí no hay posibilidad de una parcialidad pulsional: "El sadismo y el masoquismo no están compuestos respectivamente de pulsiones parciales, sino de figuras completas" (Deleuze, 2001, p. 36).

Lo cierto es que tanto el sadismo como el masoquismo se sitúan, cada uno de una manera diferente, fuera de la ley: el sádico, manteniendo esa voluntad o ley de la no castración, y el masoquista, asumiendo la castración para luego mostrar que no está.

Claro que en Deleuze se ve el manejo del sadomasoquismo desde la imposibilidad de que sean correspondientes, claro, en un asunto de personas. No hay que olvidar que Freud habla de tres tipos de masoquismos: el que es precisamente el perverso (erógeno), el femenino y el moral. El perverso es el que se puede ver más fácilmente, el femenino fue calificado de fundamental y el moral es el que subyace a todo sujeto.

El masoquismo moral sería el del autosabotaje, desligado de un objeto amado (sujeto); lo desplaza a un destino, a una realidad que lo agrede. Este masoquista que padece el infortunio de la vida, ¿no parece estar en manos del Superyó si interviene la resexualización edípica?

Hasta aquí es evidente que el sadismo sigue siendo un representante de la pulsión de muerte. El masoquismo, por su parte, ¿tendría que ver con esa pulsión de muerte dirigida al Yo, tal vez mezclada con la pulsión sexual? "El masoquismo es una manera de preservar la destructividad en el interior y de enlazarla a las pulsiones eróticas" (p. 96), afirmaría Assoun (2005).

La pulsión de muerte

A partir del trabajo con los sueños de punición, los fenómenos transferenciales y las condiciones sociales, Freud, después de venir hablando del conflicto entre pulsiones yoicas y sexuales, propone otra dicotomía que le dé una explicación más adecuada, así hablará entonces del conflicto entre *pulsión de vida* y *pulsión de muerte*.

Hasta antes de *Más allá del principio del placer,* Freud habló en pocas ocasiones de la agresividad como algo propio del ser humano, colocándola incluso del lado de las pulsiones de autoconservación o yoicas, como aquella fuerza que facilita el control del sujeto y lo ayuda a sobrevivir.

Luego habló de pulsión de dominio, del dominio sobre los demás, por lo que el hombre se comporta con agresividad para controlarse ya no a él mismo, sino al otro, encontrando en esto placer. "No es fácil para los hombres abandonar la satisfacción que se une a la agresión" (Masotta, 1990, p. 40), es el otro que siempre nos representará una causa para agredirlo, sea simplemente porque es otro diferente de uno, pero que al mismo tiempo es tan parecido. Tal idea la desarrollará luego Lacan con su estadio del espejo.

También encuentra la pulsión de destrucción, dirigida al exterior o a los otros, pero dice que "conocemos que la pulsión de destrucción es sincronizada según reglas a los fines de la descarga, al servicio el Eros" (Freud, 1923/1999, p. 42). Por lo tanto, se debe a la mezcla pulsional o a que en las pulsiones sexuales o de vida hay un componente agresivo que no tiene que ver con la pulsión de muerte.

Después de hacer su recorrido por las pulsiones de vida a través de la clínica, se da cuenta de que en la transferencia hay reacciones que se oponen a la cura, y además una tendencia a repetir situaciones displacenteras. Por supuesto, sin olvidar que ya en su interpretación de los sueños se encuentra con aquellos que no parecen ser de satisfacción de deseo, sino más bien de castigo o de pesadillas. Es ahí, por la teorización de sus contemporáneos, donde comienza a ver la pulsión de muerte. Esta es una noción expuesta totalmente en el Más allá… puesto que, como diría Masotta (1990) "más allá del placer siempre nos encontramos otra vez con el placer" (p. 75), aunque no sea entendido de la misma manera.

Deleuze (2001) lo dice así; "Más allá del fondo, lo sin-fondo" (p. 60), porque no tiene que ver con un no-fondo, puesto que en el inconsciente no hay negativos; es simplemente otra forma de placer, no es el displacer o el no placer, es un más allá del placer. Como se sigue hablando de pulsión, y la pulsión es movimiento, se podría decir que es justo en esto donde está el placer, no tanto en la disminución de la tensión; "el yo la ejerce como sujeto activo, que la repetición es ejecutada por el yo como acto, en definitiva: un placer del ejercicio" (Masotta, 1990, p. 76). Podría considerarse entonces que la disminución de la tensión es displacer simplemente, mientras que el movimiento es el placer.

Retomando, Freud contrapone a la pulsión de vida la de muerte, a las que en algún momento se les ha hecho equivalentes a los términos clásicos de Eros y Tánatos:

> Por eso, aunque Eros no sea más dado que Tánatos, por lo menos se hace oír y actúa. Pero Tánatos, lo sin-fondo portado por Eros, devuelto a la superficie, es fundamentalmente silencioso: y tanto más terrible. Nos pareció entonces que para designar esa instancia trascendente y silenciosa, había que conservar la palabra "instinto", instinto de muerte. En cuanto a las pulsiones, las eróticas y las destructivas, deben emplearse solo para designar los componentes de las combinaciones dadas, es decir, los representantes en lo dado de Eros y de Tánatos, los representantes directos de Eros y los representantes indirectos de Tánatos, siempre mezclados en el ello. (Deleuze, 2001, p. 61)

Deleuze aclara en este párrafo, además de la diferencia entre pulsión de vida y pulsión de muerte, la diferencia que existe entre aquel componente silencioso y que llevará al sujeto a lo inanimado, y lo que mueve a la agresión con el otro, nombrando a uno *instinto* y al otro *pulsión*.

Eidelsztein (1999), por su parte, dirá: "Llamamos instinto al saber que reconoce un cierto estímulo, pero no la fuerza que lo impulsa" (p. 15). Así, el instinto de muerte tendrá que ver con aquello que por herencia posee el sujeto, que todo sujeto tendrá como un saber inconsciente o de contenido de la especie, mientras que pulsión es aquello que empuja a lo inanimado.

La pulsión de vida es tan clara como agrupar a las pulsiones yoicas, de autoconservación y sexuales en una sola, mientras que la pulsión de muerte parece ser de otra naturaleza y de difícil acceso, a no ser por sus retoños. La pulsión de vida busca la unión, la integración; por tanto, su objeto es total, mientras que la de muerte va tras la disolución, y por ello tendrá "un indicio de objeto" (Laplanche, 1998, p. 31), de ahí que, para André Green, la pulsión de vida busque la objetalización, mientras que la de muerte la desobjetalización o el desinvestimiento.

Por eso, para Segal (1998), "el narcisismo primario es totalmente la expresión de la pulsión de muerte […] en la medida en que es des-objetalizante" (p. 106).

Se dice que la pulsión de muerte es silenciosa o muda, pero Freud afirma que lo es mientras no se manifieste al exterior como pulsión de destrucción. Le queda claro a Freud que no es por la ambivalencia del amor y el odio que pueda decirse que el odio y la hostilidad estén del lado de la pulsión de muerte, pues más bien tienen que ver con esa otra pulsión sexual y de vida porque siguen siendo una forma de lazo con el objeto, incluso hasta más fuerte. De hecho, para Freud el odio y el amor no son opuestos, más bien sería el odio-amor o amor-odio opuestos a la indiferencia.

Freud dice que es la primera pulsión, la pulsión de muerte, pues es aquello que lleva al organismo a querer regresar a su origen, es decir, de lo animado a lo inanimado, como estaba antes. Como ya lo había dicho desde el *Proyecto*, la finalidad de la pulsión es cancelarse; el organismo trata todo el tiempo de volver a la homeostasis; es decir, reducir todo lo que pueda la tensión. Es esto lo que después se conocerá como *principio del placer*, de tal manera que el placer por excelencia sería la descarga

total, la eliminación de todo estímulo, el nirvana o la inercia al nivel cero. Esto contradice, por tanto, al principio de constancia, que más bien lo que precisa es que exista una tensión mínima pero igual que sostenga la necesidad de buscar su eliminación. Esos serían los requerimientos de la pulsión de vida.

La pulsión de muerte estaría en un principio mezclada con la de vida, apuntalada en esta y activa mientras se dirige a otro para no aniquilarse a sí misma. "A la inversa, si esta agresión hacia fuera era limitada, ello no podía menos que traer por consecuencia un incremento de la autodestrucción, por lo demás siempre presente" (Freud, 1930/1999, p. 115). Al comer, se destruye el alimento; en el acto sexual debe haber un poco de agresión para unirse al otro sexo.

Pero para Freud, llega a un extremo la pulsión de muerte, que las otras pulsiones parciales simplemente van a cumplir la misma meta, pero por caminos diferentes, o se diría, por vías más lentas:

> La importancia teórica de las pulsiones de autoconservación, de poder y de ser reconocido cae por tierra; son pulsiones parciales destinadas a asegurar el camino hacia la muerte peculiar del organismo y a alejar otras posibilidades de regreso a lo inorgánico que no sean las inmanentes. (Freud, 1920/1999, p. 39)

Esto querría decir que tanto la pulsión de vida (pulsiones sexuales, de conservación, yoicas, parciales, etc.) como la pulsión de muerte tienen la misma meta, solo que esta última iría de manera más contundente a cumplir con su objetivo, mientras que las otras lo retrasan para permanecer en el trayecto. Es por esto que las pulsiones de vida son más notorias, en tanto que son duraderas:

> Las pulsiones de vida tienen muchísimo más que ver con nuestra percepción interna; en efecto, se presentan como revoltosas, sin cesar aportan tensiones cuya tramitación es sentida como placer, mientras que las pulsiones de muerte parecen realizar su trabajo en forma inadvertida. (Freud, 1920/1999, p. 61)

Es en el sadismo donde Freud encuentra su representación más clara, donde queda desexualizado el objeto, como ya se vio en el apartado anterior. Como si ahora se cambiaran los papeles y fuera la pulsión sexual la que está al servicio de la de muerte, por el propósito sexual que pudiera aparentar tener el sádico, pero aun así aquí encuentra otra satisfacción que no es solo la de destruir, sino también la de imponerse como el poderoso, el que domina, y esto no es otra cosa que un goce narcisista, lo que lleva a pensar de nuevo en lo erótico de la pulsión de muerte.

Como ejemplo, en el caso Schreber, Freud ve la relación entre este par de pulsiones por medio del discurso, "como si el concepto de Schreber sobre la bienaventuranza {Seligkeit} hubiera nacido por condensación de los dos significados principales de la palabra alemana: difunto y sensualmente dichoso" (Freud, 1911/1999, p. 29).

Así, la pulsión sexual está conjuntada con la de muerte como si fueran una sola, y tal vez sea por ello que Lacan dice que solo está la pulsión de muerte pues, como se ha visto, para Freud mismo todas las pulsiones están encaminadas al mismo sitio, solo que unas van más lentas que otras y todas poseen esa energía que las mueve, llamada libido. "La pulsión de muerte no tiene energía propia, su energía es la libido. O, mejor dicho, la pulsión de muerte es el alma misma, el principio constitutivo, de la circulación libidinal" (Laplanche, 2001, p. 169).

La pulsión en Lacan

Noción de pulsión

Es tal vez el último desarrollo freudiano —además de su idea del significante—, en el que plantea que todas las pulsiones están dirigidas a la misma meta de la pulsión de muerte, pero por caminos distintos, el que lleva a Lacan a hablar solo de la pulsión de muerte. Por supuesto que, al seguir los pasos de Freud, habló en sus primeros seminarios también de diferentes pulsiones o les dio nombres de acuerdo con su objeto, y si el objeto es parcial, como ya se mencionó, por tanto, la pulsión lo es. De ahí que se puedan encontrar textos en los que habla de la pulsión oral, la anal, la escópica, entre otras.

Lacan diferencia el instinto de la pulsión considerando al primero como un contenido o un saber que permanece en el sujeto. De ahí que pueda hablar de instinto de muerte, por el que todo sujeto sabe que morirá; está ahí ese saber, inconsciente y desconocido, pues al mismo tiempo el sujeto no sabe qué es la muerte, pues es una experiencia de la que no hay referencia. Mientras que la pulsión será un movimiento, una tendencia, una deriva.

Al entrar en la discusión de la existencia del principio del placer y el de realidad, Lacan cuestiona la preconcepción que se tiene sobre lo que es el placer, equiparándolo con el bien, pues no se refiere este término a un asunto moral o filosófico. No se habla aquí del Bien Supremo, sino del bien del sujeto, que puede ser incluso su destrucción o la inactividad, como ya lo habría dicho Freud; mientras que la idea de realidad también escapa a lo que sucede en el inconsciente, tal como se podría pensar inmediatamente, puesto que, sosteniendo a Freud, el objeto que se busca para conseguir el placer no está en la realidad, no es real, es alucinado, en tanto perdido y, en ese caso, lo que se buscará no es precisamente el objeto en sí mismo, sino ese placer que originó; así pues, esa misma búsqueda o espera es ya algo de ese placer. Desde ahí se puede notar la diferencia de la pulsión con cualquier otro estímulo que podría satisfacerse por un movimiento de arco reflejo. Por otra parte, mientras el placer es un logro o una meta, alcanzar una situación, la pulsión es puro trayecto, por eso no está determinada por el objeto y puede hacer uso de cualquiera.

Conociendo el principio sobre el que gira el psicoanálisis lacaniano, es decir, que *el inconsciente está estructurado como lenguaje*, es posible comprender que la idea de pulsión en Lacan girará en torno al significante, o dirá que es un artificio gramatical situado en el lado del tesoro de los significantes; por lo tanto, estará articulado. De tal manera que, al abordar el asunto de la represión, que para Freud está sobre el agente representante de la representación, ahora en este otro autor estará efectuada sobre el significante. Para Lacan, esa "representación" es del bien —o del placer— que proporciona la cosa buscada, y es ahí mismo, en esa "cosa" a la cual nombra el *Das Ding*, donde también se percibe el más allá de ese bien, el mal o el daño que podría causarle de tener acceso a ella. Por eso es que hay un intermediario, y por eso es que el placer en su límite encuentra el displacer, y

porque, además, el placer que busca la pulsión, es el de la repetición, el de la continuidad.

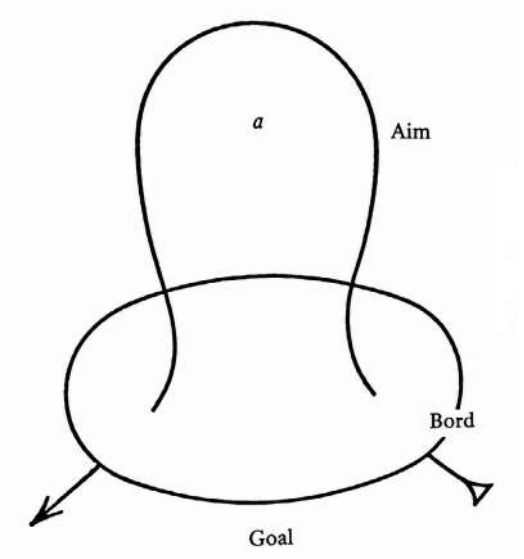
Al leer los destinos de la pulsión, se detiene para concentrase en uno de ellos, que es la sublimación, y dice de ella que "se caracteriza por este cambio en los objetos o la libido, no por intermedio directo de un retorno de lo reprimido, no indirectamente, no sintomáticamente, sino de una forma directamente satisfactoria, la libido sexual halla su satisfacción en los objetos" (Lacan, 1960a). Naturalmente que estos objetos tendrán que ser los socialmente permitidos. Lo interesante de esta afirmación es que la sublimación muestra el contenido de la pulsión, que es lo sexual, oponiendo, además, al principio del placer con el de realidad, en tanto que este último lo que representará será una realidad, pero desexualizada, como lo afirma en el Seminario 11. En todo caso, el principio de placer está sometido a una ley que es la de la búsqueda; por lo tanto, no se acerca a la satisfacción, aunque en la sublimación lo parezca.

Así, la sublimación no es un síntoma, no es la sustitución de algo reprimido, sino un cambio de fin de la pulsión. "Y la fórmula más general que les doy de la sublimación es ésta: que eleva un objeto […] a la dignidad de la Cosa" (Lacan, 1960b), a ese *Das Ding* que es de imposible acceso y cuya esencia resulta no del todo benéfica para el sujeto.

Si la pulsión halla una satisfacción —alucinada— es porque es parcial y no total, de tal manera que no necesita del objeto, más que parcialmente. Su finalidad no está en llegar al objeto o poseerlo ni siquiera parcialmente, sino en retornar a su fuente. De ahí que se pueda afirmar que "el camino de la pulsión es la única forma de transgresión permitida al sujeto con respecto al principio del placer" (Lacan, 1964b), ya que el principio del placer supondría una cancelación del estímulo, una distensión; la pulsión solo lo consigue por el trayecto y no de manera total, de tal suerte que eso hace la continuidad de la pulsión.

Su idea de pulsión, como se sabe, es representada en el circuito, lo que indica que su finalidad se logra al volver a la fuente de ella después de rodear al objeto *a*, y que es en ese recorrido donde surge el sujeto. Estará en tres niveles de oposición gramatical: en el de lo real (lo que interesa y lo indiferente), en el de lo económico (placer-displacer) y en lo biológico (actividad-pasividad).

Figura 1. *Circuito de la pulsión, en el Seminario 11*



Fuente: Lacan (1964b).

Y estará presente la libido, como laminilla ultraplana y bidimensional:

> La libido es el órgano esencial para comprender la naturaleza de la pulsión. Este órgano es irreal. Lo irreal no es lo imaginario. Se define por articularse con lo real de un modo que no podemos aprender, y por ello justamente, requiere de una presentación mítica, tal como la nuestra. Por ser irreal no impide a un órgano encarnarse. (Lacan, 1964c)

Distinguir entonces a la pulsión de vida de la de muerte, para Lacan, es simplemente ver dos aspectos de la pulsión, que más bien para él es solo considerar que la pulsión es sexual, atravesada por el significante y, por tanto, por la muerte, la muerte como significante. "El significante es el de la muerte del Otro" (Lacan, 1960c).

Por tanto, no es extraño que después Lacan afirme que la pulsión lo que representa es la sexualidad, aunque lo haga parcialmente; estará relacionado por tanto, con los síntomas y lo reprimido, de ahí que se pueda conside-

rar como un montaje o andamiaje, así como una ficción que no tiene ni pies ni cabeza.

A partir de esta idea de la pulsión es como también se puede dar paso a cómo está marcada por la muerte, pues para Lacan la sexualidad inevitablemente tendrá un lazo con la muerte. En primer lugar, porque el acto sexual marca a la especie humana como necesitada del apareamiento para sobrevivir y no perecer, y porque el acto sexual es una especie de experiencia de muerte; la sexuación de los sujetos es este señalamiento de que son finitos, necesitados del otro. La sexuación además supone que un sujeto sea femenino o masculino, y esto lo ingresa en el orden simbólico; es decir, son nombrados; por lo que han muerto para dar paso al nombre, es decir, está en el orden de los significantes, y estos, como se sabe, representan la muerte de lo que significan:

> Ven entonces cómo la misma razón que hace que el ser viviente sea inducido a su realización sexual por el señuelo hace que la pulsión, la pulsión parcial, sea intrínsecamente pulsión de muerte, y representa por sí misma la porción que corresponde a la muerte en el ser sexuado. (Lacan, 1964c)

Pero Lacan no habla siempre de pulsión de muerte como tal, incluso en el Seminario 7 la contradice, o por lo menos se toma algunas clases para mostrar el argumento de Bernfeld, quien dice que la pulsión conlleva historicidad, memoria, y la muerte no hace historia, la destrucción sí; por lo tanto, hay pulsión sexual y pulsión de destrucción, tomando la pulsión de muerte freudiana como una simple tendencia entrópica del organismo.

Así pues, la pulsión es sexual, es una representación parcial de la sexualidad y, por ello, estará ligada a la muerte, a la muerte como aquello que es imposible de ser pensado, y por tanto es lo Real, "puesto que este impensable es la muerte, cuyo fundamento de Real es que ella no puede ser pensada" (Lacan, 1976).

Retomando la idea de la historicidad en la pulsión, Lacan afirma, junto con Bernfeld, que la muerte no tiene historia; sin embargo, la pulsión en sí misma la tiene, al ser atravesada por el significante, puesto que, como diría Juan el apóstol: "Al principio era el Verbo, lo que quiere decir, el significan-

te. Sin el significante en el principio, es imposible articular la pulsión como histórica" (Lacan, 1960d).

La pulsión aparece en esa fórmula del ($ ◊ D), es decir, es a partir de la demanda, bajo el efecto del significante, como se da paso a la pulsión. En otras palabras, al articularse la demanda gramaticalmente aparece la pulsión, la pulsión que es hablada por los objetos, donde de lo que hablan es de la sexualidad en metáfora y metonimia. De ahí, en el recorrido da paso al deseo. Así, la pulsión y el deseo estarán entrelazados en ese mismo montaje, relacionados por el objeto. "El objeto del deseo es la causa del deseo, y este objeto causa del deseo es el objeto de la pulsión, es decir, el objeto en torno al cual gira la pulsión" (Lacan, 1964e). Deseo y pulsión dan la vuelta alrededor del objeto.

Pero, a diferencia de la pulsión, el deseo es "lugar de unión del campo de la demanda en el que se presentifican los síncopes de la demanda, con la realidad sexual" (Lacan, 1964a), y que está del lado de la interpretación, en el orden de la metonimia, además que la diferencia se encontrará en la manera en que se acercan o se relacionan con el objeto, pues mientras que la pulsión no depende de este, en el deseo, el objeto es la fantasía o señuelo.

Es así como vemos que, en Freud, la pulsión de la que se habla es la de muerte, con todas las demás orientadas por ella; mientras que, en Lacan, es también la de muerte la que subyace por la fuerte relación que encuentra con la sexualidad, pero intervendrá aquí un elemento más relevante: el deseo, al cual también podrá nombrar como deseo de muerte.

El deseo

El deseo estará impreso en el inconsciente, y lo que marcará será la falta, un vacío. El deseo del hombre es el deseo del Otro (Lacan, 1960f), de ahí que la falta o falla es del Otro. Lacan también dice que "el deseo es el representante no representativo" (Lacan, 1964d), lo cual marca la diferencia con la pulsión, en cuanto que esta última es representación. Esto resulta porque el deseo ya está articulado, es aquello producido por el significante, es ya una interpretación, interpretación que está sobre el objeto, que es una fantasía o un señuelo y cuya relación siempre será de distancia, incluso en algunos

casos, de rechazo, en tanto que lo que se puede señalar es que el deseo es de desear.

Así, la tesis de que el deseo del hombre es el deseo del Otro, esta identificación, es justamente la que lleva a pensar que lo que se desea es desear como el Otro lo hace, además de desear al Otro, o lo que el Otro desea. Es a esto a lo que Lacan llama *trazo unario en la identificación*, esa relación con el Otro en el campo del deseo y que está constituido en el significante, pues el Otro es quien provee el tesoro de significantes, de tal manera que lo que se desea es lo que se cree o se "sabe" que el Otro desea. De lo único que se puede estar seguro sobre el deseo es que se desea, sin necesariamente conocer qué se desea.

Lo cierto es que la identificación es con el desear, más que con el objeto del deseo. Este solo sirve para enmarcar la falta frente a un objeto. Pero si está ya articulado y no es articulable, se puede suponer que ese desear es de ser deseado.

Tan es desconocido el objeto del deseo que en el inconsciente, como se sabe, no se distingue lo que es de la realidad de lo que es la alucinación. Ya que el deseo proviene de un indicio biológico, de una relación con una suerte de objeto perdido, lo que se desea es aparentemente esa satisfacción inicial, no tanto al objeto. "En su ley, en tanto deseo, no hace ningún tipo de diferencia entre la satisfacción alucinatoria y la satisfacción real" (Pontalis, en Lacan, 1959a).

Ese primer objeto de la satisfacción, ese al que Freud llamó *perdido*, es el que se supone se trata de reencontrar; en Lacan es nombrado como el *Das Ding*, a quien, por suerte, no se encontrará más que "sus coordenadas de placer; ese estado de desearlo y de esperarlo en el cual será buscado en el nombre del principio del placer, esta tensión óptima por debajo de la cual ya no hay seguramente ni percepción ni esfuerzo" (Lacan, 1959b), puesto que el *Das Ding*, esa Cosa, no es más que ese Otro acosador que no representa solo el placer, sino el más allá de este.

De ahí que el objeto del deseo, como fantasía o señuelo, es más bien una representación del bien que evoca el *Das Ding*, o como el poseedor de ese bien que puede proporcionar el *Das Ding*.

Ese *Das Ding*, esa Cosa que además muestra el daño posible o en sí misma a la muerte, es la que provoca que el acercamiento sea distante, sea

paulatino, sea siempre de añoranza y nunca de un encuentro total. Es justamente lo que va a caracterizar al deseo, puesto que el deseo no irá directamente hacia la Cosa, sino que se mantendrá a distancia, buscando, solo entonces, la experiencia del desear —para repetir la vivencia. Así es entendible la contradicción aparente que se encuentra en que lo que aporta mayor placer es el extender el deseo en los llamados "placeres preliminares", en lugar del acto sexual en sí mismo, por ejemplo, puesto que se retiene un estado de displacer, con tal de conseguir o de mantener el mayor tiempo posible el placer de desear.

Así, el objeto queda aislado en el deseo, separado, como si el objeto tuviera la condición no solo de esa Cosa, sino de lo Bello. "Lo bello, en tanto se manifiesta, intimida, prohíbe el deseo" (Lacan, 1960e). De esta manera, se puede observar en la fórmula del fantasma, que es donde se muestra el deseo ($ ◊ a). Justamente ese fantasma lo que puede estar diciendo es un "no-toquen-lo-bello". Por eso es que Lacan llega a formular que el deseo es deseo de nada, por su imposibilidad de satisfacción, entonces no es una sustancia.

Lacan no cambiará en su idea de que el deseo es deseo del Otro, y que ese Otro no es más que la Madre; así, lo que en principio se juega en esta relación dialéctica del deseo es ser deseado por ella. Esto es a lo que él llama el *deseo original*. El deseo de lo que ella desea o lo que le falta es el falo:

> El objeto de deseo de la madre es justo eso de lo que está suspendido todo lo que en lo sucesivo para el sujeto va a ligar el acercamiento de su propio deseo a un efecto de destrucción, que al mismo tiempo subordina, define el acercamiento de este deseo al significante del efecto del deseo en la vida de un sujeto, por sí mismo, a saber el falo. (Lacan, 1958c)

De donde la identificación inicial es con ese falo, es ese rasgo unario, ese primer significante. Pero ese falo que solo marca la ausencia o la falta es lo que regresa a la condición esencial en esto que es el ser deseante.

Al hablar del Edipo, donde se realiza este montaje pulsional y se ordena el deseo, en el que aparece la amenaza de castración, lo manejará de una manera distinta a la freudiana, explicando que aquella ley que prohíbe el

incesto, esa amenaza de castración, representa otras cosas, no solo el temor a eliminársele un miembro del cuerpo. Siguiendo lo que Freud afirmara, de que el cuerpo entero se ofrece como ese miembro, que cobra relevancia a nivel de falo, por lo que llama la primacía del falo (de ahí el nombre de la etapa fálica), es por tanto una amenaza de muerte; además, no es todo, es "desaparición del deseo. Es eso a lo que el sujeto temería en el complejo de castración" (Lacan, 1958b).

Tal amenaza de castración o ley, en realidad, resulta una protección para el sujeto, puesto que aquella cosa u objeto buscado es el del deseo, que llevará, si se tiene el acceso, a un placer tan grande que resultará displacentero o que llevara a la satisfacción total y esa distensión no es otra cosa que la muerte o la inanimación. Si se identifica ese objeto con el seno o la placenta (siendo parciales), sobrevendrá la devoración, la reintegración, a la madre. Es esto lo que viene a evitar la amenaza de castración, puesto que el sujeto, buscando eso que le falta, se identifica en esa búsqueda con la del Otro, poniéndose en el lugar del objeto, de tal manera que, como aquello que le falta al Otro, a la madre, no es más que el falo. Así, la amenaza de castración viene a anunciarle que no puede reintegrarse, que no es el falo; no solo a él, sino también a esa madre. La amenaza de castración es una amenaza de muerte que, al mismo tiempo, evita justamente la muerte o la reintegración del niño, como falo, por la madre:

> ¿Acaso la Ley es la Cosa? ¡Oh, no! Sin embargo, solo tuve conocimiento de la Cosa por la Ley. En efecto, no hubiese tenido la idea de codiciarla si la Ley no hubiese dicho —Tú no la codiciarás. Pero la Cosa encontrando la ocasión produce en mí toda suerte de codicias gracias al mandamiento, pues sin la Ley la Cosa está muerta. Ahora bien, yo estaba vivo antaño, sin la Ley. Pero cuando el mandamiento llegó, la Cosa ardió, llegó de nuevo, mientras que yo encontré la muerte. Y para mí, el mandamiento que debía llevar a la vida resultó llevar a la muerte, pues la Cosa encontrando la ocasión me sedujo gracias al mandamiento y por él me hizo deseo de muerte. (Lacan, 1959)

Es evidente cómo la Ley, esa intervención castrante, posee en sí misma el anuncio del deseo, que no es otro que un deseo de muerte. El deseo incestuoso es deseo de muerte si se deja a un lado lo sexualizante que conlle-

va este término y se ve lo que esto significa, como el cumplimiento de la reintegración del falo en la madre. Pero aun sexualizándolo, implicaría para Lacan la muerte, por lo ya revisado en su idea de lo que es la sexualidad.

Esta Ley que se presenta como la amenaza de castración es, por tanto, para el niño, pero también para la madre, puesto que el deseo que ha develado esa Ley, dado que parece ser el del niño hacia su madre, no es otra cosa que aquel con el que se ha identificado, que es el de la madre hacia él. "El término *niño deseado* es aquel que responde a la constitución de la madre en tanto que asiento del deseo" (Lacan, 1958a).

Ley que prohíbe el deseo, pero que, dada la prohibición, lo que hace es provocarlo o dejarlo ver, como ya lo había mencionado Freud en su *Tótem y tabú*, pues por la Ley se devela el deseo. Esta ley del padre es la del deseo de la madre. Entonces, el deseo del padre es la Ley, mientras que el deseo de la madre se opone a ella. De ahí que el deseo en sí mismo estará conformado por esa tendencia de desear siempre, limitada por la Ley. Ley que conduce a seguir deseando.

Aunque para el niño pareciera que el objeto es la madre, lo cierto es que la madre no puede ser el objeto más deseable, pues le supone la muerte; así, esta Ley de prohibición lo que hace es conducir hacia otros objetos; eso supone un orden del deseo y una orden en el deseo, constituida por la Ley.

La Ley del deseo que es impuesta por el padre es la de desear. La castración es quien regula al deseo, pero esa misma ley lleva en sí misma otro componente más, que es el goce: "El sujeto no satisface simplemente un deseo; él goza de desear, y es una dimensión esencial de su goce" (Lacan, 1958b).

La ley que prohíbe lo que impone es a gozar, a gozar de estar en falta, y de estar buscando ser el falo del Otro, lo que determina el ser gozado por el Otro. El ser usado por el Otro. Así, este goce del que habla Lacan no es del disfrute —más que del Otro—, sino que es un imperativo a gozar, a estar en falta siempre deseando y no poder más que hablar de ello, sin alcanzarlo realmente.

Si se alcanzara el objeto, la Cosa, lo único que se obtendría sería el dolor o la muerte. Esto sería ir más allá del placer. "El dolor del prójimo y también el propio dolor del sujeto, pues en este caso no son más que una única y

misma cosa. No podemos soportar el extremo del placer, en la medida en que consiste en forzar el acceso a la Cosa" (Lacan, 1959c).

El plus-de-gozar

El goce fue un término retomado por Lacan que se ha manejado desde diferentes perspectivas, hasta equipararlo con la pulsión de muerte o con aquello que está más allá del principio del placer. De esta manera, el principio del placer es un límite al goce. Así de ambiguo resulta, puesto que Lacan hablará del goce fálico y del goce del cuerpo, pero el cuerpo como imaginario del Otro.

Es decir, para que exista el goce, se requiere del cuerpo, pero no se habla de un placer ilimitado, un placer sumamente placentero, no es a este goce al que se refiere. Es al goce como el uso de ese cuerpo, un goce donde no hay sujeto que goza, sino sujeto gozado u objeto de goce.

Un cuerpo, pues, es "algo que puede gozar, solamente se lo hace aparecer como la metáfora del goce de otro" (Lacan, 1967), ya que el cuerpo es el lugar del Otro, es aquello constituido en la imagen especular. Es el complejo de castración, ese que muestra la falta, el que detiene el goce, pues no se puede ser el complemento del Otro, pero sí se está a merced del Otro, puesto que el deseo se ha identificado con el de él. ¿Así el sujeto deseará que el Otro goce?

El Otro es el que puede gozar, es quien no solo puede, sino que lo demostrará, lo mostrará todo el tiempo al sujeto, de ahí que Lacan (1969a) diga que "el prójimo es la inminencia intolerable del goce. El Otro no es más que el terraplén impío". ¿De qué es de lo que goza el Otro? Del saber, del saber sexual que no le está permitido al sujeto. Por ello, el sujeto estará no solo condenado a seguir deseando alcanzar eso que tiene el Otro, ese deseo del Otro que le permite el goce.

"El significante es la causa del goce", puesto que se habla de él, pero también "por ser su término, el significante es lo que hace alto en el goce" (Lacan, 1973a).

Es por ello que del Goce del que se habla en el Seminario 17 es del goce cerrado, el del falo, que, por tanto, es imposible de alcanzar, porque es un

goce que contiene el vacío o la muerte, es el goce fálico prohibido (la madre). Justamente es tan imposible que lo que marca es la falla o la carencia del goce sexual, puesto que mostrará esa imposibilidad, esa falta de conseguirse, pues no goza quien tiene el falo o quien lo recibe (físicamente en lo sexual), sino que el goce le pertenece al falo, no a quien lo porta. Al necesitar del otro para ese intercambio sexual, manifiesta la castración, la incompletud.

Pero lo que sí tiene el sujeto es el "plus-de-gozar", que surgirá a partir de esta intermediación del significante, de esa pérdida de goce y de esa evitación del goce, cuyo único acceso es a partir del saber.

Esta idea del "plus-de-gozar" es explicada en Lacan más claramente a partir de la construcción de los cuatro discursos, los cuatro contextos del decir o las cuatro formas de lazo social, tomado entonces de la teoría económica marxista y de Hegel.

En cada discurso hay cuatro lugares: el del agente, que manda o domina; el del que trabaja; el de la verdad subyacente y el del producto del discurso.

Figura 2. *Lugares del discurso*

Agente, Mando, dominante → El que trabaja
Verdad subyacente Δ Producción (lo producido)

Existen cuatro funciones: S, que es el significante Amo; el $, que es el sujeto; el S2, que funciona como saber; y el *a*, que es el plus-de-gozar.

Además, las relaciones que se dan en cada contexto estarán marcadas por las líneas o flechas dibujadas en el matema, de tal manera que el agente tiene una relación de mando sobre el que trabaja; en otras palabras, relación de amo con su esclavo, lo que da como resultado un producto, que es imposible que se relacione con la verdad subyacente reprimida por el amo. La relación que podría existir entre el lugar del agente y el del producto o desde el que trabaja y la verdad subyacente de oposición. Esto tiene como base el cuadrado aristotélico, donde las relaciones cruzadas son de contradicción.

Figura 3. *Discurso del amo*

$$\frac{S1}{\$} \rightarrow \frac{S2}{\Delta\ a}$$

En el discurso del Amo, este, como significante primero, como rasgo unario, como también el falo, ordena que trabajen los significantes alrededor de la afirmación de su goce, para dejarle un resto, un sobrante, es decir, el plus-de-gozar. A su vez, deja la castración al sujeto, la imposibilidad, evitando pues que el sujeto goce, pero también que no desee por él mismo. "El discurso del amo excluye al fantasma" (Lacan, 1970a, p. 114) puesto que, en el renglón inferior, impide que el sujeto se relacione con su objeto, pero tampoco con el plus-de-gozar, lo que implica que en este discurso solo hay ley, órdenes, sin deseo.

En el discurso de la histérica se ordena a desear, a somatizar, a hacer síntoma, a buscar el falo. Se coloca ella misma como el objeto del que no se puede saber, porque no hay esa relación entre el objeto y el saber, pero lo que se producen son significantes, palabras.

Para decir algo muy general de los cuatro discursos, podría hacerse de la siguiente manera: "El discurso del amo se dirige al dominio; el universitario, a la acumulación y el control del saber; el discurso de la histeria atenta contra todo poder, y el discurso del analista se ofrece a la producción del saber y el acceso a cierta verdad del deseo del sujeto" (Herrera, 2004, p. 93). Esto, de acuerdo con el orden planteado, como si el matema del discurso tuviese una sistematización, es decir, como si fuera una máquina y girara en dirección de las manecillas del reloj (dextrógiro); el camino iría del discurso del amo al de la histérica, luego al del analista y, por último, al universitario. De esta forma, cada función va ocupando un lugar diferente con cada movimiento. En la clínica, se habla de que, en el inicio de análisis, el paciente pueda estar en el discurso del amo, para luego ir al de la histérica planteando preguntas sobre aquello que lo determina, y para terminar en el del analista, que representaría el fin del análisis, porque implica la caída del analista como sujeto supuesto saber y también la caída del mandato de los ideales.

Si el discurso diera un giro a la izquierda (levógiro), desde el discurso del amo, se transcurriría del discurso del analista hacia el universitario, no habría allí un análisis, sino solo una transformación en la que el saber se sitúa en el lugar de amo que dirige al Otro como un objeto.

El hablar primero del discurso del Amo, asociando este hecho con la lectura sobre la filosofía Hegeliana que hiciera Lacan, tampoco escapa al fenómeno de que el análisis profundo de la subjetividad lleva a la conclusión de la necesidad que tiene el sujeto de Otro que lo domine, lo controle, le facilite la vida.

Históricamente, no es posible negar la esclavitud que ha vivido el ser humano en diversas modalidades. Que el nombre de esclavo no se haya usado siempre no quiere decir que haya modificado su servidumbre. Solo se han cambiado los nombres de acuerdo con los sistemas de gobierno, dando como resultado lo mismo: el sometimiento de muchos por algunos pocos que tienen el poder.

En algunas épocas ese poder fue arrebatado a la fuerza; en otras, es un poder otorgado por el mismo pueblo, es decir, por la clase esclavizada, como podría ser en los sistemas modernos de gobierno.

Esto lleva a pensar que la servidumbre pareciera ser algo natural al hombre, tal como lo explicara muchísimo antes La Boétie en su texto *La servidumbre voluntaria*, en el que expone varias razones por las que las personas se dejan dominar, como la costumbre, la educación, los beneficios que se obtienen, la idealización o sacralización de los amos y también por convertirse en uno de ellos.

Esta servidumbre parece en principio contradecirse con la naturaleza del hombre, por cuanto preferiría la libertad; el hecho social es que, al preferir la libertad, lo que consigue es la condena a muerte. Así, la servidumbre es, pues, una manera de defenderse ante la muerte, en el caso extremo, pues se encuentran dos vertientes de la naturaleza: la que impele a la libertad y la que quiere sobrevivir. "Lo que estatuye a un individuo en dominador o en siervo, lo que funda las condiciones de una dominación o de una esclavitud, es esta inclinación inversa hacia la muerte o hacia la vida" (Trias, 1981, p. 105).

Le sea natural o no al ser humano, cuando hablamos de sujeto, es incuestionable que el término ya lleva en sí mismo la condena a la dependen-

cia, a la sujeción, y que será con respecto al lenguaje, pues es como elemento del enunciado como se conoce su lugar, como aquel que efectúa una acción, pero que, si no tiene algo que efectuar, no tiene sentido que aparezca.

Una de las connotaciones que recibe la palabra francesa *sujet,* es como "súbdito", aunque también existe su definición como "tema" o "asunto". De ahí que, en su primera acepción, se marque un sometimiento a otro, pero en la segunda deje en claro que no es un individuo, persona o alguien encarnado, sino aquello que surge de lo que se habla.

Esto acerca forzosamente a la idea que sostiene Lacan sobre qué es un sujeto para él y que siempre verá como algo que se hallará "dividido entre dos: entre S1 y S2, o entre hablanteser y Otro, o entre dos escenas…" (Eidelsztein, 2008, p. 48). Es, pues, aquello de lo que se habla, aquello que se produce en el "entre dos" y que será un hablar sobre el deseo o el goce.

Se puede observar también esta relación de sometimiento entre el significante y el significado, por la cual este último dependerá del primero. El primero será quien lo determine o quien lo conmine a emerger. Sin el significante, no hay un significado, de ahí que hay una relación más que necesaria. Así, tampoco hay un sujeto sin ese "entre dos".

Incluso para el mismo Freud, esta relación de sometimiento entre amo y esclavo se menciona como establecida entre la pulsión de muerte y la de vida, puesto que, como dice en su último desarrollo, todas las pulsiones están ordenas ante la de muerte, para conseguir lo mismo, aunque sea por un camino distinto.

Se ve claramente entonces que en el discurso del amo el inconsciente como el S1 pone a trabajar a otros significantes S2 (saber), reprimiendo o dejando como supuesto a un sujeto en falta que no puede relacionarse con el objeto. Así entonces, en el discurso del amo el Significante Amo manda al Saber, sometiendo al Sujeto en falta. Es a través de la palabra o de este discurso, de este devenir entre el primer significante y el resto, como se muestra la sujeción, la imposibilidad de que el sujeto reconozca su deseo; solo se sabe en falta, más no la interpreta, pues solo está presente el deseo del que manda: "El deseo del amo, enseña Lacan, es el bienestar del esclavo. Un bienestar que, por supuesto, desatiende el deseo del sujeto" (Herrera, 2004, p. 93). El sujeto, pues, no solo está sometido al significante, sino al

Otro que ocupa una "posición maestra, como amo absoluto" (Lacan, 1960/1998, p. 786).

Ya que en cada uno de los discursos aparece el sujeto de manera distinta, se puede precisar que en el discurso del Amo aparece como aquello de lo que no se quiere hablar, mientras que cuando cambia el lugar, su sujeción también es distinta.

Lo claro es que, en esta relación de sometimiento, el sujeto no se presenta, está aplastado por el Amo, aunque tenga un lugar. "Es preciso que el vencido no perezca para que se convierta en esclavo" (Lacan, 1960/1998, p. 790), puesto que lo que le asegura su presencia es esta represión que padece por parte del significante, del Otro o de su Amo, porque aquello con lo que le queda impedido relacionarse es con el plus-de-gozar, con ese resto que deja el discurso y que pertenece al goce del Amo; "se trata de una articulación lógica en esta fórmula: 'el saber es el goce del Otro'" (Lacan, 1969b). Así, este sometimiento, al mismo tiempo, lo protege del exceso que le representa el Goce.

La única cercanía con ese goce es por medio de su límite o resto, que es el plus-de-gozar, que es ser hablado a través de lo que padece, de la queja, de lo que el Otro le hace, del goce del Otro, de lo que el Otro es capaz de disfrutar o hacer y que siempre se verá mejor. Es decir, la relación misma con el Amo le representa un extra de goce, pero no El Goce. Por eso, al hablar de plus-de-gozar, no se refiere a un ir más allá, puesto que "no hay pues aquí una transgresión, sino más bien irrupción, caída en el campo de algo que es del orden del goce, un 'superávit'" (Lacan, 1969b), pues en el discurso, en el "entre" de un significante y otro, además de producir un sujeto, aquello de lo que habla deja ese plus-de-gozar, que es el hablar del Goce, que ya lo anula un tanto pues, como todo significante, mata a la cosa, el goce del que se habla ya no es Goce, sino solo ese resto. Así, el sujeto puede ser hablado desde ese plus, que al mismo tiempo le deja impedido a gozar. "Dicho goce es reprimido porque no conviene que sea dicho, y ello justamente porque decirlo no puede ser más que esto: como goce, no conviene" (Lacan, 1973b), por eso se encuentra debajo del Saber.

Ahora bien, si se observa la parte inferior del discurso del Amo, se verán casi los mismos elementos de la fórmula del fantasma: el $ y el *a*. En el discurso del amo, el *a* es el plus-de-gozar; mientras que en el caso del fantasma,

lo que representa es el objeto del deseo. Aun cuando los signos sean los mismos, la función no lo es, y la diferencia esencial de esta relación entre el $ y el *a* es el signo intermedio, que es, en el primer caso, un pequeño triángulo Δ, y en el segundo es el velo o rombo ◊, formado por las relaciones matemáticas.[2] En el discurso del amo, lo que indica ese pequeño triángulo es la imposibilidad de la relación. Es decir, que el sujeto $ como verdad subyacente desconoce su deseo, pues es mandado por un amo, es hablado y deja como producto esa carencia difícil de alcanzar, esa pequeña muestra de goce. En el fantasma hay una relación, alienante, separada, velada, pero a fin de cuentas hay una relación con el *a*.

De ahí que en el discurso del analista surge esta relación, aunque en función distinta, porque es el analista, como causa del deseo, el que mueve a trabajar al sujeto en falta.

En el discurso del Amo, por tanto, el deseo del sujeto no tiene lugar, solo existe la ley del Amo o el mandato del Amo, que impide el gozar. Ya se sabe de la oposición insoluble entre deseo y ley, pero también se sabe que la ley organiza el desear, o es quien lo produce, es la ley del deseo. Pero en este discurso del Amo, la ley que se presenta es la del Goce, donde no hay sujeto, donde no hay deseo. Es una Ley que dice: "habla del Goce del Otro al que tú no tienes acceso, más que por la palabra".

Si el sujeto del discurso del Amo no tiene ahí un deseo, ¿Sólo le queda el acceso al goce, aunque sea como un resto? Si la Ley es la que se asocia a la castración y esta pone los límites al goce, no permitiendo el comercio sexual incestuoso o la reintegración del producto, dando como resultado el deseo, es por eso que, aunque sean opuestos la ley y el deseo, este último no existiría sin la ley. Así como el Amo no puede existir sin el esclavo, no lo sería si no hay sobre quien mandar. Esta es la ley del deseo. "La castración quiere decir que es preciso que el goce sea rechazado, para que pueda ser alcanzado en la escala invertida de la Ley del deseo" (Lacan 1960/1998, p. 807).

Lacan (1960/1998) dice que "es el placer el que aporta al goce sus límites, el placer como nexo de la vida" (p. 801), suponiendo que el goce es aquello más allá del placer, que ya no es satisfactorio, sino que está del lado del

[2] De conjunción (∧), disyunción (∨), mayor que (>) y menor que (<).

dolor o del sufrimiento. Así, tanto el placer como el deseo, como el plus-de-gozar, vienen a funcionar como una defensa ante el Goce.

Pulsión, deseo y plus-de-gozar

La relación entre las nociones de *pulsión*, *deseo* y *plus-de-gozar* podría entenderse de la siguiente manera: La pulsión es sin sujeto —gramatical—; es un movimiento, una deriva que necesita de otro, como el objeto, para su trayecto, que no se detendrá en él, sino hasta que vuelva a su fuente. Aunque eso no representa una cancelación o disminución, es solo una modificación, pues la pulsión tenderá a repetirse. Es sexual en tanto que los objetos a los que se refiere son parciales, lo que marca ahí la hiancia o el vacío por el que hace su recorrido la pulsión, pues es ese hueco o el agujero el que es pivote de la pulsión. El sujeto que aparece en la pulsión es también el que está en falta, pero en una falta pura, representada por ese agujero; y ya que está en el campo del otro, entonces ya hay un paso por el significante.

En la necesidad, solo hay una falta a satisfacer. En el hambre, el alimento llega y satisface; en la demanda, que surge de ahí, aparece el grito, como un llamado al exterior para recibir esa satisfacción. Por su parte, en la pulsión es ese grito que va dirigido al otro, al exterior; va en búsqueda, sin que eso signifique la satisfacción. En todo caso, el placer se encuentra en el trayecto, en el ir y venir, no en la cancelación. En la tensión misma está el placer pulsional, en la insatisfacción. Aún el otro no es un objeto total, solo es algo a lo que se hace una referencia, pero sin que sea necesaria su presencia. Ya que no hay un sujeto de la pulsión, solo es un movimiento hacia el exterior, sin un objeto, tal como parece en la fórmula ($ ◊ D).

Al introducirse la experiencia del espejo, donde se constituye el sujeto a través de la mirada del otro, se conforma al mismo tiempo el objeto, como un objeto completo, por lo que el sujeto deviene en falta, en ser incompleto, lo que da origen al deseo como un reflejo del deseo de la imagen especular; entonces, el deseo es el deseo del Otro. Es así como el sujeto queda interpretado, significado, alienado y, por ende, en falta. Cuando hablamos del espejo, no necesariamente es ese instrumento, puede leerse también como la mirada, esa mirada de quien ve algo hermoso, lo que para Freud es *his*

majesty the baby, que es visto por la madre como lo más hermoso (o no), y es esa forma de ser mirado en la que se construye el ideal del sujeto. No es lo que mira en el espejo, porque contradice su propia sensación de incompleto, de no poder tener control de las cosas a su alrededor, de partes de algo que después llamará cuerpo, pero que, al mirar en el reflejo del espejo o de la mirada del otro, pareciera que sí está completo el cuerpo y que es algo preciado, entonces quiere ser eso que el otro le dice que es o debería ser.

El objeto del deseo, entonces, será inalcanzable, para sostener al deseo, aunque aparezca completo. Pero ese objeto también es el de la pulsión, solo que esta le da un rodeo —encontrando ahí su placer, en el rodeo—, mientras que el deseo se queda a distancia, tratando de revivir la experiencia satisfactoria, con un objeto alucinado.

El goce, que está en lado opuesto a la pulsión, "se articula al sujeto, no como falta, sino como cuestión de ser. También opera como lugar" (Eidelsztein, 2008, p. 78); se refiere a ese lugar del *no-todo* de la castración, es decir, del efecto del significante, y entonces su lugar no es el del agujero pulsional, sino el de la parte faltante el falo.

Mientras tanto, el plus-de-gozar aparecerá en esa fantasía por la que el sujeto en falta se da cuenta de que el Otro también lo está, de que también carece de algo y de que ese algo que desea es el falo o el mismo sujeto puesto en ese lugar, pero que supone que ese Otro sí obtiene la satisfacción del deseo y el más allá, es decir, el gozar, el gozar puro y que no es más que el gozar del falo. Así, aparece como una prohibición al sujeto de nunca llegar o de que nunca logrará aquello que el Otro sí, pero que tiene que buscarlo. Eso es el imperativo superyoico del gozar. De ahí que, donde haya castración, habrá pérdida de goce. Al quedar imposibilitado a realizarlo, solo le queda la contemplación, el entendido de que el Otro sí, a través de él, diciendo "soy gozado", por el Otro. Sí hay quien goza, pero no es el sujeto quien lo hace, sino el Otro, y lo que recibe el sujeto es solo una pequeña parte, que es ese reconocimiento del goce del Otro, que se convertirá en el plus-de-gozar. "La interrogación sobre el deseo del Otro es el mecanismo fundamental de la identificación imaginaria" (Rabinovich, 2003, p. 27): i(*a*), donde recae el mayor peso en el plus-de-gozar, en ese objeto *a*.

Es el resto que queda del discurso, un efecto del devenir de los significantes, pero no como un significante, sino como una significación, como

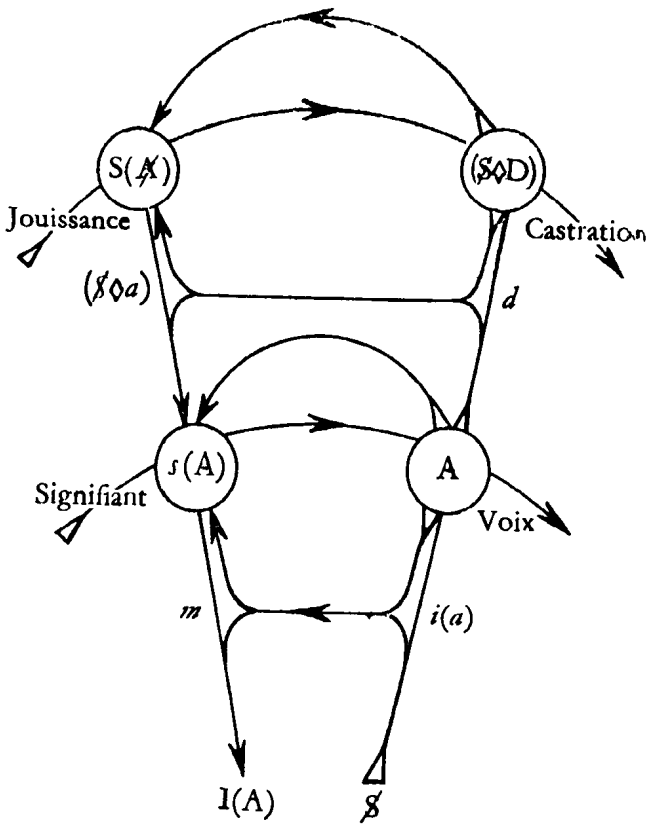
enunciación; eso es el plus-de-gozar, pues se puede hablar del goce, del goce del Otro, del sufrimiento, pero no mostrar tal cual ese sufrimiento. Es la ganancia que representa la pérdida o renuncia del goce. Es decir, la queja no es más que el uso de los significantes, y esto evita que se goce, porque, puesto en palabras, se deja el acto, y además ya le pertenece al Otro, toda vez que los significantes le pertenecen. Así, la queja impide el goce y solo es una ganancia, un resto o un superávit de ese goce. Dicha renuncia es, por tanto, lo que también divide al sujeto.

"Lacan redefine la herida narcisista como pérdida de goce, no como pérdida de autoestima" (Rabinovich, 2003, p. 71), ya que tal herida implica un desencuentro con la imagen especular, con el objeto. La herida que se enmarca en la distancia con el otro perfecto, que supone por tanto la castración, es una pérdida de goce.

Y ya que para el goce se requiere de un cuerpo, la queja hará referencia a ese cuerpo, pero teniendo en cuenta que el cuerpo no es más que el reservorio de los significantes; es, pues, el lugar del Otro. Solo se puede estar en el goce como objeto, de tal manera que el *a* es el símbolo del plus-de-gozar, de ese resto que queda entre los significantes, pero es también el objeto causa de deseo. Aunque en el fantasma también se pueda operar desde el $, y esto implica también la pérdida del goce a través del distanciamiento con el objeto *a*.

En el grafo del deseo, la pulsión aparece en el nivel más alto, con la fórmula ($ ◊ D), después de que el sujeto ha sido atravesado por el significante, es decir, de su ingreso a lo simbólico, por el cual se ha conformado el deseo (d) y se ha respondido desde el campo del Otro con el fantasma ($ ◊ α). De ahí se marca el trayecto de la pulsión a un nivel más arriba del simbólico —por tanto, en el real—, cuya respuesta en el Otro es el goce, dejando en castración al sujeto de la pulsión y del deseo. Así, se puede ver el enlazamiento de la pulsión con el deseo y su dirección tanto hacia lo real como hacia lo simbólico, pues también se dirige al nivel simbólico, en tanto que, al llegar al fantasma, se dirige al significante o síntoma s(A). De ahí que se entienda la frase de Lacan en el Seminario 23: "Las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir" (Eidelsztein, 2008, p. 248).

Figura 4. *Grafo del deseo*



Fuente: Lacan (1960/1998).

Comprendiendo este grafo al partirlo por la mitad, colocando del lado derecho las preguntas y del izquierdo las respuestas, la pulsión se conforma como una función de pregunta, de un increpar al Otro (por la transferencia); de ahí que se requiera ese campo del Otro para su trayecto, para bordear al objeto, pero para retornar y quedar en la pregunta que también es una cuestión del deseo. En ambos, como gramática, están ya dichos, están articulados. Desde el campo del Otro, la respuesta es el fantasma, es decir, el quedar enlazado en el deseo por la distancia con el objeto, surgido esto del Otro en el espejo, y también se responde con el Goce, que es, por consecuencia, Goce del Otro.

La introducción de la castración, de la falta, solo muestra el goce del Otro. Es decir, hay Otro que puede gozar, y que eso marca la castración del sujeto en falta, dejándole a su vez una relación distante con su objeto, que se repetirá en el discurso, al mismo tiempo que el discurso esconde ese plus-de-gozar, que es una reminiscencia, algo así como una herencia, lo que queda del goce del Otro.

5. Psicoanálisis y suicidio

Sólo esto ha quedado de mí,
estoy vacío,
ya no tengo nada que darle,
he estado junto a ella siempre
y ahora le exijo a la vida
que me deje vivir mi muerte.
Federico de Victoria

Freud

Resulta innegable que, para el Psicoanálisis, después de haber revisado lo que significa en otros saberes y disciplinas, la muerte es un tema de suma importancia que lo atraviesa de inicio a fin, como una de las marcas más importantes que posee el sujeto. Enlazándola a las nociones de instinto y pulsión, tanto Freud como Lacan no han podido dejar de abordarla. De ahí la relevancia de adentrarse en los conceptos de *instinto* y *pulsión*, señalando la diferencia, sobre todo en cada uno de los autores. Para indagar el asunto del suicidio como resultado del instinto o pulsión de muerte, hubo que estudiar la divergencia entre el deseo y la pulsión, sin olvidar que, al suicidio, como cualquier otro acontecer del sujeto, se le debe mirar caso por caso.

El Psicoanálisis, como cualquier otro saber, también está impregnado de los fenómenos de su época, y el suicidio, como ya se vio en el primer capítulo, no es algo ni antiguo ni de reciente aparición, de tal manera que hay pronunciamientos realizados por Freud y Lacan al respecto. Breves, pero existentes, sin embargo, pueden relacionarse con el resto de sus posturas teóricas para dar un esbozo de explicación de algunos suicidios, reiterando que la particularidad del caso remite a ese acotamiento de la explicación.

El padre del Psicoanálisis, en algunos momentos, ante los cuestionamientos sobre lo que sucedía en la vida cotidiana de su comunidad, tuvo que manifestar su opinión acerca del suicidio. En abril de 1910, intervino

en un debate de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, y el texto fue recopilado en sus obras completas como *Contribuciones para un debate sobre el suicidio*, texto muy breve donde señala el equívoco de culpar a la escuela como el factor motivador del suicidio en los jóvenes y el "deber" de llevarlos al querer vivir. En cuanto al suicidio en especial, lo que se atreve a preguntarse ante aquel auditorio es: "cómo es posible que llegue a superarse la pulsión de vivir, de intensidad tan extraordinaria, si solo puede acontecer con auxilio de la libido desengañada; o bien, existe una renuncia del Yo a su afirmación por motivos estrictamente yoicos" (Freud, 1910/1998, p. 232).

Este cuestionamiento deja sin respuesta, posponiéndolo para futuras investigaciones, el entendimiento del suicidio.

Lo cierto es que esta pregunta encierra varios asuntos:

1. Su noción de pulsión de vida como la fuerza más potente que mueve al sujeto (en oposición a lo que dijera al final en su *Más allá del principio del placer* y en *El malestar en la cultura*).
2. La idea de que en el suicidio lo que está en juego es la pulsión (opuesta a la de vida), en relación con la libido.
3. Si es el Yo quien ejecuta y es causa del suicidio.

Además, propone otra salida asociada con la melancolía y el duelo, con los afectos que se presentan en ambos estados anímicos o padecimientos. Esto implica que da una dirección hacia su texto publicado años más tarde bajo el nombre de *Duelo y melancolía*, para encontrar la respuesta.

La finalidad de *Duelo y melancolía* es marcar la diferencia entre ambos asuntos, siendo la más evidente que el duelo es una pérdida de objeto consciente, mientras que la melancolía supone también una pérdida, pero es inconsciente, porque no se sabe qué se perdió, aunque los asemeja en el trayecto o el trabajo, que en el duelo es al exterior y en la melancolía al interior. Otra de las diferencias esenciales es el debilitamiento y rebajamiento del Yo. "El cuadro de este delirio de insignificancia —predominantemente moral— se completa con el insomnio, la repulsa del alimento y un desfallecimiento, en extremo asombroso psicológicamente, de la pulsión que compele a todos los seres vivos a aferrarse a la vida" (Freud, 1917/1998, p. 244). Ese desagrado moral que menciona es reiterado o recordado a sí mismo por

esa instancia, que hasta entonces denominaba "conciencia moral", es decir, el Superyó.

Agrega que en lugar de callar y avergonzarse de su poca valía, la muestran como si, en lugar de hablar de sí mismos, hablaran de otro, lo que lleva a Freud a pensar en que se hizo una identificación con ese objeto de amor que se perdió en el exterior, de ahí su ya tan repetida frase: "La sombra del objeto cayó sobre el yo, quien, en lo sucesivo, pudo ser juzgado por una instancia particular como un objeto, como el objeto abandonado" (Freud, 1917/1998, p. 246); así es como el objeto del castigo y de los reproches superyoicos es el Yo, y la elección de objeto que se había realizado antes, hacia el exterior, descansaba sobre bases narcisistas, de tal manera que, al retirar la libido del objeto exterior, fue inmediatamente dirigida hacia el Yo, evitando así la hostilidad hacia el otro. Por tanto, habrá ambivalencia también en este vínculo con el Yo, es decir, el amor y la necesidad de sobrevivir y el odio trasladado a los autorreproches y castigo; en otras palabras, querer deshacerse de ese objeto que daña, pero también preservarlo, pues se le ama. Freud habla de la regresión al sadismo y comenta: "Solo este sadismo nos revela el enigma de la inclinación al suicidio por la cual la melancolía se vuelve tan interesante y… peligrosa" (Freud, 1917/1998, p. 249). De esta manera, bajo esta perspectiva, Freud argumenta que el suicidio no es más que matar a otro.

Esta afirmación contradice de alguna manera lo dicho sobre su elección narcisista, puesto que se ha elegido un objeto amoroso producto de la identificación, es decir, de la semejanza (o del beneficio propio); entonces, al querer matar a ese otro externo, no es más que a sí mismo al que finalmente desea matar.

Lo que queda claro del texto es que el conflicto del melancólico es entre el Yo y el Superyó o "instancia crítica", como le nombra; idea que ya había aparecido en su escrito temprano de 1901, donde habla de que "hay en permanente acecho una tendencia a la autopunición" (p. 176), mencionando además el lazo entre esta aún no identificada instancia y la pulsión de muerte, que tampoco es llamada así aún.

En ese escrito, Freud habla de los suicidios conscientes como un resultado directo de esta necesidad de autocastigo, como podría leerse en este texto del diario de Kurt Cobain (2006):

> Bajé andando a las vías del tren, me tumbé y esperé a que pasara el tren de las once, poniéndome un par de bloques de cemento encima del pecho y las piernas, y el tren se fue acercando… Y en vez de pasar por encima de mí siguió por la vía que había a mi lado. (p. 32)

¿No es esto un castigo superyoico? Tener toda la intención de morir, sufrir en el momento previo para tomar la decisión y, al final, cuando se cree conseguirlo, por un descuido de no revisar los detalles, es salvado, reiterando su inutilidad o su falta de eficacia.

Pero también Freud habla de otro tipo de suicidios, de los inconscientes o "tolerados inconscientemente"; o bien, los intentos inconscientes de suicidio, como aquellos en los que el sujeto no ha expresado su deseo de morir, pero cuyo comportamiento lo lleva a sufrir "accidentes" que, debido a sus historias precedentes, tal pareciera que son intencionados para autocastigarse.

Esto puede verse en esta historia de una joven adolescente de 19 años que llega a consulta por padecer de bulimia y cuya principal queja es el desamor que percibe en su madre hacia ella. No solo la bulimia se manifiesta, sino toda una serie de conductas de riesgo: fumar, beber alcohol y manejar en estado de ebriedad, manejar a alta velocidad su automóvil, tener relaciones sexuales a veces sin protección, estar en reuniones donde se "juega" a tener encuentros bisexuales. Como protección ante estas condiciones, está la presencia de algunas mujeres mucho mayores que ella, de las que siempre se encariña fuertemente, aunque no le atraigan sexualmente, mientras que los varones le atraen sexualmente, pero no logra enamorarse de ellos. En medio de esta confusión y bajo el resguardo de una de sus tías, se entera de que justo ella es su madre, no su tía, y de que la donó a su hermana para evitar problemas con su esposo, pues fue concebida fuera del matrimonio. Después de saber esta verdad, intenta encontrarse con esa madre, que era la tía amorosa, pero que, como madre, lo único que ahora sabe es que la abandonó. No puede con esto y regresa con su madre legal. Al pasar de los meses, sin haber resuelto del todo la relación con su tía-madre (quien aún sigue sin darle un lugar como hija, pues, aunque le haya dicho la verdad, no lo hará con su esposo) y su madre-tía (quien la acepta de regreso, pero sigue siendo fría como lo fue desde que lo recuerda), sufre un accidente

automovilístico al chocar con un tráiler mientras ella conducía para ir a la escuela al mismo tiempo que hablaba por su teléfono celular. ¿Es esto un accidente o un "suicidio inconsciente"?

Indica Freud también una característica de tales accidentes autopunitivos: "Destinada, por una parte, a expiar su fechoría, pero, por la otra, a evitar un castigo desconocido, quizá mucho mayor, ante el cual durante meses había tenido continua angustia" (Freud, 1901/1998, p. 181). Es decir, estos castigos, que podrían decirse superyoicos, son al mismo tiempo una defensa para un castigo mayor. El castigo más fuerte que se puede padecer es la aniquilación. Entonces, ¿el suicidio es un castigo superyoico o no?

Antes del suicidio, Silvia Plath, quien lo había intentado ya varias veces, había expresado en su poesía la tristeza que le embargaba, ese sinsentido que, a pesar de tener hijos, no le era compensado. Sin embargo, su intención de morir no era tan profunda, pues procuraba dejar instrucciones para ser salvada a tiempo, cosa que no sucedió en el último intento, en el que sí fue más bien un logro. ¿Se podría ver en esto el producto de un sadismo superyoico del que al final Silvia pudo liberarse tras la falta del auxilio oportuno de sus semejantes? O, como está descrito en la breve novela de Fernando Lobo (2007), en la que su personaje principal se ha dedicado a probar toda clase de formas de suicidarse, pero no lo consigue, sino hasta cuando es "merecedor" y lo hace de la manera menos planeada.

Como dice Pereña (2001):

> La melancolía conduce al suicidio, y así suele suceder cuando no se acompaña de la reclusión narcisista en la que el Yo se hace actor y escenario de esa interminable y aburrida representación sadomasoquista que Freud resume en la expresión "culpa sádica" o des-vergonzada. (p. 143)

Con esto subraya que la melancolía puede llevar al suicidio siempre y cuando ya no funcione el sadismo proferido por el Superyó, quien es el sádico interno. O bien, como se ha visto comúnmente, es en el estado contrario donde puede aparecer el suicidio: en la manía; como ese momento en el que no existen ya barreras para el acto, porque todo es *acting*, sin que medie síntoma, represión o palabras para detenerlo "Esa supuesta energía

libidinal que no se gasta en el proceso represivo, que no se traba en el lazo social ni se cifra en el inconsciente, es simple energía de muerte que se pierde como 'hemorragia' imparable" (Pereña, 2001, p. 134).

Más adelante precisaremos la diferencia entre acto, *acting out* y pasaje al acto, términos en los cuales se ha hecho mayor hincapié cuando se trata de algunos suicidios.

En otro momento, en una de las sesiones en Viena que presidía Freud, se abordó el tema, y lo que plantearon fue un enlace en el lenguaje con la conducta masturbatoria; para ellos, fue claro en cuanto al francés, sabiendo que el suicidio no es otra cosa que darse muerte por sí mismo. Usando la expresión de "levantar la mano contra uno mismo"[1] —*porter la main sur soi*—, que en el francés también se utiliza para hacer referencia al acto masturbatorio, les fue posible pensar que el suicidio podría leerse, desde esta metáfora, como un acto masturbatorio. Así, podría buscarse esta misma asociación en otras lenguas latinas, con la misma connotación, como las hay en el castellano, en el italiano y en el portugués. Otra de las afirmaciones consecuentes en esa sesión es que el suicidio no es otra cosa que el acto masturbatorio final (Société Psychanalytique de Vienne, 1978, p. 489).

La masturbación, por otra parte, cuando aparece en el sujeto —en la infancia—, tiene una liga directa con la fantasía del incesto, pues debe su origen a la relación amorosa con el objeto, que generalmente es la madre y que ha sido introyectado, conformando el Yo y deviniendo en autoerotismo, según Freud.

Siguiendo esta línea de ideas, la masturbación proviene de ese cumplimiento en la fantasía del incesto; a su vez, el suicidio se puede considerar como un acto masturbatorio. Es posible pensar que el suicidio resulta un cumplimiento de la fantasía de incesto, es decir, algo que pasa por encima de la prohibición contra el incesto y que, tanto en la masturbación como en el suicidio, se convierten en acto. Como ya se sabe, para el inconsciente no hay diferencia entre la fantasía y la realidad; o mejor dicho, entre la realidad alucinada y la que no lo es.

Revisando los conceptos que preceden estas ideas, el incesto pertenece a una de las prohibiciones ancestrales para el ser humano que ayudan a la

[1] Tal como se titula el libro de Jean Améry sobre el tema del suicidio.

sobrevivencia de la especie, siendo el incesto lo que ocasionaría el final del grupo social; es un peligro del que la moral del grupo advierte con sus leyes. Así, cometer incesto es faltar a la especie, a la humanidad, es un pecado social. Como se señala en las siguientes líneas:

> Existen dos tipos de castigos, uno automático por violaciones a la ley sagrada que tiene que ver directamente con afectar al tótem y el que se sigue de la violación a la prohibición del incesto, cuyo castigo proviene de la sociedad o del grupo. (Ortega, 2014, p. 24)

Freud, en su texto *Tótem y tabú*, explica, a través del mito de la horda primitiva, el surgimiento de estas leyes y sus consecuencias, además de la implicación que le trae al sujeto; es decir, la relevancia que tienen estas prohibiciones para la constitución del sujeto.

No hay que pasar por alto que en el texto mencionado se dice que los objetos o personas tabú son aquellas que faltaron a la ley y a quienes no se puede tocar, que se ha prohibido tener contacto físico con aquel que ya infringió la ley; lo mismo que sucede con el suicida o, por lo menos, podría verse una semejanza al desconocimiento que la Iglesia católica —entre otras— tiene hacia el suicida, dejándolo fuera del lugar al que van los que han sido perdonados de sus pecados, así como se les negaba la posibilidad de ser enterrados en lugar sagrado. El suicida podría parecer entonces un tabú, retomando las siguientes palabras:

> Aquel que se atrevió a dañar al padre queda marcado con el mismo tabú de no poder ser tocado, pues si se rompiera esto, provocaría un castigo al que entrara en contacto con él. Es como un contagio del tabú para el que lo ha roto, convirtiéndose él mismo en objeto tabú, representando un peligro para los demás. (Ortega, 2014, p. 28)

De esta manera, al hablar de la conformación del sujeto como tal, se han de asumir dichas prohibiciones, al mismo tiempo que se da lugar a las instancias psíquicas, teniendo al interior quien se encargue de recordar, de observar que se cumpla y de castigar el incumplimiento de la ley: el nombrado Superyó:

> Por más que Freud ubica una tendencia a la autopunición en las psiconeurosis, generalizándolo después en M*ás allá del principio del placer* y con sus desarrollos sobre la necesidad de castigo, esto no funciona como causa suficiente para el suicidio, ya que tendría que bastar con dicha tendencia para que tuviera lugar un suicidio. (Vargas, 2020, p. 63)

Efectivamente, si en todos habita el sentimiento de culpa, incluso el inconsciente sería suficiente y habría una cantidad mucho mayor de suicidios, quizás hasta sería ya tan normalizado que no escandalizaría a nadie.

¿Qué es entonces el incumplimiento de esta ley? Al cometer incesto, ¿contra quién se está faltando? Ya se decía anteriormente que es una falta social, pues está en riesgo la especie humana, pero además al interior del sujeto esa falta sería contra el Superyó.

Luego, no podría calificarse al suicidio como un castigo superyoico; por el contrario, sería una afrenta contra él. Conociendo la naturaleza del Superyó, que está invadido de pura pulsión de muerte y que es sádico, es entonces el principal interesado en que su objeto (desde Freud, es el Yo quien se pone de objeto para el Superyó) no desaparezca o sea aniquilado, pues quedaría insatisfecho. El Superyó no aniquila al objeto, sino que desea que permanezca ahí para seguir castigándole, otra razón por la que el suicidio o el aniquilamiento del objeto no es un asunto de castigo superyoico o comandado por él. "Sadismo que no implica la aniquilación, porque no tendría ya un objeto hacia quien dirigirse. Y que, por otra parte, recuerda la compulsión a la repetición de la pulsión" (Ortega, 2014, p. 99).

Esto que podría suceder cuando se comete una afrenta al Superyó es el resto de culpa —en cualquiera de sus dimensiones simbólica, imaginaria o real— o la creación de un síntoma y otras formaciones del inconsciente.

¿Qué castiga el Superyó? ¿Qué considera una afrenta? Sin duda alguna, cometer, la intención o el evitar cometer el incesto o el parricidio. "Por el tabú, todo sujeto será portador de un miedo sin causa que no es solamente miedo de lo prohibido, sino fundamentalmente miedo de encontrar la ocasión de realizar la transgresión" (Gerber, en Morales y Gerber, 1998, p. 36). También la evitación es castigada, puesto que supone el deseo o la intención, y ya se decía que para el inconsciente no hay dife-

rencia entre lo que se fantaseó y lo que se actúa. Naturalmente que sustituir el objeto incestuoso o parricida por otro que sea menos culposo no lo exime de la culpa.

De ahí que, si el suicidio fuera una suerte de cumplimiento de incesto, podría ser castigado por el Superyó; sin embargo, ante el hecho inminente de la muerte, el Superyó queda sin objeto. Es la paradoja. La culpa puede llevar al sujeto a buscar un castigo final, como el suicidio; sin embargo bajo esta relación con la masturbación, resultaría ser más un asunto de franquear la ley o al castigo superyoico que de someterse a él. Por lo tanto, podría ser un acto que pretende eludir la ley, tal como sería cometer incesto.

Virginia Woolf escribió a su esposo:

> Querido: Estoy segura de que me voy a volver loca de nuevo. Siento que ya no podemos atravesar otro de esos espantosos periodos. Y esta vez no me curaré. Empiezo a oír voces, ya no puedo concentrarme. Así que voy a hacer lo que creo que es mejor. Tú me has dado la mayor felicidad posible. Has sido para mí todo lo que una persona puede ser para otra… (en Vallejos, 2003, p. 130)

La voz de Virginia Woolf se plasma en esta carta para decir que ya no desea estar bajo la ley de la vida, bajo la ley de la "felicidad del matrimonio", y que tampoco desea seguir bajo ese castigo que le representa la locura, la depresión con los síntomas psicóticos.

En todo caso, el Superyó aparecería en todos aquellos intentos de suicidios fallidos; esos sí podrían leerse como actos provocados y calificados por dicha instancia. Así, en el suicida malogrado no sería la pulsión de vida la que triunfó, sino el sadismo superyoico que desea mantener a su objeto en pie para seguir castigándolo, incluso por su inutilidad de no poder autoaniquilarse. El Superyó, en todo caso, hace compromiso con el síntoma para su satisfacción sádica.

Por otra parte, las muertes que aparentemente son accidentales podrían ser explicadas desde esta óptica en la que el sujeto no pretende castigarse continuamente sino, por el contrario, pasar desapercibido por el castigador. ¿Podría ser, pues, un acto perverso? Incesto cometido, afrenta a la ley.

¿A qué se le llama incesto? Sería absurdo pensar que este término, que, aunque en sentido estricto habla del comercio sexual entre sujetos con lazos sanguíneos y de generaciones distintas, solo se refiere a eso. "Los deseos de muerte, la rivalidad fratricida, la adhesión pegajosa a las palabras del Otro, la idealización y degradación del goce de los otros […] son distintas formas de la presencia del incesto en la vida de los hombres" (Pereña, 2001, p. 97). Aunque Freud lo maneja casi todo el tiempo con algo de índole familiar, el incesto representa el deseo. La prohibición muestra el deseo. El deseo, que está del lado materno. ¿De qué se trata ese deseo? De reintegrar el producto o de quedárselo para siempre consigo, como esa promesa cumplida de que la madre portará el falo, aquello de lo que carece. Así, el suicidio sería ese intento de completarse, de tener el falo, de reintegrarse. De ahí que no suena extraño que, en algunos casos —si es que no en todos—, el suicidio esté precedido de la angustia, tal como es vivenciada en la fobia, o como podría decirse que sucede en el pasaje al acto. En ambos casos, evitando el objeto o el acto de peligro. "Lo cierto es que el Yo es la encrucijada de las angustias, la agencia de enlace y transmisión de lo que se juega entre su alteridad pulsional (denominada 'ello') y su alteridad legal (investida por el 'Superyó')…" (Assoun, 2003, p. 132).

Kurt Cobain (2006) escribió: "Soy varón, tengo 23 años y produzco leche… llevo meses sin masturbarme porque he perdido la imaginación… tocarme me da auténtico pavor. Estoy seriamente asustado para tocarme a mí mismo" (p. 137). Evidencia de la angustia que proviene de esa cercanía, del anuncio de la culpa por el deseo. La angustia, que no es de otra cosa sino de la castración, como Freud lo plantea en su adenda del texto *Inhibición, síntoma y angustia*. De nuevo aparece un concepto referente a la ley y al Superyó. La angustia de castración, angustia que disgusta, que es displacentera, pero que al mismo tiempo preserva o protege; ¿de qué?, de la muerte o aniquilación que representaría el violar la ley. Si no se hiciera caso de la angustia que avisa del deseo incestuoso —o parricida—, si la castración no valiera como suficiente advertencia para no cometer la falta —ya que la castración en el inconsciente es significada como la muerte, debido a la primacía del falo—, el sujeto sería presa del deseo de la madre y se convertiría en nada, quedaría desubjetivado. Ya se sabe que ese miedo a la muerte, tan propio del ser humano, no es más que una máscara que esconde el

miedo a la castración, un miedo que tal vez en el suicido se desvanece, que, aunque precedido de angustia, se deja de temer teniendo la certeza de que termina el sufrimiento o esa lejanía y espera ante el objeto amoroso.

Mishima lo ejemplifica en su suicidio tan planeado, justificado en la ceremonia samurái, que decide morir mostrando un acto de honor, dándole a su vida una última representación, como lo fuera siempre, por esa búsqueda de la belleza, de la perfección física, ese temor a envejecer, y lo dice a su maestro Kawabata, meses antes de suicidarse:

> De lo que tengo miedo no es de la muerte, sino de qué será del honor de mi familia después de mi muerte. Si alguna vez sucediera algo, supongo que el mundo lo aprovecharía para sacar sus dientes, marcar mis menores defectos y hacer trizas mi reputación […]. Seguramente usted es la única persona que puede preservarlos de esto, así pues se los entrego completamente para el futuro. (Kawabata y Mishima, 2005, p. 195)

Lacan

La angustia en Lacan conserva ese enlace con el deseo, pero también con la pulsión y con la relación con el Otro. La angustia no es por la nada, es por la presencia, una presencia mortífera del Otro, sin ninguna mediación; por eso se expresa como la "falta de la falta", porque no hay lejanía, no hay lugar para el deseo del sujeto y su carencia. Esa especie de completud que nadifica, pero al sujeto, que lo aniquila. Es "esa mirada de reconocimiento fijada sobre él por un Otro enigmático, a la vez desconocido e inexplicablemente familiar" (Assoun, 2003, p. 129). Mirada que reconoce al sujeto como objeto del deseo del Otro y que responde entonces a la pregunta que no debe ser contestada de "¿qué quiere el Otro de mí?", pues entonces se muestra el saber que posee el Otro sobre el sujeto; ya no hay falta ni incertidumbre, solo certeza. Como en el caso antes citado, de la joven adolescente, cuya certeza es que su madre no le dio lugar de hija para poder seguir con su matrimonio.

La angustia se vivirá por dos cosas: que el Otro pierda al sujeto o que no lo suelte. Es decir, tiene que ver con el deseo, como lo dijera Freud, pero con el deseo del Otro, con lo que el Otro desea del sujeto. Así es pues como "nace de la conciencia de la posibilidad de poder" (Assoun, 2003, p. 117), del poder que tiene ese Otro sobre el sujeto, sobre el goce, sobre la libertad, sobre el sujeto convertido en el objeto del deseo del Otro.

Ahora se verá de qué manera es la angustia y ese deseo del Otro lo que interviene en el suicidio, puesto que Lacan tampoco estuvo exento de hablar del tema, aunque no lo abordó en demasía, quizás para evitar las generalizaciones contrarias al caso por caso del Psicoanálisis. Así, en la entrevista que se le hiciera y se publicara después como *Radiofonía y televisión*, en la quinta parte dice: "El suicidio es el único acto que tiene éxito sin fracaso. Si nadie sabe nada de él, es porque procede del prejuicio de no saber nada" (Lacan, 1970b). No expresa otra cosa que esa completud, ese logro final, ese único "acto" que por tanto provoca angustia, eso único que es el cierre o la finalidad de aquel *instinto*[2] de muerte de Freud y que no queda en la apariencia, como el resto de los actos subjetivos destinados al fracaso, debido a la falta, debido a la amenaza de castración. En el suicidio es, pues, algo cumplido, esa desaparición de la barrera ante el goce; por tanto, no hay apariencia, sino evidencia, autenticidad. Un acto donde las palabras ya no tienen lugar:

> Van cuatro meses que estoy internada en el Pirovano.
>
> Hace cuatro meses intenté morir ingiriendo pastillas.
>
> Hace un mes, quise envenenarme con gas.
>
> Las palabras son más terribles de lo que me sospechaba. Mi necesidad de ternura es una larga caravana.
>
> En cuanto al escribir, sé que escribo bien y esto es todo. Pero no me sirve para que me quieran. (Pizarnik, 2005, p. 502)

En el Seminario 10, Lacan (1963) dice:

[2] Es así como lo nombra, no como pulsión de muerte, en el Seminario 19 "o peor" Clase, 1 del 4 de noviembre de 1971.

> Con respecto al objeto *a* , Freud expresa que entonces es preciso —dejo de lado por qué es así en este caso— que el sujeto se explique, pero que, como ese objeto *a* está habitualmente oculto detrás del i(*a*) del narcisismo, y el i(*a*) del narcisismo está allí para que en el cuarto nivel el *a* quede oculto, desconocido en su esencia, esto es lo que el melancólico necesita que pase, por así decir, a través de su propia imagen, y atacándola primero para poder alcanzar en ese objeto *a* que lo trasciende aquello cuyo mando se le escapa y cuya caída lo arrastrará en la precipitación, en el suicidio; ello, con ese automatismo, con ese mecanismo, con ese carácter necesario y fundamentalmente alienado con el cual saben ustedes que se realizan los suicidios de los melancólicos, y no en cualquier marco.

Para Lacan, entonces el asunto del suicidio en la melancolía, respetando la propuesta de Freud, tiene que ver con el narcisismo y mediante su fórmula o representación: i(*a*), explica que el objeto ha triunfado, que se ha quedado ahí instalado porque le pertenece al sujeto y, en lugar de quedarse a distancia o velado como en el fantasma, se lo apropia como a su imagen para terminar aniquilándose, una especie de i*a* sin paréntesis de por medio. "El objeto perdido es motor del deseo, y esa es la condición metafórica del sujeto" (Pereña, 2001, p. 134).

Es en la melancolía donde hay una falta de intervención de la palabra, un silencio discursivo donde ya no hay lugar para el seguir deseando… hablar:

> La melancolía representaría esa posición de no aceptación, de no consentir a la experiencia del lenguaje y al desplazamiento libidinal y del sentido, al deseo, a una sexualidad apalabrada pero no programada, de modo que por ese hueco del no consentimiento la vida puede perderse. (Pereña, 2001, p. 127)

Leclaire, acerca del narcisismo, dice que este se conforma en ese momento del espejo donde lo que se ve reflejado no es otra cosa que la representación del deseo materno, esa imagen perfecta, ese *infans* perfecto y querido por la madre (o por ambos padres) y que luego el sujeto tiene que abandonar o matar para dar paso a la falta, a la castración. Es por eso que la primera muerte es de esa imagen perfecta. Esa representación del deseo

materno que es el falo. Así, esta primera muerte deja la marca, como la lápida del muerto, del falo, de ese deseo materno. El suicida, para Leclaire, no logra conformarse con este duelo, padeciéndolo tanto que prefiere la aniquilación. "La lógica del suicidio deriva de un silogismo perfecto: para vivir debo matarme; pero no me siento vivir realmente (¡no es vida esta!), entonces me suicido" (Leclaire, 1999, p. 13).

Quizás es, pues, que no logra hacer esta separación del deseo materno y ofrece como respuesta, ante la pregunta de ¿*qué me quiere el Otro*?, mejor entendida como ¿para qué me quiere el Otro?, la desaparición, en una especie de sacrificio, como puede verse en lo escrito por la poeta argentina en su diario a un año de su suicidio:

> Hoy todos me han traicionado.
>
> El diálogo delirante con mi madre.
>
> Es un peso gravísimo, terrible, temible, que me hará perder la vida del modo más cruel. Ella sabe, ahora, del fracaso de toda su vida. ¿Cómo compensarla? ¿Cómo ayudarla? […] Esta es mi madre, la que hizo de mi infancia un laberinto de tristezas sin nombre. Y ella y yo estamos tan vencidas que desapareció la culpable así como la víctima. La quiero mucho, pero sobrellevar su vida (en mis hombros, que tanto me duelen) implica inmolarme. Y claro que me inmolo. Por supuesto que me doy en holocausto. ¿Y qué? (Pizarnik, 2005, p. 493)

Cuando Lacan plantea que el objeto —como causa de deseo— es el propiciador de la angustia, es justamente porque, si se consiguiera estar frente al objeto y tomarlo, se dejaría de ser deseante; por lo tanto, se conseguiría la completud. Sin duda, esto significa el aniquilamiento del sujeto, es decir, la muerte. "En las dos situaciones opuestas de estar intensamente enamorado y de querer suicidarse, el ego se encuentra abrumado por el objeto; pero en cada caso de un modo bien distinto" (Freud, en Álvarez, 1999, p. 164). Si el Yo se presenta como el objeto del suicida, es el cuerpo ese exterior del Yo que también tiene que aniquilarse. De ahí que, a pesar de la angustia que precede al acto suicida, cuando este se consuma, se desobedece la ley; es posible verlo entonces como un acto incestuoso, que escapa de la ley.

A diferencia del sueño, que Freud comentó que era un cumplimiento de deseo, le da lugar como formación del inconsciente, pero que, en lugar de aniquilar al sujeto, incluso le sirve para reparar su energía o para el campo en el que elabora sus afectos, no lo aniquila. Si el suicidio fuera un cumplimiento de deseo, ¿podría ser también una formación del inconsciente? Una formación del inconsciente que, sin embargo, se actúa, pues esa parte del suicidio que no se sujeta a la ley, que no se simboliza y que, por tanto, no puede tener la lógica, la censura y demás que tienen las formaciones del inconsciente, entonces se lleva al acto, pues se habla más de una satisfacción de deseo que de un cumplimiento —fantaseado— del deseo.

Por tanto, se encuentra al suicidio más como una transgresión de la ley, un deseo llevado hasta sus últimas consecuencias, sin ningún obstáculo, o sea, satisfaciéndose. Si para Lacan el deseo es de muerte, es ahí, en el suicidio, donde está su cumplimiento. De esto que se puede entender que el suicidio pasa por el deseo y todas sus implicaciones, incluyendo esta otra manera en que Lacan aborda el deseo a la luz de los discursos, en el del Amo. Ese Amo del discurso es también ese Otro que conlleva esa ley de castración, esa ley de muerte. ¿No es pues, en este discurso —en el extremo— donde se conduce por tanto a la muerte? "La muerte es el verdadero rostro de ese señor del mundo" (Trías, 1981, p. 107).

Desde esta mirada de Trías, en la que pareciera más se habla de personajes que de elementos discursivos, el suicidio podría leerse como una relación entre Amo y Esclavo, donde el sujeto está alienado al deseo o identificado con el del Amo —si es que puede decirse que el Amo desea—, que impele a gozar, mejor dicho, un acceso al "de más" del gozar.

Si el deseo es el deseo del Otro, desde ahí el sujeto está sometido, y si ese deseo está dirigido a la muerte o llevado al más allá, sin que funcione como defensa, ¿entonces se enmarca en el Goce? Pues solo puede gozar el Otro.

Si su deseo es el deseo del Otro, pero no está en el lugar del deseo del Otro, no es deseado, pareciera que sí está condenado al Goce. Aunque ya se sabe que es imposible no desear, eso marca la castración del Otro. Si se hablara de Otro completo, sin falta, sin deseo, donde no hay lugar para el sujeto en el deseo del Otro, naturalmente tampoco hay sujeto, porque no se requiere. Esta suposición de que el deseo es el deseo del Otro es también

porque el deseo se presenta como una sugestión, tal como la de la hipnosis, que proviene de Otro, de un Amo.

La única manera de romper esa fuerte dependencia con el Amo, hablando otra vez de personas, es marcar la diferencia, y marcar la diferencia es perder el deseo, por tanto, quedar a merced total del Goce, no ya en su plus, sino en el mismo, ahora sí, en la transgresión. Este movimiento solo puede hacerse de manera agresiva. "El crimen es principio separador en el seno mismo de la vida" (Trías, 1981, p. 34). Pero eliminar a quien encarna al Amo, por lo menos en lo social, no resuelve la servidumbre, muchísimo menos podría ser a nivel psíquico. Esto refuta que se mate al Otro en el acto suicida, como una solución, aunque no se podría saber si fue exitoso, si fuera ese el objetivo.

Es inevitable que el discurso del Amo suponga agresión, y ante la agresión solo se responde de dos maneras: con otra agresión o dejando de responder y no defenderse, como lo afirmara Hegel. El suicidio será un acto de separación más que un deseo de morir.

¿El suicidio puede ser responder con agresión al otro en uno mismo,[3] o bien, dejar de defenderse? Quizás el caso por caso daría mayor luz al respecto, puesto que algunos suicidios podrían pretender ese dejar de luchar, aunque el término de la vida siempre se viva como algo violento.

Tal parecería que en el discurso del Amo un suicidio no podría leerse pues, aunque hay ahí un significante amo que ordena a gozar, no le da lugar al sujeto para que tenga acceso al goce directamente, sino solo a ese resto que le permite al ser hablado, no pudiendo tampoco apropiarse de un deseo. Por lo menos no si se habla del acto suicida como acceso al Goce, lo que no es posible desde ninguno de los discursos.

Desde el deseo podría suceder, en cuanto a que en el del Amo queda totalmente ajeno a él y es ordenado por el significante, el rasgo unario, cuyo contenido es la muerte. Es hablado para morir, está marcado su destino, pero no llevado a desear o esperar algo. Habría, en este caso, un suicidio como devenir, donde no hay un sujeto deseante (¿psicosis?); mientras que

[3] Aunque el Yo es diferente del Otro, no hay una relación de igualdad o identidad; por tanto, al matar al Otro, no se mata al Yo, pero justo esa diferencia surgida en el estadio del espejo es el origen de la agresividad, pero la causa es la diferencia y no la igualdad.

si se ve la relación de amo y esclavo el suicido puede considerarse como la búsqueda de la liberación con tal de conservarse, pero que tal libertad solo se consigue a través de la muerte. Quien no sirve se muere. La vida, entonces, sería sostener esa servidumbre, "vida (y por ende amor) es algo que hunde a la autoconciencia en la servidumbre. La libertad se alcanza negando la vida" (Trías, 1981, p. 103).

Esto parece discurso schopenhaueriano o propio de Hume, o más cercano a Améry, quien dijera que la libertad plena sería poder elegir entre vivir o no, y que no fuera el vivir un deber.

El suicidio como transgresión

El acto masturbatorio final es el suicidio. Descompongamos esto en partes, primero vamos a entender a qué se refiere con "acto". Para ello, retomaré la explicación que hace Mirta Pipkin, quien toma para ello como ejemplo tres personajes de la literatura trágica: Hamlet, Ofelia y Antígona. ¿En común? Su relación con los ritos funerarios, con la muerte. A Hamlet lo coloca del lado del *acting out*; a Ofelia, del pasaje al acto; y a Antígona, del acto.

Para Pipkin, Hamlet es el responsable de todas las muertes de la historia, excepto la de su padre, pero, en la insistencia del espectro de su padre de ser vengado, Hamlet realiza una serie de desaciertos y termina por cumplir lo que le pide el padre, pero también muriendo. "No se trata de un suicidio o intención deliberada de morir, sino de un acto ausente de su responsabilidad subjetiva, por el cual realiza el deseo de muerte inconsciente" (Pipkin, 2023, p. 44). Encontramos en esta frase algo que puede ir dándonos luz sobre lo considerado como *acting out*, que en otras palabras podría ser una acción muy sin querer, no intencionada claramente o consciente, pero que cumple un deseo.

En la literatura más popular se conoce el *acting out*, para la Psicología, como ese mecanismo de defensa cuyo objetivo es dar un mensaje al otro. Desde esta perspectiva, son los suicidios que están dedicados al otro (¿habrá los que no?), ya sea que tengan una dedicatoria en carta o se sepa por quién se realizó. Pero está en el terreno de la actuación, con la connotación teatral

que esto puede suponer. "El *acting out* llama a la interpretación" (Vargas, 2020, p. 74). Está en el terreno de la mostración.

El caso del pasaje al acto se ha trabajado como un "salir de la escena", o sea, mientras el *acting* es estar en la escena, el pasaje se opone a ello. También se ha dicho que el sujeto no tiene control de su acción, que lo hace sin la menor reflexión ni idea de lo que pasa; eso, dicho por la psiquiatría. En el ejemplo de Ofelia, perdiendo toda esperanza, quedando como imposibilitada para ser amada, se suicida. "Ofelia, identificada al objeto que encarna el goce del Superyó, melancolizada, pasa al acto y abandona la escena" (Pipkin, 2023, p. 45). Digamos que no había opciones en su vida, habiendo sido objeto de amor, pasa a ser más que imposible, se inmola. No hay un llamado al Otro.

Para Antígona, Pipkin se plantea el acto. Es una realización, en tanto se conoce el fin y casi de manera voluntaria accede a él. Hay que recordar que Antígona decide desobedecer la ley de no dar sepultura a su hermano, por lo que es castigada con ser enterrada viva. Ella sigue la propia ley de dar sepultura a su hermano pese a que se lo prohibieran. Sabe las consecuencias y, aun así, hace lo que "debe", "quiere" y "tiene" que hacer; no lo hace desde un lugar de melancolización y desolación, sino de la certeza de hacer lo correcto. La muerte es una consecuencia.

"Lacan plantea que en el acto el significante parece estar muy próximo a significarse a sí mismo" (Vargas, 2020, p. 88). Es decir, como lo toma la filosofía, el acto es algo terminado; pocas cosas pueden considerarse actos, casi todo. De acuerdo con la filosofía, tendría el rasgo de ser potencia, algo que será o que es posible que lo sea. Un poco acercándose al concepto de *virtual*, que es algo, pero no del todo. Lacan entonces plantea que un acto no es aquello producido por un Sujeto, sino que el sujeto surge a partir de un acto. El sujeto que surge del acto es distinto, irreconocible por él mismo. También dirá que la palabra es el acto. También está presente el Otro. "El acto no *es* sin el deseo del Otro, lo que implica, igualmente, a un Otro del que no cabe esperar garantía por estar marcado por la castración" (Vargas, 2020, p. 102).

Vargas, en su texto "El suicidio como acto y sus paradojas", nos muestra a detalle y con un recorrido sobre las obras de Freud y Lacan esta noción de acto, considerándolo desde la vertiente del acto fallido. Esta formación

del inconsciente que nos hace decir o hacer una cosa que aparentemente no queríamos decir o hacer y se nombra, así como si fuese una falla; sin embargo, es una manera en que el inconsciente tramita algo que no puede ser muy transparente o directo, por lo cual, desde el inconsciente se considera logrado y no en falla. Esto nos muestra es que hay un corte, una marca, por eso se dice que hay un sujeto nuevo o producto del acto, hay una separación. Claro, aquí podemos entender cómo los suicidios pueden ser tan distintos unos de otros, comprender cómo es que unos se pueden prevenir y otros no. "El suicidio como acto implica no suicidarse por una 'bobería'", dice Lacan (Vargas, 2020, p. 134).

Regresando a la otra parte de la frase con que iniciamos este apartado sobre la masturbación, decimos pues que:

> El suicidio es el momento en que el cuerpo recobra de nuevo la importancia para el Yo, pues es la vía para terminar consigo mismo. O tal vez se pueda hablar de autoerotismo, de narcisismo; como sea, es el Yo y el cuerpo en una relación erótica: "La masturbación finaliza sin orgasmo". (Améry, 1999, p. 75)

Es el suicidio, ese encuentro con el cuerpo que en el transcurrir de la vida ha sido lo éxtimo, aquello que pertenece, pero que al mismo tiempo no, y que se ha construido por el Otro. Ese cuerpo que en inicio es la relación con la madre y que, al llegar el significante, los separa: "Un padre es el olvido del cuerpo" (Pereña, 2001, p. 95). El padre como función viene a separar al sujeto de su madre, es una separación de cuerpos; si el padre recordara al cuerpo, lo que se activa es la angustia, y entonces ha dejado su función; mientras que, por el lado contrario, "la madre es, de por sí, olvido del nombre" (Pereña, 2001, p. 95) y una huella del cuerpo, puesto que su origen no es otro que el incesto. Por eso todo sujeto habrá de pasar por un duelo, un duelo por esa pérdida de la madre, mientras que su insistencia sexual es "el olvido del olvido del cuerpo" (Pereña, 2001, p. 96), una especie de retorno forzosamente insatisfecho para que discurra el deseo y no se franquee la ley de prohibición del incesto.

De ahí que el suicidio sea contra el cuerpo, por dejarse vencer por la madre, por olvidar lo que es un padre, por no olvidar lo que es una madre;

por olvidar la Ley y no olvidar el deseo. El suicidio es contra el cuerpo, porque no se le puede olvidar ni buscar en el otro mediante un encuentro sexual.

La resistencia a la castración, a la Ley, a la prohibición o, como dice Pereña, la resistencia al trauma o a la experiencia misma de la palabra, que supone ese duelo por la cosa, hace que lo que retorna, no como formación del inconsciente, lo haga directamente en el cuerpo, sin palabra, sin experiencia, de manera inmediata.

Hans Mayer, mejor conocido como Jean Améry, cuando escribe su texto sobre el suicidio, discute sobre la idea freudiana de la pulsión empujando al sujeto a la muerte, suponiendo que toda pulsión lleva hacia algo, hacia el ser, no al vacío, pero afirma que tal vez el problema o la negación está en ese ser hacia el que empuja la pulsión. Por eso cambia la palabra *pulsión* por la de *inclinación*, porque esa conduce hacia abajo, hacia la tierra, hacia "la falta de lugar de la nada más nula" (Améry, 1999, p. 83); no es pues un retorno a un estado anterior para este autor, puesto que la pulsión de vida sí le parece que tiene mayor fuerza que cualquier otra.

Independientemente de su idea sobre las pulsiones, esto, para precisar, lleva a pensar que la sola pulsión de muerte, con toda su fuerza, aun y cuando las demás pulsiones están ordenadas a cumplir el mismo objetivo que la de muerte, no puede ser la causa del suicidio, en tanto que no todos lo eligen. Siendo la pulsión de muerte tan esencial al sujeto, no se puede hablar de una cantidad o de que algún sujeto tiene más pulsión de muerte que otro. Sí del Superyó más severo o no, sabiendo que el Superyó es la instancia impregnada de dicha pulsión.

Se puede sucumbir ante el Superyó y autocastigarse y maltratarse como en la melancolía más profunda, pero eso no garantiza la muerte. Probablemente solo en los intentos, esos que fallan, pues no hay que olvidar que el Superyó es sádico, angustiante y cruel, pero no mortífero. La angustia es la señal que previene.

Por supuesto que entre más cerca se esté de cumplir con esta encomienda del suicidio, más angustia se presentará, en tanto que supone esos avisos o señales de que se quiere transgredir la Ley, de que se quiere traspasar el lugar del "no-todo" al "todo".

Entonces, es Lacan quien ofrece otra explicación a partir de su noción de *deseo*. Del deseo del Otro, porque no se puede hablar de que el deseo sea

de alguien más. Y si el deseo del Otro es del falo, está enmarcado por la muerte. Así, posiblemente esta identificación del propio deseo del sujeto con el deseo del Otro lo lleva al suicidio. "Afirmación del deseo al negarse como viviente, de allí que hable de denegación" (Vargas, 2020, p. 120).

Este acoplamiento con el deseo del Otro, acoplamiento que recuerda a la relación prohibida, incestuosa, cuyo castigo es la muerte, no solo está amenazada por la amputación de un órgano, sino de la vida entera: es la transgresión de la Ley. "Tú, Otro, como elemento de la trama social, tenías razón frente a mí, independientemente de lo que me has hecho; sin embargo, mira: puedo sustraerme a la legalidad. Lo hago sin perjudicarte" (Améry, 1999, p. 120).

No se mata al Otro dentro del sujeto, se mata al Yo del sujeto. Como Freud dijera en el melancólico, por el que la elección objetal es de base narcisística, a quien se mata es al mismo Yo que representa a ese otro abandonador. Cierto que ese Yo se conformó por el otro, en todo caso se mata a todos, a todo. Tal vez por eso se dejan mensajes o el mismo suicidio es ya un mensaje dirigido a los demás. En realidad, al matarse el Yo, lo que queda es el Otro, el Otro completo, el Otro que ya no desea, pero ese Otro que es como el Amo, que sin su esclavo tampoco existirá. Así, no quedan ni el Sujeto ni el Otro.

¿El suicida deja de pertenecerle al Otro para pertenecerse a sí mismo o, al contrario, queriendo liberarse, cae finalmente en pertenecerle por completo al Otro? De ahí que se pueda distinguir cuando se habla de "morir por" a "morir de". Cuando es la primera situación, hay un ideal, hace referencia al acto, como por el honor de Mishima. Mientras que, en la segunda frase, interviene la "vergüenza", dice Pipkin, eso que pasa en los ataques de pánico, que se trata de ocultar el miedo a morir, y entonces no se quiere ser visto por el Otro, propio del pasaje al acto (Pipkin, 2023, p. 130).

Existen autores que afirman que el acto se comete ante no ser deseados, es decir, en no encontrarse en un lugar otorgado por el Otro, puesto que revela la falta de falta: "cuando no veo en el Otro nada que me revele algún indicio de su deseo, cuando ese deseo del Otro me deviene completamente extraño y, por lo tanto, no puedo saber qué objeto soy para él" (Gerber, p. 120). Es, pues, el otro extremo de sucumbir ante el deseo del Otro, que sería la reintegración, sin ningún intermediario, muchísimo menos el significante.

Es una suerte de regreso a ese gran Otro que produjo al sujeto y su falta; como lo dijera Paz (2003): "Aunque la muerte es la gran madre, no es ni sexo ni tumba, sino espacio ilimitado y vacío" (p. 81).

El punto inevitable es que cada suicidio será diferente, no solo en los detalles, sino que, sea consciente, voluntario o inconsciente, accidental, cada uno de estos actos representa algo que ya no se podrá saber qué es, pues es donde el significante en verdad ya no puede "parecer" que diga algo. "Por medio del escrito, el sujeto procura restituirse como sujeto del significante amenazado de desaparecer por el encuentro con lo real" (Gerber, p. 123), a pesar de las notas del suicida, que son un intento de hacerse entender finalmente en toda una vida (o el tiempo que tardará en tomar la decisión) en la que no sirvió del todo, ni para extender el deseo de vivir, de vivir así, y se instaló el de no ser más, logrando cumplirlo. Es, al final de cuentas, una afirmación de su existencia.

Puntualizando, en Freud, el suicidio es por la pulsión de muerte, un conflicto entre el Yo y el Superyó. El Yo, como objeto conformado por identificación narcisista, por lo que se mata al Yo para matar al otro, pero si la elección de ese objeto es también narcisista, finalmente al que se mata es al Yo mismo. Por otra parte, no hay que olvidar que el Superyó es sádico; o bien, que la culpa que hay en el melancólico y que presume como si estuviera más bien culpando al otro es de naturaleza sádica, por lo que es una culpa que insiste, así como el Superyó, quien está movido por la pulsión de muerte. Es pues una pulsión en el Superyó o en esa culpa, que no quiere ser cancelada.

Freud, además, hace una distinción entre suicidios conscientes o los tolerados inconscientemente y, junto con sus colegas de la época, hablará del suicidio como un acto de masturbación final, lo que más bien lo enlazará al incesto.

Como lo dijera Lacan, la inclinación a la muerte es más bien instintiva, por cuanto es un saber inconsciente para todos, pero que la pulsión sea de muerte es porque es sexual, y eso la hace parcial, escindida y atravesada por el significante. Pero para dar paso a esta parcialidad, es necesario el deseo, deseo mostrado por la Ley de prohibición del incesto y parricidio; en otras palabras, deseo mostrado por la amenaza de la castración. Es decir, el deseo en sí mismo tiene un componente mortífero, puesto que debe estar bajo

amenaza de no cumplirse, para que pueda aparecer ahí un sujeto, aun cuando esa amenaza también represente la muerte.

Es por eso que el sujeto está en el "entre" de la Ley y del deseo, o —del deseo y de la ley— del S1 y el S2, pues el deseo se manifiesta en la falla del discurso. El deseo tiene que decirse, apalabrarse, pero no completamente, para que insista en querer seguir diciéndose.

El incesto es, entonces, sucumbir ante el deseo cumplido, es lo dicho sin palabras, ese espacio del puro cuerpo y donde la angustia aparece sin hacer señal para evitar nada. Ya sabemos que para Lacan la angustia es por la falta de falta, por lo tanto, el suicidio será el único "acto exitoso".

Según Leclaire, el suicida no se sobrepuso a ese primer asesinato, de no ser el falo, de no ser el objeto de la madre, de no estar en el deseo de la madre; es decir, se quedó instalado como falo, y el falo no es otra cosa que un significante vacío o mortífero.

De ahí que el suicida lo que responde ante "¿qué me quiere el Otro?" es la inmolación, la desaparición, y cae abrumado por el objeto *a*, o, mejor dicho, convirtiéndose en objeto total para el otro.

Con el Amo está asegurado su plus-de-gozar, insuficiente para el suicida, que decide dejar de servir. Al dejar de servir, no puede ser sino el Amo, diría Trías, por ende, tener acceso al gozar, a morir. El suicidio es un acto violento ante el Amo: ante agresión, se responde con agresión, con una agresión que permite dejar de defenderse; o bien, un último vencimiento que separa del Amo.

Es por ello un acto exitoso de afrenta al Amo que va dirigido al cuerpo, sin poder olvidarlo. Es decir, sin intervención del olvido del cuerpo, propio de la función paterna.

En el suicidio, esa pulsión encrucijada con el deseo se desarticula, queda la sola pulsión sin el significante. No es que haya más pulsión, es que no hay deseo, no hay palabra, no hay metáfora sustitutiva. Lo que queda es un algo que ni falta tiene, por tanto, no están ahí ni lo sexual, parcial ni mortal de la pulsión.

Cuando hay palabra, cuando hay un mensaje en el suicida, se puede hablar entonces de que es dirigido al Otro. Dependerá, en el caso, por caso de qué se quiera decir con ello. Así, en el marco aún discursivo, puede leerse como el cumplimiento del deseo del Otro, cuyo deseo está orientado

hacia la muerte como un discurso ¿psicótico?; o bien, en el mostrar que se tiene el control, que se está de lado de la Ley, sometiéndose a la castración o efectuándola por él mismo, como el discurso perverso. En ambos casos, es una transgresión.

Transgresión de la ley, en sus dos formas de leerse: como ese pasar por encima de la ley que impide el cumplimiento del deseo, pero también como esa ley que se impone al sujeto, que transgrede al sujeto, esa ley de muerte.

Para el Psicoanálisis, puede ser el suicidio un mensaje, a los otros, al Otro, pero un mensaje que ya no tiene palabras, un mensaje que dice ya no querer decir, rechazar el plus-de-gozar. No decir ya nada al Otro es quedarse atrapado en él. Ir en los dos extremos de dejarse avasallar por el objeto causa del deseo, es decir, cumplir el deseo, pero también estar en el lado de someterse absolutamente ante esa Ley, ese Amo que prohíbe, que aniquila.

Pero puede existir un tercer caso en el que no hay mensaje, es mero acto. Un acto puro, no para otro, un acto de pudor. Es esto distinto al discurso, es un acto ya sin palabra, una transgresión al discurso, a la subjetividad.

Si se dijera que el suicidio es pulsional, en la noción lacaniana, porque toda pulsión es de muerte o sexual, pura pulsión en donde la palabra no ha podido poner límite —es decir, la castración no ha podido aparecer o ser más efectiva—, es llevado el deseo no ya a su cumplimiento, sino a su realización —pues el cumplimiento supone falla y puede estar por alucinación o fantasía—; entonces hablamos de una trasgresión a la ley.

Por el contrario, si se dijera que es un efecto de castración, por cuanto representa una separación total con el Otro, no es ya como amenaza que mantiene en vilo, sino como la ejecución. Siguiendo el mandamiento del "no desearás…", es porque no hay un ser deseado, como tampoco, por consecuencia, manera de desear, porque la única manera de no desear es estar muerto; tampoco se puede matar al otro (mucho menos al padre) si se está muerto. Un cumplimiento a la letra de la Ley. Ésta es la transgresión de la Ley, en el sentido también de que es una transgresión efectuada por la Ley.

¿Cumplimiento de Ley o transgresión de la Ley? ¿Efecto del nombre del padre o del deseo de la madre? Estar del lado del deseo o del lado de la Ley es un suicidio, dejarse avasallar por el objeto, o que se efectúe la castración, pues, como se decía antes, el sujeto debe permanecer en el medio para que

exista, porque los extremos suponen su desvanecimiento total. Siendo un acto, no es ya un discurso que se pueda enmarcar como psicótico o perverso.

El suicidio es, entonces, una transgresión en realización del deseo o en el de la Ley, es una transgresión de la subjetividad, una transgresión al discurso, porque es descolocarse de ese "entre dos" entre el deseo y la Ley. Ni se cumple el deseo absoluto del otro ni se deja eliminar por la castración, solo se desaparece del discurso, es un dejar de ser hablado.

Este ya no hablar, ya no decir, es porque no hay Otro, ni otros, que le escuchen o sean garantía de que su palabra tiene sentido; se pierde ese rombo de la fórmula del fantasma por la que el sujeto se relaciona con el otro. Por eso no es tan extraño que algunos de los suicidas antes han sido adictos (a-dicto: contrario al decir o a lo dicho) a alguna sustancia, como si esto los estuviera preparando para su último rechazo del no-decir, para ese *fading* del *fading*, donde el sujeto ya no está en falta, sino desaparecido.

6. ¿Cuál es la tarea del Psicoanálisis frente al suicidio?

Han venido
a incendiar la edad del sueño.
Un adiós es tu vida.
Pero tú te abrazas
como la serpiente loca de movimiento
que solo se halla a sí misma
porque no hay nadie.
Alejandra Pizarnik

Ya hemos visto algunas cuestiones que la teoría psicoanalítica aborda sobre el suicidio, también antes hemos visto propuestas de prevención y tratamiento de ideación suicida.

De acuerdo con los datos de algunas investigaciones, lo que funciona para prevención del suicidio es la terapia cognitivo conductual con sus derivados actuales. Seguramente habrá algunas otras escuelas psicológicas que plantean formas de intervención y/o prevención; de momento, con lo que he me encontrado con mayor frecuencia es lo mencionado en este texto. ¿Entonces dónde queda el Psicoanálisis en todo esto? ¿Es solo una propuesta de explicación del suicidio o tiene algo más qué aportar? También habrá muchas explicaciones psicoanalíticas, de acuerdo con las escuelas existentes.

Para ello, será importante regresar un poco a pensar en lo que sí es prevenible y lo que no lo es, como también en la noción de *síntoma* o de *patología*; es decir, lo que se aborda en la clínica. Sobre todo, pensando que la teoría psicoanalítica no tendría sentido sin la clínica, aunque no sea lo único de lo que puede hablar la teoría psicoanalítica.

Entonces, consideremos alguna manifestación de malestar que hay en una persona. Desde la Psiquiatría y, por tanto, desde la Psicología científica (aunque para algunos sea pseudociencia), podríamos pensar la patología, ese malestar "clínicamente significativo", como aquello que afecta a la persona y que altera o trastoca su bienestar, o un estado anterior satisfactorio. La Psiquiatría dirá que ese malestar debe estar presente en la mayor parte de las áreas de la persona y la mayor parte del tiempo. Dependerá del cuadro

sintomático para también considerar esos tiempos que lo hacen llamarse de una u otra manera. Es decir, la persona debe tener molestias en su ámbito emocional, familiar, social, laboral, académico —si es el caso—, físico (es posible), etc. Tendría que haber una especie de incomodidad entre lo que se quiere y lo que se tiene, o entre lo que se cree de sí mismo y lo que refleja ante los demás; una incapacidad para poder ajustarse a lo requerido o esperado por los demás. Hay algo que reconoce la persona como que no está bien en casi todo lo que compete a su vida.

Habrá ante esto algunas excepciones, como lo son tres trastornos: ludopatía (juego patológico), pedofilia y personalidad antisocial, puesto que en ellos puede no existir este reconocimiento de que algo está mal en ellos o este malestar "clínicamente significativo".

Para todo lo demás, hay nombre de trastorno, que, proveniente de una tradición médica, trata entonces con cuadros sintomáticos y signos patológicos. En las disciplinas "psi", los signos son aquellas evidencias de la existencia del trastorno que pudieran ser observables o medibles. Para ello, habrá algunos instrumentos, como pruebas psicométricas preferentemente. El asunto de los síntomas, que se entiende como la mirada subjetiva del que padece el trastorno o la queja del paciente, responderá a un listado que se puede cotejar con los manuales de diagnóstico, como se hace cuando se trata de una enfermedad física.

Desde este abordaje, entonces, se ve a los síntomas como aquello que hay que ir quitando para que la persona vuelva a sentirse cómoda y se ajuste a lo esperado por los demás, por lo que la mayoría hace, siente o piensa. ¿Por qué la mayoría? Porque esta mirada de cuadros sintomáticos ha surgido de investigaciones, principalmente en centros clínicos y psiquiátricos, de las patologías, y de ahí se ha recurrido a la estadística para poder definir qué es lo normal, o sea, lo que la mayoría hace en su grupo cultural, y por ello es lo esperado; así, eso tendrá que ser a lo que aspire toda persona que desee tener "salud mental".

La ideación suicida es un síntoma de algunos trastornos, o sea, no existe como tal el trastorno de conducta suicida, es más bien un elemento que aparecerá o no en algunos cuadros sintomáticos pertenecientes a determinados trastornos. También, cabe decir que el DSM agrega un apartado a la mayoría de los trastornos para decir si tienen o no riesgo de suicidio.

Como tal, la pretensión de la Psiquiatría y las psicologías clínicas, como hacen con todos los síntomas, será tratar de aminorar o eliminar; en tanto, el síntoma de la ideación suicida tiene que ver, como se indica en el nombre, con un asunto del pensamiento Es desde ahí como se puede manejar. Claro está que, como lo vimos con la propuesta de las terapias cognitivo conductuales, los pensamientos no están solos, van acompañados de emociones y sentimientos, así como de respuestas conductuales, pensando esta triada como un sistema en el que se puede trabajar con uno de esos aspectos y se modificarán los otros dos. Parece sencillo el abordaje.

Sin embargo, la ideación suicida es un síntoma, no el problema principal; es una manifestación evidentemente grave o que produce mucho miedo, mas no es la causa en sí misma. Justo una de las problemáticas con el DSM-5 fue que se intentó agregar un eje axial sobre la etiología de los trastornos, situación que no consiguió llegar a un acuerdo; puesto que el DSM en principio supone ser ateórico y agregar etiología representó una gran complicación, tratándose de cuestiones psíquicas, desde el tema de definir si es psíquico, mental, emocional, de qué es de lo que se habla en la psiquiatría o psicopatología descriptiva. Buscar las causas de un trastorno suele ser más sencillo cuando se hace referencia a lo que se puede observar y manejar, a lo neurológico, fisiológico, físico, pero el ámbito de las emociones (sin pensarlas como producto solamente de neurotransmisores, hormonas o algún otro elemento físico), de los pensamientos, de los sentimientos, de las actitudes, es una labor compleja, lo que ha provocado que se elaboren teorías para poder explicarlo. Aun así, se les puede ver como solo síntomas que habrá que trabajar para disminuir o eliminar.

¿Esa mirada puede funcionar? Por supuesto que sí, pero no en todos los casos. Porque si así fuera, ya habría disminuido el índice de suicidios en el mundo. Quizás algunos programas resultan más exitosos que otros, tal vez por la cultura de los grupos con los que se trata. Ya vimos en capítulo anterior, sobre la noción de la muerte y del propio suicidio, que el concepto ha ido cambiando, así también depende de cada cultura lo que considere alarmante o no sobre el suicidio. Podríamos entonces pensar que los suicidios prevenibles por estas vías son los que llamaríamos *acting out.* Sin embargo, no es por el nombre precisamente, sino por las formas en que se va dando salida a la ideación suicida.

El tema central al que quiero llegar en este apartado es que el Psicoanálisis, desde su clínica, tiene una forma distinta de ver al síntoma. El síntoma no es lo relevante o esencial, no es algo a disminuir o eliminar, es una manifestación, incluso es considerado una defensa que echa a andar el sujeto para mantener de alguna manera su equilibrio psíquico, su estabilidad, aunque le sea incómodo. De ahí que el psicoanalista o el clínico con orientación psicoanalítica no se enfoca en el trabajo alrededor del síntoma, a veces incluso deja de hablar del síntoma.

Pongamos un ejemplo. Si el síntoma tiene que ver con un trastorno alimenticio, en el que hay la provocación del vómito, si nos centramos en el síntoma, haremos un conteo de las veces que en el día o la semana o cada vez que se provoca el vómito, ante qué circunstancias después de qué. Luego pensaremos en el progreso terapéutico, en la medida en que ello fue disminuyendo. Pero ¿será eso suficiente? Quizás sí. Pero si la persona tuvo esa conducta que es propiciada por una distorsión de su imagen corporal, ¿dejar de vomitar le regresará la percepción adecuada, si es que la hay?

Pensar que la ideación suicida proviene de una depresión y ver la depresión como algo que hay que trabajar es seguir con el enfoque en el síntoma por el síntoma entonces, se puede medicar para disminuir o equilibrar emociones a nivel de neurotransmisores, pero la depresión no es nada más eso. Incluso puede haber en el paciente una sensación de bienestar, sin embargo, los pensamientos que estaban causando el malestar no desaparecen, las ideas que subyacen a la tristeza pueden continuar. La persona no desea morir porque está triste o deprimida, desea vivir de otra manera, sin lo que ocasiona su tristeza. Puede relacionarse el suicidio con el trastorno depresivo, pero la sola depresión no causa un suicidio; en cambio, sí lo ocasionan los rompimientos de pareja, el desaliento ante una falta de trabajo, de salud, de futuro, de vivienda, de familia que sostenga, etc. Sabemos que es multicausal, que es más bien complejo lo que está detrás de cada suicidio.

¿Tal vez, será mejor trabajar con encontrar las causas o en qué le beneficia presentar esos síntomas, de qué se está defendiendo? Quizás si la persona rechaza el alimento, tenga que ver con lo que le significa ese alimento o la introducción de algo ajeno a su persona.

En la novela *La vegetariana*, escrita por Han Kang, el personaje llamado Yeonghye es diagnosticada como anoréxica nerviosa por no querer comer nada, pero ¿realmente no quería comer?, ¿eso era lo central? Cuando vemos su historia, en la que comienza a dejar la carne por unos sueños, no tiene absolutamente nada que ver con el síntoma principal de la anorexia, que es la distorsión de la imagen corporal, en la que la persona se ve más gorda de lo que pudiera estar; en realidad, las anoréxicas no tienen sobrepeso, por el contrario, es otro indicador del trastorno el hecho de que tengan bajo peso del esperado por su estatura. Entonces, pensar solo en el síntoma y creer que este personaje tiene anorexia es la cosa más absurda, pues su idea delirante apuntaba a otra dirección, que leemos cuando le dice a la hermana que le lleva comida: "Ya no necesito comer", y le reitera: "Tengo que empaparme de agua. No necesito comida, Inhye. Solo necesito agua" (2025, p. 137). Podemos ver en esa novela cómo la protagonista es incomprendida, no solo por la familia, sino también por el sistema psiquiátrico.

¿Podríamos pensar esto de todas las anorexias o las esquizofrenias, etc.? No, cada persona tiene su muy propia forma de sufrir o hacer síntoma. Si observamos la manera en que Lacan plantea dónde está colocado el síntoma en la figura del nudo borromeo, lo vemos en el centro, anudando los tres registros (simbólico, imaginario y real); es por ello que en su Seminario 23, titulado *Le sinthome*, habla del síntoma como aquello que enlaza los registros, que le da una especie de sentido y que no podríamos tratar de quitarlo de ese lugar porque desataría la estructura del sujeto, es decir, tiene una función.

Pensarlo como un mecanismo de defensa nos lleva a buscar cuál es el peligro que se vislumbra, sobre todo desde el inconsciente y por qué es que está esa —en este caso— ideación suicida.

Actualmente se ve cómo desde la Medicina se ha intensificado la creación de analgésicos, de atenuantes de síntomas, y en Psicología pasa igual, hemos buscado la atenuación, más en temas de ideación suicida, que puede incomodar escuchar a quien sea hablando de la muerte, de la propia muerte.

De pronto lo que se provoca es el aislamiento, que ya no se hable, pero justo lo que pretende el Psicoanálisis, en su clínica, es el uso de la palabra. Aunque no en cualquier contexto, sino en el del dispositivo analítico, en el que hay un otro que está escuchando, desde el lugar de sujeto supuesto

saber. Lo que se busca es que haya el tránsito de la palabra para dar cuenta del deseo, que no es propio, pero también dentro de lo que llamamos transferencia, es decir, en la relación con un otro que le escucha:

> En otras palabras, ante la soledad propia del ser humano, llevarlo a encontrarse con el otro, con el semejante, con quien le pueda retroalimentar y que, a pesar de no poseer un sentido social o no tener otra certeza más que la muerte, se resuelva la existencia a partir de posibilidades, no de seguridades, de opciones de creación. (Ortega y Pedroza, 2013, p. 1874)

De poder confirmar el lugar que tiene en el mundo.

Lo que hace el Psicoanálisis no es otorgarle sentido de vida o darle ideas de por qué debería vivir, pues resulta eso como una imposición, no hay una interpretación que provenga del analista, sino que la elabora el analizante, como se le llama al que va a proceso de análisis, pues tiene una función activa (volviendo al asunto de la acción); ni tampoco es negar las palabras que se producen en el proceso, sería "más o menos lo que hace un curador de arte, que no instala un nuevo cuadro, sino que acomoda los que ya existen de manera distinta" (Ortega y Pedroza, 2013, p. 1876), como en el bucle donde no es solo cerrar la experiencia, como dice la Gestalt, sino regresar para partir de ahí a otro lado.

En algún momento relacioné el tema de la ideación suicida con el mecanismo de defensa de la negación, siguiendo la frase de "no quiero vivir", desde la propuesta de Freud, en el texto dedicado a dicho mecanismo. La idea que de ahí desprendí fue que esta frase, pronunciada en el consultorio, sea como afirmación con desánimo y desesperanza, como queja después de hablar de muchas dificultades, o como propiciando el inicio de un análisis,

> nos evidencia lo contrario: si se quiere vivir, pero no de la forma en la que se vive o no para lo que se cree que se le deseó vivir, hay un Otro siempre presente en ese enunciado, porque la palabra siempre está transitando en la interlocución, pero, no solo por eso, sino porque indudablemente tiene alguna dedicatoria. (Ortega, Pérez y Nieves, 2025, p. 11)

Si retomamos el discurso del Amo, podemos comprender que cuando en la clínica, en la atención de personas con ideación suicida, le decimos lo que tiene que hacer, incluso con la buena intención de poderle ayudar a que tenga un sentido de vida, ¿será que podemos hacerlo sin tratar de imponer uno nuestro o lo que consideramos como adecuado o lo que debiera ser? Quizás no siempre se puede encontrar un "sentido", un "para qué vivir", pero eso es cosa de la persona en situación. El asunto está en cómo nos posicionamos como clínicos, si nos quedamos en el discurso del analista, en la escucha respetuosa del decir del otro o transitamos sin pensarlo al discurso del Amo, mostrándole lo que está bien para el paciente.

Vargas lo dice así: "La lectura del acto implica que el analista no se sume al silencio del suicida, no para obturar con respuestas generalizadas, sino para demarcar la lógica que implica dicho fenómeno en el caso por caso" (2020, p. 170). Suponer que nuestra obligación ética es dar prioridad a la vida es enmarcarnos en la disciplina médica sobre la salud, pero también en una "moral" cientificista, cuando de lo que se encarga el Psicoanálisis es de la escucha del deseo y del goce, ahí no hay una moral o convencionalismos.

Continuando un poco con lo que menciona Vargas, quien atinadamente dice que, como en el Psicoanálisis y la mayoría de las disciplinas "psi", se sabe del caso *a posteriori*, nunca de forma anticipada, no podemos saber si alguien con ideación suicida en verdad lo va a llevar a cabo; así, tampoco sabemos si hará un *acting out*, un pasaje al acto o un acto. "Cómo hablar de una anticipación, una práctica de la prevención, sin ponernos en el lugar de un Otro omnisapiente de la garantía, excluyendo la dimensión necesariamente azarosa del análisis" (2020, p. 171). Quiere decir que utilizar estrategias de prevención como dar la información de los riesgos, los mitos y lo que hay que hacer cuando se tiene ideación suicida es posicionarse desde ese lugar de gran Otro, cuando el analista también está en riesgo, porque cualquiera puede estarlo y no es la experiencia la que te coloca en un lugar de saber, sino solo de supuesto saber.

Reconocemos que, aun cuando a veces se nos ocurre decir al paciente que toda decisión importante que desee tomar mientras está en tratamiento la postergue hasta hablarla, como lo sugería Freud en *Recordar, repetir y elaborar*, sabemos que existe la libertad del paciente, y no estamos con él

todo el día a toda hora, así que eventualmente no podemos tener ese poder absoluto, y es una fortuna no tenerlo. Quizás haya más probabilidad de "salvar" al paciente con el acompañamiento terapéutico o algunas formas no tan clásicas del Psicoanálisis.

Por otra parte, no olvidemos que en la clínica psicoanalítica no hay especializaciones, se escucha al otro, al que demanda la escucha. El psicoanalista no decide qué sí puede o no escuchar o a quién sí o a quién no. Dependerá del establecimiento de la transferencia, pero digamos que no tiene una tarjeta diciendo que solo escucha personas con depresión o con conflictos familiares o con ideación suicida. Escuchará lo que el analizante desee hablar, pero para que *eso* puede ser enunciado. Quizás encontraríamos en todo aquel que se dedica a escuchar que puede descubrir ideación suicida o un malestar profundo en cualquiera de sus pacientes.

La palabra seguirá siendo la herramienta con la que el Psicoanálisis pretende trabajar en la clínica. Ante las urgencias actuales donde no hay mucho sentido o palabra, porque hay más angustia o pánico, habrá que transitar a formas expresivas; la escritura es una de ellas, y se ha visto cómo ha servido a muchas personas, quizás no tanto como para evitar un suicidio que ya se ha pensado y decidido, pero sí para clarificar quizás. Así, encontramos a muchos que testimonian haber cambiado su decisión a partir de escribir, escribir la historia, sus historias. El Psicoanálisis no se ha quedado en el diván, ha buscado también otras estrategias, otras formas, donde se privilegia igualmente la palabra hablada o escrita, en lo individual o en lo grupal.[1]

Incitar a la palabra, al decir, en lugar de actuar, es la revolución planteada por el Psicoanálisis; darle la palabra al que no la tiene, sea porque ha decidido callar por resignación o porque ha sido obligado a hacerlo, por la cultura.

> Rebelión y revelación, dos condiciones para que haya análisis ya que el psicoanálisis es, desde sus orígenes, un pronunciamiento, en tanto su práctica de interrogar al goce es sublevación, rebelión, abandono de la indiferencia, un no desviar la mirada, ni caer en la fascinación del sacrificio. (Pipkin, 2023, p. 136)

[1] Véase Ortega y Pedroza (2018).

"¿Es posible desviar un destino trágico?", Dice Pipkin que, desde el Psicoanálisis: escuchando y sosteniendo el horror de la desesperanza, de la castración, del "no todo", del límite y del sin límite, del deseo, del goce, de la falta del sentido, producir una reescritura de lo que se piensa ya se instituyó en el destino.

Cuando asistí a algunos seminarios con la Dra. Martha Gerez, la escuchaba hablar de la culpa y del trabajo que ella realizaba con magistrados y jueces respecto al asunto de qué tan pertinente es atenuar las condenas, las sanciones a los criminales; desde su perspectiva, comentaba que era mucho mejor sancionar a un criminal que condonar su castigo, pues eso podía calmar al Superyó, podría un castigo externo detener el autocastigo que posiblemente le llevaba a cometer más crímenes. Sí, como ya lo dijera Freud. Este discurso me inspiró para hacer mi tesis de maestría sobre el sadismo superyoico, y ahora lo traigo acá, considerándolo dentro del trabajo de la clínica psicoanalítica, donde busca que el sujeto se percate de su falta —no en el sentido legal, sino en el marco del deseo—. Para algunos psicoanalistas, esto significa que se haga responsable, no desculpabilizar, quizás sí aminorar su angustia —no de manera directa o intencionada—, pero no quitar la culpa, pues justo es la culpa la que nos hace poder reconocer el deseo y sostiene el lazo social.

Es inevitable que cuando se habla de estrategias terapéuticas pensemos en las que tienen una mayor estructura y que sean esas las que funcionan más. Quizás puedan funcionar dado que el que se posiciona del lado del terapeuta percibe un mayor control o mayor conocimiento de lo que hace, cura desde su conocimiento y su técnica, eso puede disminuir la propia angustia, pues no es fácil escuchar a la otra persona cuando dice que quiere morir. Desde el Psicoanálisis, el analista no posee esa certeza o seguridad, y si puede manejar su angustia, será porque ya atravesó por el propio análisis, ya habrá lidiado con su propia ideación de muerte. También porque en el dispositivo analítico no está como persona, sino ocupando un lugar, ejerciendo una función. Claro, esto suena bien y hasta parece una leyenda lo que puede lograr un psicoanalista en su posición o función. Suena hasta como una especie de secreto que algunos, los "elegidos", pueden lograr: colocarse en el lugar de la abstinencia, del muerto, del Otro, o cómo veamos en la literatura al respecto. Daría para otro libro, incluso ahondar en la

transferencia como dispositivo analítico. Encontraríamos también muchas posturas, porque no hay un solo Psicoanálisis, sino tantos como autores.

En mis primeros encuentros con el psicoanálisis, un día hice una pregunta, creo que inocente y hasta tonta, al Dr. Braunstein, pues yo acababa de egresar de la Licenciatura en Psicología, con formación humanista, por lo que mis estudios estaban impregnados de la Filosofía Existencial, el Personalismo y el Humanismo de Rogers, Maslow Perls, pero también de algo de Psicoanálisis de Klein Rank, y un poco más de la Logoterapia de Frankl. Mi pregunta al Dr. Braunstein fue si era muy diferente el Psicoanálisis del Humanismo y en qué radicaba la diferencia, quería saber su punto de vista; no porque no lo hubiese estudiado ampliamente, pero en mi formación el Psicoanálisis, sobre todo el freudiano, era, digamos, *non grato,* así que su respuesta fue: "No hay más humanismo que el Psicoanálisis", explicando que el Psicoanálisis es quien reconoce la esencia del ser humano. Eso fue suficiente para que yo me adentrara en su estudio, sobre todo en Freud y en Lacan.

Aun así, pienso que podemos quedarnos en la pura teoría o críticas acerca del Psicoanálisis y pensar en todas sus fallas que, como cualquier escuela *psi*, tendrá. Pero ya en la práctica, en lo cotidiano, tendríamos que cuestionarnos cómo es que escuchamos al otro, cómo escuchamos a quien habla de su desolación y de su querer morir. Imposible no tratar de decirle que puede querer otra cosa, instar a su deseo de algo más, imposible no conmoverse o condolerse; y posicionarnos en un lugar de poder, pensando que quizás solo quiere atención, y entonces juga un poco con eso. ¿Qué hacer con los sentimientos de culpa si un analizante se suicida? Se trata de haber transitado por la comprensión de que fallaremos, de que también estamos atravesados por la falta, la incertidumbre.

No se trata de no ser sensibles a lo que nos dicen o de que no nos afecte lo que dice el otro, se trata de comprender que la persona está ahí para ser escuchada y no juzgada, ni sobreprotegida, ni desechada. Creo que solo se aprende la forma de escuchar de haberlo vivido; no hay un recetario de qué si decir o qué no, porque cada caso es distinto. Particularmente, agradezco a todas las personas con quienes he llevado un proceso terapéutico o analítico, porque he podido vivirlo y después, siempre en segundo tiempo, saber si fue la mejor forma o cuál no lo fue.

Lo cierto es que a veces se critica la ortodoxia. Bueno, es conocida por ejemplo, la crítica que realizara Ferenczi a Freud, siendo su discípulo y paciente; podríamos leer su historia, pero, para mi sorpresa, colegas muy apreciados me han hablado de las enseñanzas de Ferenczi sobre la forma de escuchar. Siempre creí que tenía que ver con su mala experiencia con Freud, una transferencia muy particular —como lo son todas—, pero lo que me parece importante es que, esté yo de acuerdo o no, su enseñanza aporta a colegas y les hace ver una clínica de determinada forma, que resulta adecuada para algunos de sus pacientes. Entonces, quiere decir que no hay La Clínica correcta, sino la escucha que pueda hacer surgir al sujeto del inconsciente, del deseo; y con ello, transitarlo. La prioridad la tiene el caso, el sujeto.

Ciertamente el Psicoanálisis no se especializa en tipos de personas, pero no desconoce las vicisitudes de algunas circunstancias que pueden agravar los padecimientos subjetivos. Por supuesto que en la clínica nos encontraremos siempre con obstáculos, de la sociedad, de las instituciones, de los colegas, de las familias de los analizantes e incluso la resistencia del propio analizante, la compulsión a la repetición, sus creencias. "Los budistas ven en el apego a la felicidad y en la aversión al dolor las causas del propio dolor. Pero también existe lo contrario: una aversión a la felicidad y un apego al dolor" (Bouchoux, 2018, p. 69).

Lacan hablaba incluso *del triunfo de la religión*, que tiene que ver con esa dependencia del ser humano que le otorga al Otro, a esa gran Otro, la responsabilidad de lo que le acontece, es decir, le permite evitar sentirse responsable de sus elecciones de vida, pues todo tiene un sentido de acuerdo con la voluntad de ese ser omnipotente. Freud también lo dice respecto a la religión, que se le otorga el poder de ser una cosmovisión; se puede confiar en una idea así o creencia justo por el carácter infantil por el que los padres son vistos por el niño con esos super poderes. Pero no solo pasa con la religión, es decir, como Freud lo pensó, la religión aprovecha esta dependencia del ser humano. Como habíamos visto anteriormente, sobre nuestra forma de llegar a la vida, en la que tenemos forzosamente que ser cuidados por el otro, eso nos deja una marca imborrable. Así, habrá quienes aprovechan esto y, como vemos en la relación amo-esclavo, el esclavo le otorga ese poder al Otro; entonces, eso resulta también conveniente, porque puedo ceder mi

toma de decisión al Otro, y ya no tengo que cuestionarme por mi deseo. Todo es porque una voluntad más grande que la mía así lo decidió, el destino, el signo zodiacal, la medicina, el psiquiatra, el psicólogo… en fin, lo que aparentemente nos libere de tomar decisiones, aunque en realidad es una condena a vivir sometidos, sujetados al deseo del Otro.

Se cree que, por estas elaboraciones en torno a la religión, el Psicoanálisis está en contra, pero no se trata de eso. En realidad, es señalar la dependencia del sujeto que lo lleva a caer en no hacerse cargo de su deseo, sino depositarlo en el Otro. Sin embargo, esa misma cualidad de confiar, de creer y depender le puede servir de garante. Es por eso mismo que puede establecerse la transferencia, que es indispensable para el proceso analítico. Pero no se trata de transitar de un padre a un dios para llegar al analista, sino que habrá que atravesar ese camino desde la creencia-confianza hasta el saber, de la sabiduría que lo lleve a darse cuenta de su deseo, así como de la castración propia y del otro. "El proceso psicoanalítico encuentra ese saber sobre la verdad que cada paciente posee, pero del que nada sabe, precisamente, por el miedo a comprometerse con algo de la naturaleza de esa verdad" (Tappan, 2021, p. 36).

Ciertamente no somos responsables de lo vivido en la infancia, pero sí lo somos en la vida adulta de la interpretación que damos a lo acontecido; Si no, todo sería producto del contexto y las circunstancias. Aún así, la propia interpretación de ese contexto y circunstancias es asunto de la persona, lo que llamamos la realidad psíquica. En eso coincide más el Psicoanálisis con el budismo moderno. Aún en la adolescencia tenemos esa oportunidad de reinterpretar lo acontecido, de ahí el asunto del trauma infantil en segundo tiempo. "Comprender que el dolor puede ayudarnos en el camino hacia el despertar hará que vivamos las experiencias dolorosas de forma distinta" (Bouchoux, 2018, p. 90). Sin embargo, no hay que olvidar que el saber del Sujeto, el del inconsciente, el que compete al Psicoanálisis, es uno no sabido. ¿Por qué el sujeto elabora de esa manera y no de otra su realidad psíquica? ¿Había que simplemente hacer "pruebas de realidad", como lo plantean algunas psicologías? Si esta realidad psíquica proviene de una elaboración o reelaboración, como los sueños, nunca encontramos el sueño como tal; ese es inapalabrable, así lo es la "realidad psíquica". Entonces incluso podemos llegar a reconocer, entender, aceptar nuestras "querencias",

pero el deseo (que es del Otro) permanecerá inaccesible. La evidencia de ello son todas las formaciones del inconsciente, pero sí podemos sabernos en falta, es decir, deseantes.

El camino hacia el saber con el que se encuentra el analizante no tiene que ver con la razón o la lógica, sino con aquellas verdades producidas por la *mostración* (concepto de Wittgenstein) y no la demostración positivista de verificar si lo que dice es cierto para todos. Entonces, el papel del analista es estar atento (de manera flotante) para escuchar cuando esos momentos de mostración para el analizante se dan en su discurso. "La verdad en Psicoanálisis siempre se encuentra articulada, fue verdad y solo concierne a quien analiza; de esa verdad, el analista no sabe nada, él es un soporte que permite, facilita o dificulta que se produzca" (Tappan, 2021, p. 156).

Para el que va a análisis, se le escuchará con respeto y se le instará a que se pueda encontrarse ahí donde se escucha desconocido para él mismo, de lo que ha elaborado como su realidad. Por supuesto, sin caer en el absurdo. No le puedo decir a una persona que vive en la pobreza o que vive injusticia social o que le han despedido por ser homosexual o indígena que todo eso es una interpretación suya y muy particular de la realidad, pero sí se le puede acompañar a que vea cómo acomoda todo eso que vive; cuántas opciones tiene, cuáles son, hasta donde puede andar y, sobre todo, qué desea:

> A esto Lacan lo designa como "destitución subjetiva", que no posee relación alguna con la castración de nadie, sino, por un lado, con la caída del "sujeto del lugar del saber" y, por el otro, con el establecimiento de la inexistencia de un saber autojustificado plentamente… (Eidelsztein, 2024, p. 124)

Esto implica que estemos advertidos de la incertidumbre, de que el sujeto está en falta, pero también el Otro, eso que significa que no hay un Otro del Otro.

Para terminar

He mencionado, a lo largo del texto, a algunos artistas que se suicidaron; también me he encontrado con una herramienta que algunos han usado como la posibilidad de permanecer con vida: la escritura, como lo trabaja Marisa Belausteguigoitia Rius cuando habla de las escritoras feministas de *This bridge called my back,* donde un grupo de mujeres se hacen ver y escuchar a partir de reconocer sus historias de sufrir la discriminación, el racismo y el desprecio de una sociedad estadounidense. O lo que narra Serge André en su novela *Flac*, cuya escritura le hace permanecer menos enfermo. Otro de los autores que he citado es Álvarez, quien también testifica que la escritura, después de padecer de ideación suicida, lo ha salvado. Y así quizás encontraríamos muchas historias. Aunque también existen las otras historias, en las que la escritura fue insuficiente o, mejor dicho, la obra de los autores se convirtió en una larga carta de despedida y quizás explicación, justificación, de lo que harían. Podemos encontrar incluso textos donde se analizan como casos clínicos. Despiertan interés, por supuesto.

Así, quedan estos grandes personajes para los que la escritura no tuvo la función de mantenerlos con vida, sino para decirnos por qué ya no. Ahí están Primo Levy, Hans Mayer (Jean Améry) —escritores acerca del suicidio, sobrevivientes al Holocausto—, Virginia Wolf, Alejandra Pizarnik, Hemingway, Sylvia Plath, Kurt Kobain, Yasunari Kawabata, Yukio Mishima, por las razones que fueran, el propio Freud, Lacan, Marx y un largo etcétera.

Nos duele saber cuánto sufrieron y nos dejaron una herencia en la escritura magnífica, que nos puede llevar un poco a comprender su decisión.

Me es imposible no pensar en algo muy personal. Estando en un hospital, cansada, agotada de estar sintiéndome mal y después de dos cirugías, recuerdo que me decían que tenía que vivir por mi hijo, que era en ese entonces pequeño. Tenía casi un mes sin verlo, y yo solo quería descansar, no podía dormir ni comer. Cuando escuchaba eso, primero, como si yo pudiese de pronto por voluntad dejar de estar enferma y que mi organismo funcionara a la perfección, era un poco molesto. Segundo, ¿cómo dejarle la responsabilidad de mi vida a mi hijo? Pensaba que era demasiada carga para él, la persona que más amo en la vida, no por eso tenía que echar encima de él algo tan grande como decidir vivir. Ahora que aparentemente era mi decisión, también pensaba —porque tenía mucho tiempo para hacerlo— que de poco le podía servir a mi hijo una madre así de enferma o con padecimientos graves de por vida. Al final, creo que lo que me ayudó a pasar del "debes" o "tienes" que vivir al "quiero vivir" fue el reflejo de toda la gente que se esforzó en el "querer" que yo viviera, aunque surgiera de su deber, como la doctora que me atendió y que aún sigo consultando, como mi madre cuidándome, mi padre acompañando, mis hermanos, mis amigas-hermanas-hijas, mis amigos, toda la gente que supe que hizo oración por mí, que me donó sangre y que estuvo al tanto. Yo tuve ese gran privilegio. Es decir, estuvieron a mi lado "otros" mostrando ese querer la vida, salvando un poco de la búsqueda del deseo del Otro en la que se puede salir perdiendo. Lo mío tuvo remedio, en el sentido de la enfermedad física, pero también en el querer.

No sé si la vida tenga sentido, lo veremos al final de cada quien a través de la mirada del otro que vive; creo que lo vamos construyendo por fuerza en colectivo, nunca en soledad. Así que cualquier intervención respetuosa, amable compasiva puede funcionar.

Lo cierto es que, ante el dolor de existir, ¿qué lo mitiga? Por más pequeños que sean los sujetos que lo piensan, que lo intentan, muchos dicen que es la poca tolerancia a la frustración, la inmediatez de la búsqueda de la satisfacción; lo que sí podemos decir es que nunca un suicidio es igual al otro… No podemos hablar de "el suicidio", sino de suicidios; al intentar explicarlos, razonarlos, siempre se escapará algo. Sin importar la edad o la causa, lo que podemos afirmar es que nosotros requerimos de la mirada de Otro que nos sostiene, nos mira, nos contempla; somos deseados. Da sen-

tido a nuestras vidas; de lo contrario, no habría transferencia ni vida. Esa mirada nos promete que estamos en el centro de la caridad, la mirada benevolente. Con el suicidio se consigue volver a estar en esa mirada, convertirse en un ser sagrado, resto despreciable y fascinante al mismo tiempo. El suicida busca restaurar esa benevolencia caída (Ritvo, 2021, p. 75). No es un acto, es acción extrema, escandaloso para volver a ser mirado, ser hablado, ser deseado.

Así como Bartra menciona que los grupos sociales en decadencia buscan su autodestrucción yendo a revoluciones, guerras en las que les han prometido la restauración de algo que les parece honorable, su democracia, su libertad, su nación o lo que sea, sabiendo que podrían morir con el fin de que nazca algo mejor, es lo que plantea la Dra. Vanda cuando habla de la *apoptosis*, en la que las células se sacrifican para el desarrollo del organismo. La idea de morir para vivir.

No pretendo ser especialista en suicidio, eso se lo dejo a los "suicidólogos", necesarios para la época, para la sociedad actual, solo quiero compartir lo que he estudiado, experimentado, para que quizás le sirva a alguien, sea del lado del que escucha o del que quisiera ser escuchado. Sobre todo, pensar que no es algo tan extraño el tener ideación suicida, no tiene que ver con enfermedad mental, con algo que está dañado, sino como eso que pasa por nuestros pensamientos en momentos de desesperanza, de desconsuelo, de profunda tristeza o incluso de rabia ante las injusticias, ante el dolor de los demás.

Por el que se dedica a escuchar o por situaciones de vida, está en el lugar de escuchar, que pueda sostener esa escucha sin prejuicios, sin la intención de ser un salvador, sino con la suficiente sabiduría y compasión para acompañar al otro, sabiduría que proviene de haber saboreado la castración, la falta, la propia ideación suicida o el pensar sobre la propia muerte.

Del lado del que ha pensado en el suicidio, de su suicidio, que sepa que hay interés genuino por acompañar, por escuchar, desde múltiples lugares. No hay una forma ideal de atender a quienes están sufriendo ideación suicida, pero el hecho de saber que pueden recurrir a alguien y buscar es el gran paso para ser ayudado. En Psicoanálisis, cuestionar la dirección de la cura nos recuerda que esta tiene que ver con instar al sujeto a seguir deseando… hablar.

Ya vimos que hay casos prevenibles y otros que no. Estrategias y herramientas hay muchas, casi por cada caso se puede crear una. La escucha psicoanalítica es una entre mil; para mi gusto personal, es la que puede acompañar con mayor cuestionamiento y sin juicios ni imposiciones del "deber" ser o el "deber hacer".

La escucha psicoanalítica no busca el ajuste, la adaptación, que comprendas lo que pasa y lo sobrelleves, que respondas a las demandas del otro; por el contrario, insta a buscar el deseo, el desear. Desde esa mirada, es una disciplina revolucionaria. No busca someter al sujeto, sino liberarlo y que reconozca su deseo, que se mueva a desear estar mejor, a buscar esa forma de vivir que le llene de satisfacción, no total, siempre parcial. Que no se quede quieto, porque la quietud está del lado de la pulsión de muerte; la muerte, esa llegará, pero que nos encuentre deseando y viviendo. Al fin, la causa de toda muerte es la vida misma.

Que todos los seres sean felices,
que todos los seres se liberen del sufrimiento,
que nadie sea desposeído de su felicidad,
que todos los seres logren ecuanimidad, libres de odio y de apego
Gueshe Kelsang Gyatso

Referencias

Álvarez, A. (1999). *El dios salvaje: Un estudio del suicidio.* Norma.

Álvarez del Río, A. (2021). No todos los suicidios son iguales. En A. Kraus (Coord.), *Suicidio* (pp. 67-82). Penguin Random House.

Améry, J. (1999). *Levantar la mano sobre uno mismo: Discurso sobre la muerte voluntaria.* Pre-textos.

Ariés, P. (1992). *El hombre ante la muerte.* Taurus.

Asociación Internacional de Prevención del Suicidio (s/f). *World Suicide Prevention Day*. https://www.iasp.info/wspd/

Assoun, P.-L. (2003). *Lecciones psicoanalíticas sobre la angustia.* Nueva Visión.

Assoun, P.-L. (2005). *Lecciones psicoanalíticas sobre el masoquismo.* Nueva Visión.

Bartra, R. (2021). Suicidio y decadencia: Reflexiones durkheimianas. En A. Kraus (Coord.), *Suicidio* (pp. 199-208). Penguin Random House.

Belausteguigoitia R., M. (2021). El suicidio desde las perspectivas de género e intersecciones. En A. Kraus (Coord.), *Suicidio* (pp. 101-122). Penguin Random House.

Bello, A. (2003). *Ficciones sobre la muerte*. La Mano.

Bernstein, R. J. (1991). *Perfiles filosóficos*. Siglo XXI.

Bouchoux, J. C. (2018). *Por los caminos de Buda y Freud.* Arpa y Alfil.

Camus, A. (2005). *El mito de Sísifo*. Losada.

Cobain, K. (2006). *Diarios*. Reservoir.

De la Boétie, E. (1980). *La servidumbre voluntaria*. Tusquets.

De Victoria, F. (1994). *Adolescencia del verbo adolecer*. Contraste Gráfico.

Deleuze, G. (2001). *Presentación de Sacher-Masoch: Lo frío y lo cruel.* Amorrortu.

Durkheim, E. (1994). *El suicidio*. Coyoacán.

Eidelsztein, A. (1999). *Análisis parcial del concepto de pulsión* (clase 2). http://www.edupsi.com/pulsion

Eidelsztein, A. (2008). *Estructuras clínicas a partir de Lacan, 2: Neurosis, histeria, obsesión, fobia, fetichismo y perversiones.* Letra Viva.

Eidelsztein, A. (2024). *Elementos para el psicoanálisis, 1: Materiales.* Letra Viva.

Ferreyra, N. (2012). El suicidio ¿cuándo? En N. Ferreyra, H. González, C. Pineiro y J. B. Ritvo (Eds.), *El enigma del suicidio: Psicoanálisis en lectura* (pp. 9-38). Letra Viva.

Freud, S. (1895/1999). Proyecto de psicología. En *Obras completas* (vol. 1). Amorrortu.

Freud, S. (1901/1998). Psicopatología de la vida cotidiana. En *Obras completas* (vol. 6). Amorrortu.

Freud, S. (1905/1999). Tres ensayos de teoría sexual. En *Obras completas* (vol. 7). Amorrortu.

Freud, S. (1910/1998). Escritos breves: Contribuciones para un debate sobre el suicidio. En *Obras completas* (vol. 9). Amorrortu.

Freud, S. (1911/1999). Puntualizaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (Dementia paranoides) descrito autobiográficamente. En *Obras completas* (vol. 12). Amorrortu.

Freud, S. (1914/1999). Introducción del narcisismo. En *Obras completas* (vol. 14). Amorrortu.

Freud, S. (1915a/1999). Pulsiones y destinos de pulsión. En *Obras completas* (vol. 14). Amorrortu.

Freud, S. (1915b/1999). La represión. En *Obras completas* (vol. 14). Amorrortu.

Freud, S. (1915c/1999). Lo inconsciente. En *Obras completas* (vol. 14). Amorrortu.

Freud, S. (1917/1998). Duelo y melancolía. En *Obras completas* (vol. 14). Amorrortu.

Freud, S. (1919/1999). "Pegan a un niño". Contribución al conocimiento de la génesis de las perversiones sexuales. En *Obras completas* (vol. 17). Amorrortu.

Freud, S. (1920/1998). Más allá del principio de placer. En *Obras completas* (vol. 18). Amorrortu.

Freud, S. (1923/1999). El yo y el ello. En *Obras completas* (vol. 19). Amorrortu.

Freud, S. (1928/1999). Dostoievski y el parricidio. En *Obras completas* (vol. 21). Amorrortu.

Freud, S. (1930/1999). El malestar en la cultura. En *Obras completas* (vol. 21). Amorrortu.

Freud, S. (1933/1999). 32ª conferencia: Angustia y vida pulsional. En *Obras completas* (vol. 22). Amorrortu.

Foucault, M. (1992). *El orden del discurso*. Tusquets.

García R., S. (2021). El derecho y la vida: ¿Morir en paz? En A. Kraus (Coord.), *Suicidio* (pp. 227-248). Penguin Random House.

Gerber, D. (2007). *Discurso y verdad: Psicoanálisis, saber, creación: El Horla: Angustia, locura, suicidio*. Escuela Libre de Psicología.

Geshe Kelsang Gyatso and New Kadampa Tradition (2013). *Oraciones para meditar.* Tharpa.

Goethe, J. W. (1774/2001). *Werther*. Edimat.

Graue W., E. (2021). Algunas reflexiones sobre el suicidio. En A. Kraus (Coord.), *Suicidio* (pp. 21-34). Penguin Random House.

Green, A. (1998). Pulsión de muerte, narcisismo negativo, función desobjetalizante. En A. Green y D. Widlöcher (Dirs.), *La pulsión de muerte* (pp. 65-78). Amorrortu.

Habermas, J. (1989). *El discurso filosófico de la modernidad*. Taurus.

Herrera G., R. (2004). De la mirada médica a la escucha psicoanalítica. *Devenires,* (10), 91-114. https://publicaciones.umich.mx/revistas/devenires/ojs/article/view/613

Hume, D. (2002). *Del suicidio*. Océano.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2001). *ABC de las estadísticas de intentos de suicidio y suicidios*. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/1334/702825431815/702825431815.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). *Estadísticas a propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio* (Comunicado de prensa núm. 503/22). https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_SUICIDIOS22.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (s/f). *Salud*. https://www.inegi.org.mx/temas/salud/

Jankélévitch, V. (2004). *Pensar la muerte*. Fondo de Cultura Económica.

Kang, H. (2025). *La vegetariana*. Penguin Random House.

Kawabata, Y. y Mishima, Y. (2005). *Correspondencia (1945-1970)*. Emecé.

Korinfeld, D. y Levy, D. (2024). *Autolesiones y situaciones de suicidio en adolescentes: Una perspectiva clínica ampliada: Herramientas para intervenir desde las instituciones.* Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico.

Kraus, A. (Coord.) (2021). *Suicidio.* Penguin Random House.

Kundera, M. (2002). *La ignorancia*. Tusquets.

Lacan, J. (1938). *La familia* [CD-ROM]. Infobase.

Lacan, J. (1958a). *Seminario 5: Las formaciones del inconsciente, clase 14: Sur le balcon de Genet* [CD-ROM]. Infobase.

Lacan, J. (1958b). *Seminario 5: Las formaciones del inconsciente, clase 17* [CD-ROM]. Infobase.

Lacan, J. (1958c). *Seminario 5: Las formaciones del inconsciente, clase 26* [CD-ROM]. Infobase.

Lacan, J. (1959a). *Seminario 7: La ética del psicoanálisis, clase 3: Una relectura del Entwurf* [CD-ROM]. Infobase.

Lacan, J. (1959b). *Seminario 7: La ética del psicoanálisis, clase 4: Das Ding* [CD-ROM]. Infobase.

Lacan, J. (1959c). *Seminario 7: La ética del psicoanálisis, clase 6: De la ley moral* [CD-ROM]. Infobase.

Lacan, J. (1960/1998). Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. En *Escritos 2* (19ª ed.). Siglo XXI.

Lacan, J. (1960a). *Seminario 7: La ética del psicoanálisis, clase 7: Las pulsiones y los señuelos* [CD-ROM]. Infobase.

Lacan, J. (1960b). *Seminario 7: La ética del psicoanálisis, clase 8: El objeto y la cosa* [CD-ROM]. Infobase.

Lacan, J. (1960c). *Seminario 7: La ética del psicoanálisis, clase 15: El goce de la transgresión* [CD-ROM]. Infobase.

Lacan, J. (1960d). *Seminario 7: La ética del psicoanálisis, clase 16: La pulsión de muerte* [CD-ROM] Infobase.

Lacan, J. (1960e). *Seminario 7: La ética del psicoanálisis, clase 18: La función de lo bello* [CD-ROM]. Infobase.

Lacan, J. (1960f). *Seminario 7: La ética del psicoanálisis, clase 23: Las metas morales del psicoanálisis* [CD-ROM]. Infobase.
Lacan, J. (1963). *Seminario 10: La angustia, clase 25* [CD-ROM]. Infobase.
Lacan, J. (1964a). *Seminario 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, clase 12: La sexualidad en los desfiladeros del significante* [CD-ROM]. Infobase.
Lacan, J. (1964b). *Seminario 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, clase 14: La pulsión parcial y su circuito* [CD-ROM]. Infobase.
Lacan, J. (1964c). *Seminario 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, clase 16: El sujeto y el otro (I): La alienación* [CD-ROM]. Infobase.
Lacan, J. (1964d). *Seminario 11. Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, clase 17: El sujeto y el otro (II): La afanisis* [CD-ROM]. Infobase
Lacan, J. (1964e). *Seminario 11: Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, clase 18: Del sujeto al que se supone saber, de la primera diada, y del bien* [CD-ROM]. Infobase.
Lacan, J. (1967). *Seminario 14: La lógica del fantasma, clase 21* [CD-ROM]. Infobase.
Lacan, J. (1969a). *Seminario 16: Del uno al otro, clase 14* [CD-ROM]. Infobase.
Lacan, J. (1969b). *Seminario 17: El reverso del psicoanálisis, clase 1: Producción de los cuatro discursos* [CD-ROM]. Infobase.
Lacan, J. (1970a). *Seminario 17: El reverso del psicoanálisis, clase 7. Edipo, Moisés y el padre de la horda*. Paidós.
Lacan, J. (1970b). *Radiofonía y televisión* [CD-ROM]. Infobase.
Lacan, J. (1971). *Seminario 19: O peor, clase 1* [CD-ROM]. Infobase.
Lacan, J. (1973a). *Seminario 20: Aún, clase 2. A Jakobson* [CD-ROM]. Infobase.
Lacan, J. (1973b). *Seminario 20: Aún, clase 5. Aristóteles y Freud: La otra satisfacción* [CD-ROM]. Infobase.
Lacan, J. (1976). *Seminario 23: El síntoma, clase 9. Pedazos-de-real* [CD-ROM]. Infobase.
Laplanche, J. (1998). La pulsión de muerte en la teoría de la pulsión sexual. En A. Green y D. Widlöcher (Dirs.), *La pulsión de muerte* (pp. 15-34). Amorrortu.
Laplanche, J. (2001). *Vida y muerte en psicoanálisis*. Amorrortu.
Leclaire, S. (1999). *Matan a un niño: Ensayo sobre el narcisismo primario y la pulsión de muerte*. Amorrortu.
Levinas, E. (1998). *Dios, la muerte y el tiempo*. Cátedra.
Linares S., J. E. (2021). Una aproximación al suicidio en la tradición filosófica. En A. Kraus (Coord.), *Suicidio* (pp. 287-304). Penguin Random House.
Lobo, F. (2007). *Relato del suicida*. Almadía.
Marx, K. (1846/2012). *Acerca del suicidio*. Las Cuarenta.
Masotta, O. (1990). *El modelo pulsional*. Argonauta.
Matos M., E. (2021). El suicidio divino, el suicidio humano: Historia y literatura. En A. Kraus (Coord.), *Suicidio* (pp. 261-270). Penguin Random House.
Medina-Mora, M. E. y López, A. (2021). No había otra manera: Las vicisitudes en torno al suicidio y su manejo. En A. Kraus (Coord.), *Suicidio* (pp. 181-198). Penguin Random House.
Morales, H. y Gerber D. (Comps.) (1998). *Las suplencias del nombre del padre*. Siglo XXI.

Morin, E. (1999). *El hombre y la muerte*. Kairós.

Organización Mundial de la Salud. (2019). *Cada 40 segundos se suicida una persona*. https://www.who.int/es/news/item/09-09-2019-suicide-one-person-dies-every-40-seconds

Organización Mundial de la Salud. (2025). *Suicidio*. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide

Organización Mundial de la Salud. (s/f). *Suicidio: Resultados de búsqueda*. https://www.who.int/es/home/search-results?indexCatalogue=genericsearchindex1&searchQuery=suicidio&wordsMode=AnyWord

Orozco, M. (2007). *La soberanía del acto: Un estudio introductorio a la noción de crimen en Freud.* Amapsi.

Ortega Martínez, M. C. (2013). ¿Hacia dónde van las psicoterapias hoy? En *Construyendo una psicología comprometida con América Latina.* Asociación Latinoamericana para la Formación y Enseñanza de la Psicología.

Ortega Martínez, M. C. (2014). *Introducción al sadismo superyoico.* Fontamara.

Ortega Martínez, M. C. y Pedroza F., H. (2018). *Más allá del diván (El psicoanálisis hoy)*. Fontamara.

Ortega-Martínez, M. C., Pérez Castillo, P. y Nieves-Chaves, M. A. (2025). Suicide seen from clinical psychology with a psychoanalytic orientation. *Journal of Philosophy and Daily Life, 11*(27), 1-17, e11127117. https://doi.org/10.35429/JPDL.2025.11.27.1.1.17

Pacheco, L. E. (2021). Cabra de dos cabezas. En A. Kraus (Coord.), *Suicidio* (pp. 249-260). Penguin Random House.

Paz, O. (2003). *Xavier Villaurrutia en persona y en obra*. Fondo de Cultura Económica.

Pereña, F. (2001). *La pulsión y la culpa: Para una clínica del vínculo social.* Síntesis.

Pipkin, M. (2023*). En el fin del sentido: Una lectura psicoanalítica del suicidio.* Lugar.

Pizarnik, A. (2005). *Diarios*. Lumen.

Pizarnik, A. (s/f). *Hija del viento*. http://amediavoz.com/pizarnik.htm

Rabinovich, D. S. (2003). *Una clínica de la pulsión: Las impulsiones.* Manantial.

Ramírez-Bermúdez, J. (2021). Historias (clínicas) del fin del mundo. En A. Kraus (Coord.), *Suicidio* (pp. 161-180). Penguin Random House.

Rendón, E. (2021). El suicidio en la era digital. En A. Kraus (Coord.), *Suicidio* (pp. 131-160). Penguin Random House.

Ritvo, J. B. (2012). El llamado al suicidio. En N. Ferreyra, H. González, C. Piñeiro y J. B. Ritvo (Eds.), *El enigma del suicidio: Psicoanálisis en lectura* (pp. 73-100). Letra Viva.

Salame K., L. (2021). Suicidio en médicos. En A. Kraus (Coord.), *Suicidio* (pp. 271-286). Penguin Random House.

Santillán, C. (2023). Nuevos modelos breves para atender emergencias psicológicas. En L. L. Eguiluz y C. Santillán (Coords.), *Pensamiento suicida: Pautas de intervención clínica con niños y adolescentes* (pp. 121-134). Terracota.

Santillán, C. y Eguiluz, L. L. (2023). Guardianes para la prevención del suicidio. En L. L. Eguiluz y C. Santillán (Coords.), *Pensamiento suicida: Pautas de intervención clínica con niños y adolescentes* (pp. 135-148). Terracota.

Savater, F. (1995). *Diccionario filosófico*. Planeta.

Schopenhauer, A. (1999). *Sobre el dolor del mundo, el suicidio y la voluntad de vivir.* Tecnos.

Segal, H. (1998). Mesa redonda. En A. Green y D. Widlöcher (Dirs.), *La pulsión de muerte* (pp. 103-127). Amorrortu.

Société psychanalytique de Vienne (1978). *Les premiers psychanalystes: Minutes de la Société Psychanalytique de Vienne* (tomo 2) [sesión del 20 de abril de 1910]. Gallimard.

Suárez O., J. O. (2023). El trabajo clínico con jóvenes que piensan en el suicidio. En L. L. Eguiluz y C. Santillán (Coords.), *Pensamiento suicida: Pautas de intervención clínica con niños y adolescentes* (pp. 47-78). Terracota.

Szasz, T. (2002). *Libertad fatal: Ética y política del suicidio.* Paidós.

Tappan, J. E. (2021). *Una introducción epistemológica al psicoanálisis: Mirada al psicoanálisis y a la construcción de su conocimiento.* Casa Alef.

Trías, E. (1981). *El lenguaje del perdón: Un ensayo sobre Hegel.* Anagrama.

Valadez Luna, L. A. y Ortega Martínez, M. C. (2019). Actitud en bachilleratos ante el suicidio de adolescentes en San Juan del Río, Querétaro. *Integración Académica en Psicología*, *7*(20), 46-52. https://integracion-academica.org/anteriores/30-volumen-7-numero-20-2019/237-actitud-en-bachilleratos-ante-el-suicidio-de-adolescentes-en-san-juan-del-rio-queretaro

Vallejos, S. (2003). *Virginia Woolf: La voz propia*. Longseller.

Vanda C., B. (2021). ¿Los animales también se suicidan? En A. Kraus (Coord.), *Suicidio* (pp. 209-226). Penguin Random House.

Vargas, D. (2020). *El suicidio como acto y sus paradojas.* Letra Viva.

Villaurrutia, X. (1998). Nocturno mar. *Citas y poesías.* http://www.avantel.net/~eoropesa/html/poesia/xvillaurrutia1.html

Volpi, J. (2001). *A pesar del oscuro silencio*. Seix Barral.

Woldenberg, J. (2021). Suicidios. En A. Kraus (Coord.), *Suicidio* (pp. 83-100). Penguin Random House.

Sobre la autora

María Cristina Ortega Martínez

Doctora en Psicología y Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro; Maestra en Estudios Psicoanalíticos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; Licenciada en Psicología por la Universidad del Valle de Guadiana; Diplomada en Teoría Psicoanalítica, Violencia Intrafamiliar, Estudios de Género, Teología, y Asesoría y Orientación Educativa. Profesora-investigadora de tiempo completo en la Facultad de Psicología y Educación, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Candidata SNII 2015-2019. Colaboradora con LaTe (Lapsus de Toledo) de España. Colaboradora de GAPE (Grupo Alteridade Psicanálise e Educação), de la Universidad Federal Fluminense, de Brasil. Miembro de REPPSIGE (Red de Estudios Psicoanalíticos, Psicosociales y de Género). Líder del cuerpo académico consolidado Psicoanálisis, Clínica y Sociedad. Perfil Prodep. Líneas de investigación: argumentaciones e intervenciones clínicas, principalmente psicoanálisis, además de evaluación psicológica. Sus publicaciones más recientes son el artículo en coautoría "El suicidio visto desde la psicología clínica con orientación psicoanalítica" (2025); el capítulo en coautoría "Transcendendo paradigmas: Afetividade freireana na pandemia e após" (en el libro *Distopia e clínica do social,* 2024); el libro en coautoría *Más allá del diván: El psicoanálisis hoy* (2018), y el libro *Introducción al sadismo superyoico* (2014).

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6188-4677
Google Académico: https://scholar.google.com.mx/citations?hl=es&view_op=list
Academia: https://aracelicolin.academia.edu/MaríaCristinaOrtegaMartínez

Estudios sobre la idea de muerte y los suicidios. De las psicologías al psicoanálisis,
de María Cristina Ortega Martínez, publicado
por Ediciones Comunicación Científica, S. A. de C.
V., se terminó en agosto de 2026 en versión digital para
acceso abierto en los formatos PDF, ePub y HTML. El cuidado
de la edición estuvo a cargo de Sebastián Gómez Zaldívar.

Este texto aborda diversas perspectivas sobre la muerte a lo largo de la historia, así como las consideraciones relativas al suicidio, desde su concepción como pecado en la religión, crimen y hecho social, hasta su consideración como problema de salud mental derivado de algún trastorno. También se aborda la prevención y, especialmente, el tratamiento de quienes sufren ideación suicida o han intentado suicidarse a partir de algunas propuestas terapéuticas de diversas psicologías. Partiendo de la premisa de que habrá suicidios prevenibles y otros no —como demuestran las estadísticas—, se plantea la posibilidad de reflexionar sobre el suicidio desde una perspectiva psicoanalítica para que el lector pueda considerar si ofrece una alternativa útil. Estas palabras sirven para comprender que la cuestión del suicidio, de la muerte misma, no es exclusiva de la locura o de algún trastorno mental, sino que es común en la medida en que somos sujetos atravesados por la finitud y la intuición de lo infinito.



María Cristina Ortega Martínez es Doctora en Psicología y Educación, Maestra en Estudios Psicoanalíticos y Licenciada en Psicología. Es profesora-investigadora miembro del cuerpo académico Psicoanálisis, Clínica y Sociedad, y es autora de los libros *Introducción al sadismo superyoico* y *Más allá del diván (el psicoanálisis hoy)*.

EBSCO

RENIECYT 2000922

Google Scholar

Dialnet

turnitin

OPEN ACCESS

doi

DOI.ORG/10.52501/CC.457

ISBN-13: 978-968-9803-33-1

9 789689 803331

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

EDICIONES COMUNICACIÓN CIENTÍFICA PUBLICACIONES ARBITRADAS

comunicacion-cientifica.com